

Examen UEI 1 : 2^{ème} Année Rattrapage/ 2025**Q1/ Le thorax :**

1. Le processus xiphoïde représente la partie inférieure du sternum
 2. Le rachis dorsal présente une courbure concave en arrière
 3. Les fosses côtes sont au nombre de 3
 4. Le grand dentelé est un muscle de la paroi postéro-latérale
- A (1,4) B (3,4) C (2,3) D (1,3) E (4,5)

Q2/ Le cœur :

1. La base est antérieure et droite
 2. Le segment atrial de la face diaphragmatique est étroit
 3. La paroi latérale de l'atrium droit est marquée par les muscles pectinés
 4. Le ventricule gauche présente trois faces
- A (1,4) B (3,4) C (2,3) D (1,3) E (4,5)

Q3/ Les vaisseaux et les nerfs du cœur :

1. L'artère circonflexe passe au-dessous de l'auricule gauche
 2. L'artère coronaire gauche irrigue les 2/3 antérieurs de la cloison inter ventriculaire
 3. Le sinus coronaire présente la valvule de Vieussens a sa terminaison
 4. Les centres du parasympathique cardiaque sont les noyaux du nerf vague
 5. Le plexus cardiaque supérieur donne les nerfs atriaux
- A (2,3,4) B(1,2,4) C(1,2,5) D(1,4,5) E(2,3,5)

Q4/ Le système artériel :

1. Le segment ascendant de la croise aortique est oblique en haut et à gauche
 2. L'œsophage est situé en avant de l'aorte thoracique en bas
 3. Le tronc artériel brachio-céphalique se divise en arrière sous-clavière gauche et commune gauche
 4. Le tronc pulmonaire est place à gauche de l'aorte
- A (2,4) B (3,4) C (2,3) D (1,4) E (1,2)

Q5/ La trachée :

1. Fait suite au larynx au bord inferieur du cartilage cricoïde
 2. La trachée thoracique occupe le médiastin antérieur
 3. La membrane fibro-elastique forme en arrière la lame transverse
 4. Les artères proviennent des artères thyroïdiennes supérieures
- A (1,3) B (3,4) C (2,3) D (1,4) E (4,5)

Q6/ Le diaphragme :

1. La coupole gauche est plus élevée que la droite
 2. Le hiatus œsophagien est traverse par l'œsophage et les nerfs vagues
 3. Est irrigue par les 5 premières artères intercostales
 4. Son innervation motrice est assurée par les nerfs phréniques
- A(1,2) B(2,3) C(2,4) D(1,3) E(3,4)

Q7/

1. Les trois régions du médiastin communiquent entre elles au-dessous des pédicules pulmonaires.
2. Les veines brachio-céphaliques (bc) au nombre de deux droite et gauche.
3. Chaque veine (bc) est formée par l'union de la veine jugulaire interne, la veine subclavière
4. La veine cave inférieure naît en regard de L3.
5. Le réseau lymphatique est présent surtout dans le système nerveux central et les tissus non vascularisés

A (1,2,4) B(3,4) C(2,3,1) D(1,3) E(2,3,5)

Q8/

1. Le canal thoracique est au contact de la face postérieure de l'œsophage dans l'étape inférieure du médiastin.
2. La coupe de t3 montre le passage de la crosse aortique.
3. L'empreinte de la veine azygos est située au-dessus du hile droit.
4. Le lobule pulmonaire est l'unité fonctionnelle respiratoire.
5. Les 2 nerfs phréniques descendent sur les bords latéraux de l'œsophage thoracique.

A (3,4) B(1,3,4) C(2,3,4) D(1,3) E(2,3,5)

Q9/

1. L'articulation ary-comiculée est une symphyse unie par un fibro- cartilage
2. Les muscles de la corde vocale sont le thyro-aryténoïdiens et cricothyroïdiens.
3. La cavité laryngée est représentée à sa partie supérieure par les ventricules et la glotte.
4. Le nerf laryngé supérieur innerve tous les muscles du larynx.
5. Le cricoaryténoïdien latéral n'est visible que sur la vue postérieure.

A (1,4) B(1,3,4) C(2,3,4) D(1,2) E(2,3,5)

Partie 2 : Histologie**Q10- L'ébauche cardiaque apparaît initialement :**

- A. En arrière de la membrane cloacale, dans le mésoblaste paraxial
- B. En avant de la membrane pharyngienne, dans le mésoblaste splanchnopleural
- C. Dans le pédicule embryonnaire, en position intra-embryonnaire définitive
- D. Dans le mésoderme intermédiaire, au contact du nephrotome
- E. Dans l'aire chorale, sous le trophoblaste

Q11-La couche musculo-élastique de l'endocarde est située :

- A. Directement en contact avec le sang circulant
- B. En continuité directe avec le myocarde contractile
- C. Absente au niveau des oreillettes
- D. Entre la couche sous-endothéliale et la couche sous-endocardique
- E. Identique à la média des artères élastiques

Q12-Les cellules de Clara se trouvent principalement :

- A. Dans les grosses bronches
- B. Dans les bronchioles
- C. Dans les alvéoles pulmonaires
- D. Dans la trachée
- E. Dans la plèvre viscérale

Q13- Les disques intercalaires des cardiomyocytes permettent :

- A. La cohésion et la conduction électrique
- B. La sécrétion de collagène
- C. L'adhésion au péricarde
- D. Le stockage du calcium
- E. La formation de valvules

Q14- Le retour veineux est facilité par :

- A. Le péricarde viscéral
- B. Les valvules veineuses
- C. La media riche en fibres élastiques
- D. Le squelette fibreux du cœur
- E. La circulation lymphatique

Q15- La zone paracorticale du ganglion lymphatique contient principalement :

- A. Lymphocytes B
- B. Lymphocytes T
- C. Plasmocytes
- D. Cellules dendritiques folliculaires
- E. Macrophages sinusaux

Q16- La circulation ouverte splénique correspond à :

- A. Des artérioles s'ouvrant directement dans les sinus veineux
- B. Des capillaires déversant leur contenu dans la pulpe rouge avant de rejoindre les sinus
- C. Un réseau ferme sans contact avec le parenchyme
- D. Une dérivation lymphatique de la circulation sanguine
- E. Une communication directe entre artères et veines

Q17- Les vraies cordes vocales sont recouvertes par :

- A. Un épithélium pseudo-stratifié cilié
- B. Un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé
- C. Un épithélium cylindrique simple cilié
- D. Un épithélium malpighien kératinisé
- E. Un épithélium cubique simple

Partie 3 : Physiologie**18. La régulation du débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique (VES). Quelle affirmation est correcte ?**

- A. Le system nerveux sympathique ralentit la fréquence cardiaque (effet chronotrope négatif).
- B. Une augmentation de la fréquence cardiaque diminue le débit cardiaque.
- C. Plus la contractilité est forte, plus le VES diminue.
- D. Une augmentation de la précharge augmente le débit cardiaque en augmentant le VES.
- E. Une augmentation de la postcharge augmente le débit cardiaque.

19. Concernant la régulation du débit sanguin coronaire (DSC), quelle affirmation est correcte ?

- A. L'autorégulation dépend du système nerveux autonome.
- B. Le DSC reste inchangé lors des variations de la fréquence cardiaque.
- C. Une pression de perfusion > 140 mmHg entraîne une vasodilatation coronaire.
- D. Une pression de perfusion < 70 mmHg entraîne une vasoconstriction coronaire.
- E. Le DSC s'adapte aux besoins en oxygène du myocarde tant que la pression de perfusion est comprise entre 70 et 140 mmHg.

20. À l'ECG, quelle affirmation est correcte ?

- A. Le complexe QRS correspond à la repolarisation des ventricules.
- B. L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes.
- C. L'espace PR correspond à la dépolarisation et repolarisation des ventricules.
- D. L'onde T correspond à la repolarisation des oreillettes.
- E. L'onde T correspond à la dépolarisation des ventricules.

21. À propos de la courbe AV/AP (compliance) du poumon, de la paroi thoracique et de l'ensemble thoraco-pulmonaire, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Dans la courbe de la paroi thoracique, à 69 % de la capacité vitale (CV), la paroi est à son volume d'équilibre
- B. À bas volume, l'ensemble thoraco-pulmonaire tend à diminuer le volume.
- C. À haut volume pulmonaire, le poumon exerce une pression de rétraction élastique.
- D. À haut volume pulmonaire, la paroi thoracique exerce une pression de distension élastique pour se gonfler.
- E. À haut volume pulmonaire, l'ensemble thoraco-pulmonaire tend à augmenter le volume.

22. La coagulation plasmatique transforme :

- A. La thrombine en prothrombine
- B. La fibrine en fibrinogène
- C. Le fibrinogène en fibrine
- D. Le calcium en facteur XII
- E. La plasmine en plasminogène

23. L'enzyme responsable de la fibrinolyse est :

- A. La thrombine
- B. La plasmine
- C. La trypsine
- D. La prothrombinase
- E. La sérine protéase

24. Concernant le transport des gaz dans le sang, l'effet Haldane est un processus qui :

- A. décrit un état de diminution de l'affinité Hb-CO₂
- B. est secondaire à une forte baisse de la PaO₂
- C. dévie la courbe de Barcroft vers la droite
- D. limite l'élimination du CO₂
- E. se produit au niveau des tissus périphériques

25. Concernant l'état d'hypoxie, laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- A. il correspond à une baisse importante de la PCO₂
- B. il entraîne une diminution du débit ventilatoire
- C. il est détecté uniquement par les chémorécepteurs centraux (CRC)
- D. sa régulation est très rapide mais peu sensible
- E. aucune proposition n'est juste

26. La gazométrie est un examen : (RF)

- A. effectué sur un prélèvement artériel
- B. permettant l'étude de l'hématose
- C. évaluant la fonction acido-basique
- D. définissant l'insuffisance respiratoire chronique
- E. mesurant la partie combinée des gaz

Partie 4 : Biophysique**27- Quelle est la condition pour que le débit d'un fluide incompressible soit constant dans deux sections différentes ?**

- A. $D = S v = S_1 V_1$
- B. $D = S v + S_3 V_1$
- C. $D = S / v = S_1 / V_1$
- D. $D = S + S_1$
- E. Toutes les propositions sont justes

28- Que représente le coefficient de proportionnalité y dans l'équation de la loi de Hooke ?

- A. Force par unité de longueur
- B. Élasticité de l'objet
- C. Variation de la longueur
- D. Longueur initiale de l'objet
- E. Toutes les propositions sont justes

29- Comment modéliser la paroi d'un vaisseau sanguin ?

- A. En tant que structure rigide
- B. Comme une membrane élastique semi-rigide
- C. Comme une fine membrane élastique
- D. Comme un tube flexible
- E. Toutes les propositions sont justes

30- A quoi s'oppose la tension superficielle dans un vaisseau sanguin ?

- A. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du vaisseau sanguin
- B. Le flux sanguin dans le vaisseau
- C. L'expansion du rayon du vaisseau
- D. La contraction des parois du vaisseau
- E. Toutes les propositions sont justes

Examen UEI 2 : 2^{ème} Année Rattrapage/ 2025**Anatomie : Cocher la réponse juste pour toutes les questions****Q1/ Le pharynx :**

1. A la forme d'une gouttière verticale ouverte en arrière
2. Le cavum représente l'étage supérieur
3. Le fascia intra-pharyngien tapisse la face superficielle des muscles du pharynx
4. Est irriguée par l'arrière palatine ascendante

{A}{1,4} {B}{1,3} {C}{1,2} {D}{2,4} {E}{2,3} \]

Q2/ Le duodénum et le pancréas :

1. Le duodénum est sus et sous-mesocolique
2. La tête du pancréas est effilée
3. Le pancréas est parcouru par 4 canaux excréteurs
4. Le bloc duodeno-pancréatique répond au fascia de Treitz en arrière

{A}{1,4} {B}{1,3} {C}{2,2} {D}{2,4} {E}{2,3}

Q3/ Le jéjuno-iléon :

1. Le jéjunum est constitué par des anses allongées transversalement
2. Est fixé par le
3. Les artères jéjunales naissent du bord droit de l'arrière mésentérique supérieur
4. Le drainage veineux se fait dans la veine cave inférieure

{A}{1,4} {B}{1,3} {C}{1,2} {D}{2,4} {E}{2,3}

Q4/ Le rectum

1. Fait tirer au colon sigmoïde en regard de S3
2. Les plis permanents de l'ampoule rectale sont verticaux
3. Le rectum pelvien est divisé par le péritoine en 2 segments
4. Les artères rectales supérieures naissent des arbres hypogastriques

{A}{1,2} {B}{2,3} {C}{3,4} {D}{2,4} {E}{1,3} \]

Q5/ La rate :

1. Est située au niveau de l'épigastre
2. Est entièrement pigmentée
3. Sa face diaphragmatique répond à la plèvre et poumon gauche
4. Son extrémité supérieure répond à l'angle colique gauche

{A}{1,2} {B}{2,3} {C}{3,4} {D}{2,4} {E}{1,3}

Q6

1. L'œsophage cervical s'étend donc de C6 à T2,
2. Les rapports antérieurs de l'œsophage se font par la trachée et le nerf récurrent droit.
3. Dans l'étage sus-azygo-aortique l'œsophage répond à gauche au conduit thoracique, l'arbre sous-clavière gauche.
4. Dans l'étage moyen et en dorsal l'œsophage ne répond à aucun élément sauf au plan prévertébral

{A}{1,4} {B}{1,3,4} {C}{2,3,4} {D}{1,3} {E}{2,3}

Q7/

1. Le feuillet pariétal du péritoine, doublé par le fascia transversalis, sauf dans la région lombaire.
2. Pars condensa par ou passe l'arbre hépatique droite.
3. La bourse orientale répond en caudal, au bloc duodéno- pancréatique.
4. Un méso prend le nom de l'organe auquel les feuillets pariétal et viscéral se continuent l'un avec l'autre.
5. Grand omentum sa portion frontale, démarre au bord epiploïque et forme le ligament gastro-colique.

A (1,4) B(1,3,4) C(2,3,4) D(1,3) E(2,3)

Q8/

1. Le canal veineux d'Arantius qui, à l'état embryonnaire, réunit la veine porte à la veine cave inférieure et s'obthière à la naissance.
2. Le lobe carre est entre la gouttière de la veine cave inférieure et le sillon du ligament rond.
3. Les rapports de la face supérieure du foie répondent aux poumon et à la plèvre gauches.
4. La face dorsale du foie répond au pôle supérieur du rein droit et à la surrénale droite

A (2,4) B(1,3,4) C(2,3,4) D(1,3) E(1,4)

Q9/

1. Le secteur paramédian gauche comprend le segment II et le segment III.
2. Le segment V du foie postero-superieur et le segment VIII est antérieur.
3. Les trois veines sus-hépatiques cheminent dans les scissures portales.
4. Dans le segment hilaire les branches terminales de la veine porte occupent le plan postérieur.

A (1,4) B(1,3,4) C(3,4) D(1,3) E(2,3)

Q10/

1. En profondeur, la paroi antéro-latérale de l'abdomen s'étend jusqu'au péritoine pariétal inclus.
2. Le muscle oblique externe de l'abdomen est le plus profond et le plus étendu.
3. La gaine des droits, dans ses 2/3 supérieurs, sa paroi antérieure et sa paroi postérieure sont symétriques.
4. La ligne blanche est un raphé médian, fibreux xypho-pubien, formé par l'entrecroisement des fibres musculaires de la paroi antero-latérale de l'abdomen.

A (1,4) B(1,3) C(2,3,4) D(3,4) E(3,4)

HISTOLOGIE :**Q11- Concernant l'histophysiologie des glandes salivaires, quelles affirmations sont exactes?**

1. La glande parotide est une glande mixte à prédominance séreuse, responsable de la production de lysozyme.
2. Les acini séreux, prédominant dans la glande parotide, contiennent des cellules myoépithéliales qui facilitent l'expulsion de la salive riche en amylase.
3. Les croissants de Gianuzzi sont caractéristiques des acini mixtes et sont formes de cellules séreuses coiffant les cellules muqueuses.
4. La glande sublinguale est principalement muqueuse et sa salive, riche en mucines, joue un rôle essentiel dans la lubrification du bol alimentaire.
5. Les canaux intercalaires, par leurs échanges ioniques actifs, modifient la composition de la salive primaire.

A(1,2,3) B(1,3,4) C(3,4,5) D(1,4,5) E(2,3,4)

Q12- À propos de la muqueuse gastrique fundique, sélectionner les propositions justes:

1. Les cellules pariétales (bordantes) sont responsables de la sécrétion d'acide chlorhydrique et du facteur intrinsèque, essentiel à l'absorption de la vitamine B12.
2. Le pepsinogène, secrète par les cellules principales, est active en pepsine par l'acide chlorhydrique à un pH optimal supérieur à 6.
3. Les cellules à mucus à pôle apical fermé de l'épithélium de surface secrètent un mucus alcalin qui protège la muqueuse de l'acidité gastrique.
4. La vascularisation ascendante de la muqueuse fundique permet de charger le sang en ions bicarbonates issus des cellulaires pariétales, contribuant à la protection de l'épithélium.
5. Les cellules endocrines de type G (gastrine) sont les plus abondantes dans la muqueuse fundique et stimulent la motilité gastrique.

A(1,2) B(2,3) C(1,3,4) D(3,4,5) E(4,5)

Q13- Quelles sont les caractéristiques histologiques et fonctionnelles spécifiques de l'intestin grêle qui le distinguent des autres segments du tube digestif ?

1. La présence de villosités et de microvillosités (plateau strié) augmente considérablement la surface d'absorption.
2. Les glandes de Brünner, situées dans la sous-muqueuse du duodénum, secrètent un mucus acide pour initier la digestion des lipides.
3. Les cellules de Paneth, localisées au fond des cryptes de Lieberklühn, ont une fonction de défense immunitaire par la sécrétion de lysozyme.
4. Les plaques de Peyer sont des agrégats lymphoïdes caractéristiques du jéjunum, jouant un rôle dans la surveillance immunitaire.
5. Le muscle de Brucke, une extension de la musculaire dans l'axe des villosités, facilite le drainage de chylifère central par ses contractions.

A(1,2) B(3,4) C(4,5) D(1,3,5) E(1,2,3,4,5)

Q14- Concernant la muqueuse buccale, quelles affirmations sont exactes ?

1. L'épithélium de la gencive est kératinisé.
2. Le chorion est composé d'une couche superficielle papillaire et d'une couche profonde conjunctivoelastique.
3. Le tissu sous-muqueux est toujours présent et contient des glandes salivaires accessoires.
4. La muqueuse linguale est recouverte de papilles chez l'homme.
5. Les papilles filiformes sont les plus nombreuses et contiennent des bourgeons du goût.

A(1,2,4) B(3,4,5) C(2,3,4) D(2,4,5) E(1,2,3)

Q15- Quelles sont les fonctions principales des cellules bourdantes (pariétales) de l'estomac?

1. Sécrétion de pepsine pour la digestion des prodiges.
2. Production de mucus pour protéger la paroi gastrique.
3. Sécrétion d'acide chlorhydrique (HCl) pour l'acidification du contenu gastrique.
4. Production de facteur intrinsèque pour l'absorption de la vitamine

B12.

5. Sécrétion de gastrine pour stimuler la motilité gastrique.

A(1,3) B(3,4) C(2,4) D(1,5) E(2,5)

Q16- Quelles sont les caractéristiques des glandes de Brünner ?

1. Elles sont situées dans la sous-muqueuse du duodénum.
2. Elles sécrètent un mucus acide pour neutraliser le pH gastrique.
3. Elles sont des glandes tubuleuses ramifiées.
4. Elles sont présentes en grand nombre dans le jéjunum.
5. Elles contribuent à la protection de la muqueuse duodénale.

A(1,2,3) B(3,4,5) C(1,3,5) D(2,4,5) E(1,3,4)

Q17- Quelles sont les caractéristiques de la muqueuse colique ?

1. Elle présente des villosités intestinales.
2. Les glandes de Lieberklühn sont profondes et serrées.
3. Elle contient de très nombreuses cellules caliciformes.
4. La couche lymphoïde est représentée par des follicules clos du côlon.
5. Elle est de type épidermoïde.

A(1,2,3) B(2,3,4) C(3,4,5) D(1,2,3,4) E(2,3,4,5)

Q18- Dans le concept d'organisation lobulaire du foie, une proposition est fausse laquelle ?

- A. La branche de la veine porte se situe à la périphérie du lobule.
- B. Les espaces portes sont en périphérie du lobule.
- C. Le trajet de la bile produite par les hépatocytes s'effectue vers la périphérie du lobule.
- D. Le trajet du sang s'effectue de l'espace porte, vers la veine centrolobulaire.
- E. Les travées d'hépatocytes s'étendent entre la veine porte et l'arbre hépatique du lobule.

19- quelle vitamine est un antioxydant puissant liposoluble ?

A-vitC/

B-vit B1

C-vit K

D-vit E

E-vit B3

20- Quels sont les facteurs de la coagulation dépendants de la vitamine K?

A-I,II,III, IV

B-V, IIIV, X

C-II, VII, IX, X

D-VII, IX, XI, XIII

E-tous ces facteurs

21- quelle est la meilleure prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né ?

A- supplémentation en fer à la naissance

B- injection systématique de vitamine K a la naissance

C- supplémentation en vitamine D

D- administration de vit K par voie orale

E- les propositions B et D sont exactes

22- le transport du fer dans le sang est assure principalement par :

A- la ferritine

B- l'hémoglobine

C- la transferrine

D- le cytochrome C

E- l'hepcidine

23- une alimentation strictement végétarienne peut conduire à une carence en :

A-Manganèse

B-suivre

C-fer heminique

D-fluor

E- toutes ces propositions

24. À propos de la sécrétion gastrique laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

A/c'est la seconde des sécrétions acides digestives

B/elle est exclusivement hydro-électrolytique

C/elle est maximale en post-prandial

D/elle est très acide en post-absorptif

E/elle est inhibée par le stress

25. Concernant la vidange gastrique, quel type d'aliment est évacué le plus lentement :

A/les liquides

B/les glucides digestibles

C/les glucides non digestibles

D/les lipides

E/les protéines

26. L'emulsification des graisses est assurée par :

A/La lipase gastrique

B/Les sels biliaires

C/L'amylase pancréatique

D/La trypsine

E/Le sac intestinal

27. Le péristaltisme est défini comme :

- A/Des contractions permanentes
- B/Des contractions alternes propulsives
- C/Des mouvements de brassage colique uniquement
- D/Une relaxation sphinctérienne isolée
- E/Une sécrétion glandulaire rythme

28. L'absorption de la vitamine B12 nécessite :

- A/La bile
- B/L'acide chlorhydrique
- C/Le facteur intrinsèque
- D/La trypsine
- E/La sécrétine

29. L'enzyme responsable de l'activation des protéines pancréatiques est :

- A/La lipase pancréatique
- B/La trypsine
- C/L'entérokinase
- D/La papaïne
- E/La

30. Le rôle principal de la bile est :

- A/Hydrolyser les glucides
- B/Emulsifier les graisses
- C/Dégrader les protéines
- D/Neutraliser l'acidité gastrique
- E/Détruire les bactéries intestinales

Examen UEI 03 : 2^{ème} Année Rattrapage/ 2025**Partie 1 : Anatomie**

Cocher la réponse juste pour toutes les questions

Q1/ Les voies excrétrices de l'urine :

1. Le rein comporte trois petits calices t
2. La papille rénale est coiffée par le calice majeur
3. L'uretère est fixé par le péritoine pariétal postérieur
4. Les uretères sont vascularisés par les artères rénales

A(1,2) B(1,3) C(1,4) D(2,4) E(3,4)

Q2/ L'uretère lombaire répond :

1. Au muscle psoas iliaque en arrière
2. Au promontoire médialement
3. Au bord médial du rein latéralement
4. Au bord médial du rein médialement

A(1,2) B(1,3) C(1,4) D(2,3) E(2,4)

Q3/

- A. Les reins sont des glandes volumineuses situées à la partie basse de la région retro-péritonéale latérale.
- B. Les reins sont reliés aux gros vaisseaux uniquement par les artères rénales.
- C. Le sinus du rein est situé à l'extérieur du hile.
- D. Le rein gauche se projette entre le bord supérieur de Th 11 et la L3.
- E. Les rapports latéraux des reins répondent aux poumons.

Q4/

- A. La capsule fibreuse tapisse la face superficielle du rein.
- B. Les colonnes de Bertin sont situées entre les calices.
- C. Le labyrinthe contient est situé dans la substance médullaire.
- D. Le rein droit répond par son bord médial à l'aorte abdominale.
- E. Le rein gauche répond en avant à la tête du pancréas.

Q5/ A propos de l'urètre :

1. Les ostiums des conduits éjaculateurs s'ouvrent dans l'urètre prostatique.
2. L'urètre féminin est oblique en bas et en arrière
3. L'urètre spongieux est entouré par le corps spongieux.
4. La fosse naviculaire de l'urètre est une dilatation de l'urètre féminin.

A(1,2) B(1,3) C(1,4) D(2,4) E(3,4)

Partie 2 : Histologie

Q6- Concernant les fonctions endocrines du rein, quelles hormones sont libérées et quel est leur rôle principal ?

1. L'aldostérone, qui régule la réabsorption du sodium et de l'eau.
2. L'érythropoïétine, qui stimule la production d'érythrocytes par la moelle osseuse.
3. La rénine, qui joue un rôle crucial dans le contrôle de la pression sanguine/
4. L'hormone antidiurétique (ADH), qui augmente la perméabilité à l'eau des tubes collecteurs.
5. L'angiotensine II, qui est un puissant vasoconstricteur direct.

A(1,2) B(1,3) C(2,3) D(4,5) E(3,4)

Q7- La barrière de filtration glomérulaire est une structure complexe essentielle à la formation de l'urine. Quelles sont les affirmations exactes concernant ses composants et leur fonction ?

1. L'endothélium capillaire est de type fenêtré, permettant le passage de toutes les molécules, y compris les
2. La membrane basale du capillaire agit comme un ultrafiltre, retenant les protéines dont le poids moléculaire des cellules sanguines est supérieur à 68 KD.
3. Les podocytes, cellules épithéliales du feuillet viscéral de la capsule de Bowman, forment des fentes de filtration qui régulent le passage des substances.
4. Le passage de l'ultrafiltrat à travers cette barrière est un phénomène actif nécessitant de l'énergie.
5. L'ultrafiltrat glomérulaire est identique au plasma sanguin, y compris en termes de concentration en protéines de haut poids moléculaire.

A(1,2) B(2,3) C(3,4) D(4,5) E(2,5)

Q8- L'appareil juxta-glomérulaire joue un rôle majeur dans la régulation de la pression artérielle. Quels sont les éléments constitutifs de cet appareil et leurs rôles dans le système rénine-angiotensine-aldostérone ?

1. La macula densa, une portion différenciée du tube contourné proximal, détecte les variations de la concentration en sodium.
2. Les cellules granulaires de l'artériole afférente sécrètent la rénine en réponse à une baisse de la pression artérielle.
3. L'angiotensine I est directement convertie en angiotensine II par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) située principalement dans les poumons.
4. L'aldostérone, sécrétée sous l'influence de l'angiotensine II, favorise l'excrétion de sodium et d'eau au niveau du tube contourné distal.
5. Le lacs cellulo-conjonctif est une structure de soutien sans rôle fonctionnel direct dans la régulation de la pression.

A(1,2,3) B(2,3,4) C(3,4,5) D(2,3,5) E(1,3,4)

Q9- Le tube contourné proximal (TCP) est le site d'une réabsorption et d'une sécrétion importantes. Quelles sont les caractéristiques histophysiologiques du TCP ?

1. Il réabsorbe près de 70% de l'ultrafiltrat glomérulaire, y compris la quasi-totalité des acides aminés et des hydrates de carbone.
2. Sa portion Initiale, le segment droit de Schachowa, s'enfonce dans la pyramide de Malpighi.
3. Il est caractérisé par la présence d'une bordure en brosse (striée) et de bâtonnets basaux, augmentant sa surface d'échange.
4. La sécrétion d'ions H⁺ et d'ammoniac (NH₄⁺) est un phénomène négligeable à ce niveau.
5. La réabsorption de l'eau dans le TCP est Indépendante de la réabsorption des solutés.

A(1,2) B(2,3) C[3,4) D(4,5) E(1,3)

Q10-L'anse de Henlé est cruciale pour l'établissement du gradient osmotique médullaire. Quelles sont les propriétés de ses différentes portions ?

1. La portion grêle descendante est très perméable à l'eau, entraînant une concentration de l'urine.
2. La portion ascendante est imperméable à l'eau et réabsorbe activement le sodium, contribuant à la dilution de l'urine.
3. À la sortie de l'anse de Henlé, l'urine est hyper-osmotique par rapport au plasma.
4. La réabsorption de l'eau dans la portion descendante est un processus actif.
5. La portion descendante est également perméable aux ions chlorure, qui suivent le sodium.

A(1,2) B(2,3) C(3,4) D(4,5) E(1,5)

Q11-Concernant la vascularisation rénale, l'artère arciforme est une artère qui chemine

- A. Entre les pyramides de Malpighi
- B. Entre les pyramides de Ferrein
- C. A la base de la pyramide de Malpighi
- D. En sous capsulaire
- E. Entre les lobules rénaux

Q12- La paroi des voies urinaires présente des adaptations spécifiques à leur fonction de transport et de stockage de l'urine. Quelles sont les caractéristiques histologiques de ces parois ?

1. L'urothélium, ou épithélium de transition, est un épithélium pseudo-stratifié polymorphe dont les cellules superficielles sont souvent binucléées et imperméables à l'urine.
2. La musculature des voies urinaires est généralement composée de deux couches de muscle strié : une longitudinale interne et une circulaire externe.
3. Au niveau du tiers Inférieur de l'uretère, la musculature comporte trois couches de fibres musculaires lisses.
4. La vessie vide contient des cellules en raquettes dans son épithélium, et sa musculature est peu développée pour permettre une distension maximale.
5. Les uroplakines sont des protéines transmembranaires impliquées dans la perméabilité de la membrane cellulaire à l'eau.

A(1,2) B(1,3) C[1,4) D(2,5) E[2,4)

Partie 3 : Physiologie

13. Dans le système circulatoire rénal, une pression oncotique élevée caractérise :

- A/ les capillaires glomérulaires
- B/ les capillaires péri-tubulaires
- C/ les vasa-recta
- D/ les artères Interlobulaires
- E/ les artères interlobaires

14. La régulation extrinsèque du débit sanguin rénal :

- A/ est exclusivement hormonale
- B/ repose sur une vasoconstriction reflexe myogénique
- C/ réduit le débit sanguin cérébral en faveur du débit sanguin rénal
- D/ est efficace pour une pression systémique < 45mmHg
- E/ aucune proposition n'est Juste

15. Une clairance rénale de 30 ml/min correspond à un capital néphronique fonctionnel d'environ :

- A/ 75%
- B/ 60%
- C/ 50%
- D/ 25%
- E/ 10%

16. La filtration glomérulaire :

- A/ est la deuxième étape de la formation de l'urine
- B/ concerne 80% du flux plasmatique rénal
- C/ est un processus passif bidirectionnel
- D/ donne naissance à l'urine primitive
- E/ est nulle pour le glucose

17. L'osmolarité du liquide filtre atteint sa valeur maximale au niveau de :

- A/ la partie contournée du tube proximal
- B/ la partie droite du tube proximal
- C/ la pointe de l'anse de Henlé
- D/ la partie initiale du tube distal
- E/ la partie terminale du tube distal

18. La sécrétion passive au niveau du tube contourné proximal (TCP) concerne l'une des substances suivantes :

- A/ l'ammoniac (NH₃)
- B/ l'ammonium (NH₄⁺)
- C/ l'urée
- D/ le potassium (K⁺)
- E/ la choline

19. Lorsque la glycémie dépasse le seuil maximal de transfert rénal du glucose (T_m) :

- A/ la clairance du glucose est nulle.
- B/ le débit de réabsorption du glucose est constant.
- C/ le débit d'excrétion du glucose est égal au débit de filtration.
- D/ seuls les SGLT2 sont saturés
- E/ aucune proposition n'est juste

20. Pendant le remplissage vésical, la contraction du sphincter urétral interne est sous une commande :

- A/ sympathique a adrénérergique.
- B/ sympathique B adrénérergique.
- C/ parasympathique muscarinique.
- D/ parasympathique nicotinique.
- E/ non adrénérergique non cholinergique.

21. L'incontinence urinaire d'effort peut être secondaire à :

- A/ une toux chronique
- B/ des accouchements répétés
- C/ une constipation chronique
- D/ une obésité
- E/ toutes les propositions sont justes

Partie 4 : Biochimie

(QCM 22, 23 et 24) : Un patient a les résultats suivants : ph : 7,30

PaCO₂ : 60mmHg

HCO₃⁻ : 28mmol/l

Q-22 Quelle est la nature du déséquilibre acide-base ?

- A. acidose respiratoire non compensée
- B. acidose métabolique compensée
- C. acidose mite
- D. alcalose métabolique surcompensée
- E. alcalose respiratoire

Q-23 L'origine de ce déséquilibre peut être, cocher la proposition la plus exacte

- 1. Une hypoventilation
- 2. L'augmentation de la Pco₂
- 3. baisse des bicarbonates
- 4. une dépression du centre respiratoire

A1.2 B.2,3 C.2.4 D.3,4 E.1,2,4

Q-24 quelle cause peut être à l'origine de ce tableau ?

- A. Accident vasculaire cérébral
- B. Hypotension intracrânienne
- C. Aspiration d'un corps étranger
- D. Mucoviscidose
- E. Toutes ces propositions sont exactes

Q-25- Quel est le 1er mécanisme de défense immédiat contre une variation du pH sanguin ?

- A. compensation respiratoire
- B. compensation rénale
- C. systèmes tampons
- D. élimination rénale des acides
- E. ventilation pulmonaire

Q-26 un patient présente une acidose métabolique sévère avec lactates élevés Quelle est la cause la plus probable ?

- A. Vomissements prolonges
- B. Hypoxie tissulaire
- C. Hyperventilation
- D. Diarrhées profuses
- E. Aucune cause probable

Q-27 quelle est la valeur normale des bicarbonates sanguins en mmoles par litre ?

- A 18-24
- B. 20-26
- C. 22-26
- D. 20-28
- E. 22-30

Q-28 Cocher la proposition fausse parmi les suivantes.

- A. Les anions indosés sanguins sont plus importants que les cations indosés
- B. Les protéines plasmatiques représentent la fraction majoritaire des cations indosés
- C. Le trou anionique peut être calculé sans tenir compte de la kaliémie
- D. Le trou anionique doit être corrigé en cas d'hypoalbuminémie
- E. Le trou anionique est normal si l'acidose métabolique est accompagnée d'une réabsorption des chlorures

Q-29 Parmi les mécanismes suivants, lequel ne contribue pas directement à l'acidité titrable ?

- A. sécrétion d'H⁺ par les cellules tubulaires
- B. formation de NH₄⁺
- C. tamponnement par les ions phosphates
- D. excrétion des protons dans les tubules distaux
- E. es propositions B et D

Q-30 un patient a les constantes suivantes : Na⁺ : 140 mmol/l, d- : 105 mmol/l, HCO₃⁻ : 24 mmol/l

Quelle est la valeur du trou anionique ?

- A-9 mmol/l
- B-11 mmol/l
- C-12 mmol/l
- D-15 mmol/l
- E-16 mmol/l

Examen UEI 4 : 2^{ème} Année Rattrapage/ 2025**Partie 1 : anatomie****Cocher la réponse juste pour toutes les questions****Q1/L'appareil génital féminin :**

1. L'utérus est piriforme
2. Le ligament rond de l'utérus traverse le canal inguinal
3. L'ovaire est entièrement péritonisé
4. Le fundus représente l'extrémité supérieure du vagin

A(1,3) B (2,3) C(2,4) D(1,2), E(1,4)

Q2/

1. Le lobe antérieur formé de tissu nerveux et prend le nom d'adénohypophyse.
2. Les artères proviennent toutes de la carotide interne, elles sont au nombre de 3
3. L'artère surrénale supérieure droite naît de l'artère rénale droite.
4. L'artère surrénale supérieure naît de l'artère phrénique inférieure

A(1,4) B (1,3,4) C (2,3,4) D(1,3) E (2,4)

Q3/ Concernant la glande thyroïde:

1. Glande endocrine située dans la région infra-hyoïdienne entre les régions carotidiennes.
2. L'isthme émet un prolongement de son bord inférieur appelé la pyramide de la Louette.
3. Les pédicules vasculaires représentent les seuls moyens de fixité de la thyroïde.
4. L'artère laryngée inférieure est en rapport avec le pôle supérieur des lobes latéraux de la glande.
5. Aucune réponse n'est juste.

A(1,2) B (1-3) C(1-4) D(5) E(2,4)

Q4/ Concernant la glande thyroïde:

- A. Sa vascularisation est assurée uniquement par les artères thyroïdiennes supérieure et inférieure.
- B. L'artère thyroïdienne supérieure est une branche collatérale du tronc thyro-bicervico-scapulaire.
- C. L'artère thyroïdienne inférieure naît de la crosse de l'aorte et est présente de façon constante.
- D. Son drainage veineux se fait dans la veine jugulaire externe et le tronc veineux brachio-céphalique droit.
- E. Toutes les réponses sont fausses

Q5/ Quels muscles appartiennent au plan superficiel du périnée ?

1. Le muscle constricteur de la vulve.
2. Le sphincter externe de l'urètre.
3. Le sphincter externe de l'anus .
4. Le pubo-vaginal.
5. Aucune réponse n'est juste.

A (1-2) B(1-3) C(1-4) D(5) E(2-4)

Partis 2 : HISTOLOGIE :

O6- Concernant le développement embryologique de l'hypophyse. Quelles affirmations sont exactes ?

1. Le diverticule de Rathke est une évagination de nature ectoblastique qui donne naissance à la neurohypophyse.
2. Le processus infundibulaire est une évagination ectoblastique du stomodeum qui forme l'adénohypophyse
1. La persistance de vestiges du canal pharyngo-hypophyse peut être à l'origine d'un craniopharyngiome
4. Le lobe postérieur de l'hypophyse se développe à partir de la poche de Rathke.
5. L'adénohypophyse dérive de l'ectoblaste stomodéal.

A(1,2) B(2,3) C(3,4) D(4,5) E(3,5)

O7- Quelles sont les caractéristiques histologiques et fonctionnelles des systèmes magnocellulaire et parvocellulaire de l'hypothalamus ?

1. Le système magnocellulaire est composé de petites cellules dont les produits de sécrétion sont l'ocytocine et la vasopressine.
2. Les neurones du système parvocellulaire synthétisent des neuropeptides hypophysiotropes qui régulent l'adénohypophyse.
3. Les noyaux supra-optiques et paraventriculaires sont les sites de localisation des cytones du système parvocellulaire
4. Les produits de sécrétion du système magnocellulaire sont stockés dans la neurohypophyse avant d'être libérés.
5. Le système parvocellulaire est en relation directe avec la neurohypophyse.

A(1,3) B(2,4) C(1,4) D(2,5) E(3,5)

Q8- Concernant la glande thyroïde, quelles sont les affirmations correctes relatives à son développement et à sa structure ?

1. La thyroïde est d'origine mésoblastique et provient d'une ébauche médiane unique.
2. Le canal thyroéoglosse, qui relie l'ébauche thyroïdienne au pharynx, persiste à l'âge adulte.
3. Les cellules C ou parafolliculaires, responsables de la sécrétion de calcitonine, dérivent des crêtes neurales
4. La vésicule thyroïdienne est l'unité histologique de la glande, elle est formée de thyrocytes uniquement.
5. La thyroïde est la plus volumineuse des glandes endocrines pures et est très vascularisée.

A(1,3) B(2,4) C(1,4) D(2,5) E(3,5)

Q9- Quelles sont les fonctions et les régulations des différentes zones de la corticosurrénale?

1. La zone glomérulée sécrète les glucocorticoïdes, dont la sécrétion est contrôlée par l'ACTH adénohypophysaire.
2. La zone fasciculée est la plus épaisse et sécrète les minéralocorticoïdes, régulés par le système rénine- angiotensine.
3. La zone réticulée sécrète les androgènes et est sous la dépendance de l'ACTH hypophysaire.
4. Les cellules de la zone glomérulée participent à la régulation de la volémie en stimulant la réabsorption du sodium
5. La corticosurrénale a une structure trabéculaire non orientée, et a une sécrétion protéique.

A(1,3) B(3,4) C(1,4) D(2,5) E(3,5)

Q10- Concernant le pancréas endocrine, quelles sont les affirmations exactes sur les ilots de Langerhans et leurs sécrétions ?

1. Les cellules A des ilots de Langerhans secrètent l'insuline, une hormone hypoglycémiante.
2. La sécrétion de glucagon par les cellules A est stimulée par une baisse de la glycémie.
3. Les cellules B des ilots de Langerhans synthétisent le glucagon, qui agit principalement sur les cellules hépatiques
4. L'insuline facilite la pénétration du glucose dans les hépatocytes, les adipocytes et les cellules musculaires.
5. Les ilots de Langerhans sont des plages claires, rondes ou ovales, réparties dans la masse exocrine du pancréas.

A(2,5) B(2,4,5) C(1,4) D(2,5) E(1,2,5)

O11- Quelles sont les caractéristiques des follicules et leur évolution au cours du cycle menstruel ?

1. Le follicule primaire est caractérisé par un ovocyte I entouré d'une assise de cellules folliculeuses cubiques et ébauche de la zone pellucide.
2. Le follicule tertiaire (cavitaire) est de grande taille contient un antrum rempli de liquide folliculaire
3. La thèque interne du follicule secondaire produit directement des œstrogènes qui sont ensuite libérés dans la circulation.
4. Au moment de l'ovulation, l'ovocyte est libéré sous forme d'ovocyte I bloqué en prophase I.
5. Le corps jaune, formé après l'ovulation, sécrète principalement des estrogènes pour maintenir la grossesse

A(1,3) B(2,4) C(1,4) D(1,2) E(3,5)

O12- Concernant les glandes annexes aux voies génitales males, quelles sont les affirmations correctes sur leurs sécrétions et fonctions ?

1. Les vésicules séminales produisent un liquide clair, visqueux et alcalin, riche en fructose, qui constitue 70 à 80 % de l'éjaculat.
2. La prostate est une glande hormono-indépendante qui sécrète un liquide acide protégeant les spermatozoïdes et contrôlant la coagulation du sperme.
3. Les glandes bulbo-urétrales sont responsables de la majeure partie du volume du sperme et contiennent des spermatozoïdes matures.
4. La prostate est constituée de 2 à 3, tubes de 5 à 12 cm de long, baignant dans une atmosphère conjonctivo-élastique richement vascularisée
5. Les vésicules séminales et la prostate sont toutes deux androgéno-dépendantes.

A(1,3) B(2,4) C(1,4) D(2,5) E(1,5)

Partie 3 : PHYSIOLOGIE (cocher une seule proposition)**13. La sécrétion de l'hormone de croissance (GH) se caractérise par :**

- A/ Une libération continue et stable sur 24h
- B/ Une libération pulsatile, surtout pendant le sommeil
- C/ Une augmentation progressive avec l'âge
- D/ Une inhibition par la GH-RH hypothalamique
- E/ Une absence totale de régulation hypothalamique

14. Parmi les facteurs suivants, lequel stimule directement la sécrétion de GH ?

- A/ La somatostatine
- B/ L'IGF-I circulant
- C/ La ghréline
- D/ Le cortisol
- E/ L'insuline

15. L'action métabolique principale de la GH est :

- A/ Hypoglycémiant et lipogénique
- B/ Hyperglycémiant et lipolytique
- C/ Inhibitrice de la synthèse protéique
- D/ Identique à celle de l'insuline
- E/ Antagoniste de l'IGF-I

16. Une insuffisance endocrinienne secondaire est confirmée par :

- A/ un test à l'hormone négatif
- B/ un taux de stimuline élevé
- C/ un test à la stimuline négatif
- D/ un taux de RH bas
- E/ toutes les propositions sont fausses

17. Lequel des organes ou tissus suivants est insulino-dépendant ?

- A/ le globule rouge
- B/ le globule blanc
- C/ le cerveau
- D/ le muscle squelettique
- E/ le cœur

18. Concernant le métabolisme des lipoprotéines, la lipoprotéine lipase (LPL) intervient dans :

- A/ la voie endogène
- B/ la voie exogène
- C/ le transport inverse du cholestérol
- D/ les propositions A et B sont justes
- E/ toutes les propositions sont justes

19. La protéine Ras est : cocher la proposition exacte

- A- Une protéine kinase
- B- Une GTPase monomérique
- C- Une un récepteur transmembranaire
- D- Un récepteur canal ionique
- E- Un RCPG

20. Qu'est-ce qui permet à une cellule de répondre spécifiquement à une hormone

- A- La présence de nutriments
- B- L'équipement de la cellule cible
- C- La température ambiante
- D- La lumière ambiante
- E- La taille de la cellule

21. Parmi les facteurs suivants, lesquels freinent la sécrétion hypophysaire de la prolactine:

- 1- TRH
 - 2- Métoprolole
 - 3- Hormones thyroïdiennes
 - 4- Estrogènes
 - 5- Dopamine
- A=1+2 B=2+3 C=3+4 D= 3+5 E=1+2+3

22. Parmi les tests suivants, lequel est indiqué pour le diagnostic différentiel entre cryptorchidie et anorchidie chez l'enfant :

- A- Un dosage statique de la testostérone
- B- Un test de stimulation à la B-HCG.
- C- Un spermogramme,
- D- Un dosage de la FSH, LH,
- E. Un test de stimulation au Tamoxifène.

23. Parmi les propositions suivantes, cocher la proposition qui caractérise l'hypogonadisme masculin hypogonadotrope ?

- A- Le bilan sanguin montre un déficit en 5 alpha réductase
- B- L'enfant présente une gynécomastie
- C- Le patient présente une puberté précoce.
- D- Le bilan sanguin retrouve un taux élevé de FSH et de LH
- E- Le bilan sanguin retrouve un excès de sexe hormone binding globuline

24. Chez l'homme un taux bas d'inhibine-b est un témoin de :

- A- Azoospermie obstructive
- B- Une Azoospermie par éjaculation rétrograde dans les urines
- C- Hyper-androgénie
- D- Hyper-oestrogenie
- E- Insuffisance testiculaire

25. Quelle hormone est sécrétée selon un rythme long ?

- A- Progestérone
- B- Cortisol
- C- Insuline
- D- Adrénaline
- E- Testostérone

Examen UEI 5 : 2^{ème} Année Rattrapage/ 2025**Partie 1 : Anatomie****Cocher la réponse juste pour toutes les questions****1. A propos des méninges :**

- A. La dure-mère crânienne adhère fortement à la voute
- B. La dure-mère rachidienne descend dans le canal rachidien jusqu'à 54
- C. Les granulations de Pacchioni qui sont le lieu de résorption du LCR
- D. L'espace sous dural est l'espace entre la dure-mère et l'os
- E. L'espace extradural est l'espace entre la dure-mère et l'arachnoïde

2. A propos du cervelet :

- A Les pédoncules cérébelleux sont des formations anatomiques impaires
- B- le pédoncules cérébelleux unissent le cervelet à la face postérieure du tronc cérébral
- C Les pédoncules cérébelleux unissent le cervelet à la face antérieure du tronc cérébral
- D- L'archéocérébellum est relié aux noyaux dentelés
- E- L'archéocérébellum est relié aux noyaux embolus

3. La face postérieure de l'étage pontique du tronc cérébral :

- A Est marquée par le plancher du quatrième ventricule
- B. Est marquée par la présence de deux paires de colliculi
- C. Est marquée par l'émergence du nerf trijumeau
- D. Est marquée par l'émergence du nerf abducens
- E. Présente le sillon basilaire

4. A propos du nerf trijumeau (V):

- 1. Sa racine motrice est plus volumineuse que sa racine sensitive
 - 2. Sa racine sensitive est plus volumineuse que sa racine motrice
 - 3. Il correspond au nerf moteur de la face
 - 4. Il correspond au nerf sensitif de la face
 - 5. Il présente à la terminaison de son tronc un renflement nerveux : le ganglion géniculé
- A(1,3) B(1.4) C[2.4) D(2.5) E(3,5)

5. Le massif facial :

- A Le cornet nasal inférieur est un os impair
- B. L'os nasal a une forme triangulaire
- C. La face nasale du maxillaire est antérieure
- D. L'os zygomatique présente deux processus, frontal et temporal
- E. Le vomer forme la paroi antéro-intérieure du septum nasal

6. La morphologie de la moelle épinière

- 1 Le sillon antérieur est peu profond
 - 2 Les cordons sont au nombre de 3
 - 3 Le 4- nerf cervical est situé au-dessous de la 4^e vertèbre cervicale (C4)
 - 4 Le 10^e nerf thoracique est situé au-dessous de la 10^{ème} vertèbre thoracique (T10)
 - 5 Les artères spinales antérieures se réunissent pour former le tronc spinal antérieur
- A(L4 2.5 C2.4) D(4.5)

7/

- A Le 3- ventricule communique avec chaque ventricule latéral par l'aqueduc de Sylvius
- B. Le lobe frontal : situé en avant du sillon central, formé de 4 circonvolutions
- C Le trigone cérébral est une lame de substance grise située dans la concavité du corps calleux
- D. Les espaces compris entre les noyaux gris centraux sont appelés le centre ovale.
- E La paroi supérieure ou toit du 3e ventricule correspond en surface à l'espace inter-pédunculaire.

8/

- A. La structure de l'oreille externe est formée par une lame osseuse, des ligaments et des muscles.
- B. L'oreille moyenne est constituée de 03 parties : la caisse du tympan, l'antre mastoïdien, et la cochlée
- C La paroi supérieure ou crânienne de la caisse du tympan présente la région du golf de la jugulaire.
- D. Le muscle du marteau assourdi les bruits violents, innervé par une branche du nerf mandibulaire
- E. Le labyrinthe osseux est contenu dans l'écaille de l'os temporal

9/

- 1. Le système postérieur (vertébro basilaire) assure la vascularisation du tronc cérébral et du cervelet
 - 2. Parmi les branches collatérales des artères vertébrales on cite des rameaux perforants destinés au bulbe et au pont, l'artère cérébelleuse antéro-inférieure.
 - 3. Les artères cérébrales postérieures sont des branches terminales du tronc basilaire
 - 4 Les territoires artériels profond et superficiel du cerveau sont indépendants l'un de l'autre
 - 5. L'artère cérébrale antérieure chemine le long de la fissure latérale du cerveau.
- A (2,4,5) B(3,3,5} C (1,3,4) D(3,4,5) E(1,2.5)

Partie 2 : Histologie

10. Sur une coupe longitudinale d'un ganglion rachidien on peut reconnaître tous les constituants suivants sauf

- A- Une capsule conjonctivo élastique
- B- Des capsules péri-cellulaires, et des gaines enveloppant les fibres nerveuses
- C- Des amas cellulaires (des neurones et cellules névrogliales) occupant la zone périphérique corticale du ganglion
- D- Des fibres nerveuses occupant l'axe du ganglion
- E- Une partie centrale dilatée contenant des amas de cellules ganglionnaires, et de fibres nerveuses à disposition anarchique

11. Concernant le développement du système nerveux, cocher les propositions justes.

- A Le tube neural donnera le névraxe
- 8- Les crêtes neurales donneront le système nerveux périphérique.
- C. La partie crâniale du tube neural comporte trois vésicules à la fin du 2- mois du développement
- D- Le prosencéphale ne se divise pas, et donne le bulbe rachidien
- E- Les vésicules télencéphaliques donneront les futurs hémisphères cérébraux.

12. Concernant l'écorce cérébrale toutes ces propositions sont justes sauf t

- A- Est une structure plissée
- B- Est une structure de faible épaisseur
- C- Est une structure stratifiée comportant plusieurs couches cellulaires
- D- Son origine embryologique est neuro ectoblastique
- E- L'iscortex homotypique comporte 2 couches cellulaires

13. Parmi les fibres suivantes, lesquelles constituent la voie afférente du Cortex cérébelleux

- A Les fibres moussues
- B Les dendrites des cellules de Purkinje
- C- Les fibres grimpantes
- D- Les axones des cellules de Golgi
- E Les axones des cellules de Purkinje

14. Dans le glomérule cérébelleux de Held, font synapse tous ces éléments sauf :

- A Les ramifications terminales des fibres grimpantes
- B- Les ramifications terminales des fibres moussues
- C- in dendrites de cellules de Golgi de type II
- D- Les terminaisons axonales de cellules da Golgi de type II
- E- Les dendrites des grains du cervelet

13. L'organe de l'olfaction : (cochez la RJ)

- A- Est un organe des sens secondaire
- B C'est un organe des sens primaire où la cellule sensorielle principale est ganglionnaire
- C- La cellule olfactive assure le recueil de l'information et son transport jusqu'au système nerveux central
- D Les cellules à mucus de l'épithélium olfactif représentent les cellules sensorielles principales
- E- La cellule sensorielle principale est nerveuse

16. Concernant les couches de la rétine :

- A Les cellules de Muller vont des cellules névrogliales propre à la rétine visuelle
- 8 Les corps cellulaires des cellules bipolaires forment la couche plésiforme interne
- C La coche des cônes et des bâtonnets correspond aux prolongements dendritiques des cellules visuelles
- De La couche la plus externe est l'épithélium pigmentaire
- E- Les corps cellulaires des cellules visuelles forment la couche des grains internes

17. A propos de l'organe gustatif :

- A- Les cellules gustatives sont fusiformes, surmontées d'un bâtonnet gustatif.
- B C'est un organe des sens secondaire
- C Les cellules gustatives sont des cellules sensorielles principales
- D. Il comporte des cellules sensorielles qui sont des neurones
- E. il est formé par les bourgeons du goût situés au niveau des papilles linguales

Partie 3 : Physiologie

18. le reflexe myotatique inverse présente toutes ces caractéristiques, sauf :

- A) ses afférences sont des fibres de type Ib
- B) limite l'extension de la jambe sur la cuisse
- C) ses récepteur sont les fuseaux neuromusculaires
- D) Est un réflexe ...
- E) présence dans l'arc réflexe d'un interneurone inhibiteur du motoneurone a

19. Le tonus musculaire présente toutes ces propriétés et caractéristiques, sauf :

- A) est un état actif des muscles squelettiques, en dehors du sommeil
- B) est entretenu par activation synchrone et continue des unités motrices
- C) est sous la dépendance de l'encéphale
- D) repose sur la boucle gamma
- E) dans l'arc réflexe, les motoneurones gamma innervent les fibres extrafusales

20. Un des agents suivants est un désensibilisant des nocicepteurs :

- A) prostaglandines E2
- B) sérotonine
- C) histamine
- D)
- E) bradykinine

21. Le syndrome syringomyélique présente toutes ses caractéristiques, sauf :

- A) est un déficit sensitif
- B) est suspendu
- C) est péri-médullaire
- D) respecte la sensibilité proprioceptive
- E) respecte la sensibilité épicritique

22. Le faisceau ayant une influence sur les muscles ... et les extenseurs est :

- A) le faisceau rubro-spinal latéral
- b) le faisceau réticulo spinal antérieur
- C) le faisceau
- D) le faisceau cunéiforme
- E) le faisceau cortico bulbaire

23. Dans l'hypermétropie :

- A) le globe oculaire est trop loin
- B) la vision de près est floue
- C) il y a nécessité de port de verres divergents pour la vision de loin
- D) impossibilité d'accommodation pour la vision de loin
- E) aucune de ces propositions n'est juste

24. Un son en db grave quand :

- A) son amplitude est élevée
- B) son amplitude est basse
- C) sa fréquence est élevée
- D) sa fréquence est basse
- E) sa hauteur est grande

Partie 4: Biophysique (Cocher une seule proposition)**25- Indiquer la réponse fausse. La biophysique sensorielle :**

- A. s'intéresse principalement au recueil et la transduction du message physique
- B. Elle définit le message physique et précise ses caractéristiques
- C analyse les mécanismes de codage de l'information captée
- D présente les principales techniques d'exploration de la chaîne sensorielle
- E s'intéresse principalement à la transmission et l'interprétation du message physique

26- Indiquer la réponse fausse. Un son complexe :

- A Est un son comportant un seul harmonique
- C. Sa fréquence est égale à la fréquence du fondamental
- D. Est un son comportant un fondamental et des harmoniques.
- E. Est périodique

17- Indiquer la réponse fausse. L'onde sonore :

- A Peut se propager dans le vide
- B Est une onde élastique
- C. Se propage de proche en proche dans un milieu matériel
- D. Sa vitesse de propagation dépend du milieu de propagation
- E Elle est caractérisée par sa fréquence et sa longueur d'onde

28- Indiquer la réponse fausse. Un son pur:

- A n'est pas sinusoïdal
- B est un son comportant un seul harmonique
- C. est caractérisé par sa tonie (HAUTEUR)
- D. est caractérisé par sa sonie (INTENSITE)
- E est caractérisé par son timbre

29- Indiquer la réponse fausse. En audition objective :

- A Le phone qualifie la sensation de sonie
- B L'échelle des phones se définit par rapport à un son pur de 1000Hz
- C 0 phone est le seuil liminaire (le minimum audible)
- D. Les courbes phonationnelles sont parallèles entre elles
- E. Le timbre correspond au spectre des fréquences et de leurs amplitudes

30- indiquez la réponse fausse. Dans les dyschromatopsies:

- A. La protanopie est l'absence de cônes L qui codent pour le rouge
- B. Le deutéranopie est l'absence de cônes M qui codent pour le vert
- C. Le tritanopie est l'absence de cônes S qui codent pour le bleu
- D. Les dichromates arrivent à voir deux couleurs parmi les trois couleurs primaires
- E. Un trichromate n'a aucune vision colorée et son acuité visuelle est altérée

Examen UEI 2 : 3^{ème} Année Rattrapage/ 2025

1) Quels sont les anomalies retrouvées à l'examen de la marche d'un parkinsonien? Cochez la réponse juste

- a) Une démarche à petits pas,
 - b) Freezing et Festination
 - c) Un élargissement du polygone de sustentation
 - d) Une attitude fléchie en avant
 - e) Une démarche fauchante
- A (a+b+e), B (a+b+d), C (a+e) D (a+c+e), E (d+e).

2) Lequel des éléments suivants est en faveur d'une maladie de Parkinson idiopathique ? Cocher la réponse juste(RJ).

- A. En présence d'une atteinte strictement symétrique
- B. Devant une amélioration nette sous traitement dopaminergique
- C. En absence de tremblement de repos
- D. Une cause iatrogénique identifiable
- E. Aucune de ses réponses n'est juste.

3) Un patient est considéré en état d'inconscience totale (coma profond) lorsque le score de Glashow est égale à

- A. 7
- B. 5
- C. 3
- D. 1
- E. 0

4) Dans la segmentation anatomique fonctionnelle du cervelet partie centrale est responsable de :

- A. les mouvements volontaires
- B. la verticalisation et la station debout
- C. La marche
- D. la proprioception
- E. les réflexes vestibulaires

5) Le syndrome de Brown Sequard se caractérise par : Cocher la réponse juste (RJ)

- a) Un syndrome cordonal postérieur homolatéral à la lésion
 - b) Des troubles de la sensibilité tactile du cote de la lésion
 - c) Des troubles de la sensibilité thermo algique du cote controlatéral à la lésion
 - d) Un syndrome pyramidal controlatéral à la lésion
 - e) Un syndrome cérébelleux controlatéral à la lésion
- A (a+b+c) B (d+c+e) C (b+c+d) D (a+c+e) E (a+d+e)

6) Le reflexe bicipital : Cocher la réponse juste (RJ)

- A. Dépend de la racine C4-C5
- B. Dépend de la racine C5-C6
- C. Sa réponse est une flexion de l'avant-bras
- D. B et C justes
- E. A et C justes

7) Le reflexe cutanéoplantaire est : Cocher la réponse fausse (RF)

- A. Est un réflexe ostéotendineux du membre inférieur.
- B. Se fait en effleurant la plante du pied à l'aide d'un instrument moussu
- C. Se traduit par une flexion plantaire des orteils
- D. Peut-être indifférent des deux côtes sans signification
- E. Le Babinski est son expression pathologique v

8) Les pathologies à évoquer devant une douleur d'horaire inflammatoire sont : Cochez la réponse juste

- A. Une arthrose
- B. Une polyarthrite rhumatoïde
- C. Une entorse
- D. Une infection ostéoarticulaire
- E. Une tumeur osseuse

9) La vésicule: cochez la réponse fausse (RF)

- A. Est visible et palpable.
- B. Sa surface est en relief.
- C. Sa taille est supérieure à 5 mm de diamètre.
- D. Sa forme est hémisphérique.
- E. Son contenu peut être purulent en cas de surinfection.

10) La tuméfaction d'une articulation est liée a une anomalie de plusieurs structures lesquelles? Cochez la ou les réponse (s) juste (s).

- A. Hypertrophie synoviale
- B. Epanchement articulaire
- C. Fissuration du cartilage hyalin
- D. Hypertrophie de l'extrémité osseuse
- E. Amyotrophie musculaire

11) Les caractéristiques d'un liquide de type mécanique sont les suivants sauf un lequel ?

- A. Coloration jaune citrin
- B. Riche en cellules (PNN)
- C. Visqueux
- D. Taux de protide < 40 g/l
- E. Pauvre en cellules (PNN)

12) Les macules : Cochez la fausse (RF)

- A- sont des lésions sans infiltration.
- B- sont des lésions sans relief.
- C- sont des lésions visibles à l'œil nu
- D- Peuvent être rouges ou pigmentées.
- E- sont toujours rouges.

13) Les pustules : Cochez la fausse (R F)

- A. correspondent à un afflux de polynucléaires neutrophiles dans l'épiderme.
- B. Peuvent être d'origine bactérienne ou non bactérienne.
- C. Peuvent se voir dans le psoriasis pustuleux et sont aseptique et non folliculaires.
- D. Sont toujours centrées par un poil.
- E. Peuvent se voir dans l'acné

14) Les lésions d'origine vasculaires regroupent : Cochez la réponse fausse (RF)

- A. les télangiectasies.
- B. les angiomes plans.
- C. les fièvres éruptives de l'enfant.
- D. les éphélides.
- E. les purpuras

15) Les papules : cochez-la ou les réponse (s) fausse (s) (R F)

- A. Correspondent à des lésions circonscrites en relief.
- B. Correspondent à des plaques de grande taille bourgeonnantes.
- C. Peut-être épidermique.
- D. Peut-être dermique.
- E. peuvent être œdémateuses.

16) Une atteinte lombosciatique S1 : cochez la réponse juste (RI)

- A. Décrit un trajet latéral du membre inférieur jusqu'à la face dorsale du pied
- B. Décrit un trajet latéral du membre inférieur jusqu'à la face plantaire du pied et le dernier orteil
- C. Décrit un trajet postérieur du membre inférieur jusqu'au bord externe du pied et le dernier orteil
- D. Décrit un trajet antérieur du membre inférieur jusqu'au genou
- E. Décrit un trajet postérieur du membre inférieur jusqu'à la face dorsale du pied

17) Une douleur d'horaire inflammatoire : Cochez la ou le (s) réponse (s) juste (s) (RI)

- A. Prédomine en fin de journée
- B. Réveille le patient à 2h du matin
- C. Elle est accompagnée d'un dérouillage matinal de 15 mn
- D. Elle est améliorée par l'effort
- E. Elle est aggravée par le repos

18) Une douleur d'horaire mécanique : Cochez-la ou les réponse (s) juste (s)

- A. Prédomine le matin
- B. Réveille le patient la nuit, lors des changements de position
- C. Elle est soulagée par l'effort
- D. Elle est aggravée par le repos
- E. Elle peut s'accompagner d'un dérouillage matinal de 5 mn

19) La douleur nociceptive: Cochez-la ou les réponse (s) juste (s)

- A. Peut être due à un traumatisme
- B. Elle est lancinante et permanente
- C. Elle s'accompagne de troubles sensitifs
- D. Elle est de topographie locale
- E. Elle est due à une lésion du système nerveux périphérique

20) Parmi les niveaux vertébraux suivant lequel ou lesquels peuvent entraîner une compression médullaire du canal vertébral ? Cochez la ou les réponse (s) juste (s).

- A. D 5
- B. D 12
- C. L 4
- D. S 1
- E. C 4

21) L'analyse sémiologique d'une douleur doit rechercher : Cochez la ou les réponse (s) juste (s)

- A. L'ancienneté de la douleur
- B. Le mode d'apparition de la douleur
- C. L'horaire de la douleur
- D. L'intensité de la douleur
- E. Les facteurs influençant son intensité

22) L'examen de la coordination comporte : Cocher la réponse fausse (RF)

- A. Épreuve doigt nez aux membres supérieurs
- B. La mobilisation passive des segments des membres
- C. L'épreuve talon genou aux membres inférieurs
- D. Exécuter des mouvements alternatifs rapides
- E. Examen de la station debout et de la marche tout d'abord les yeux ouverts, puis les yeux fermés.

23) Concernant la colonne vertébrale, indiquez-la proposition exacte

- A. Il existe huit vertèbres cervicales et douze vertèbres thoraciques
- B. Entrent dans la composition de la colonne vertébrale cervicale les vertèbres C1 (axis) et C2 (atlas)
- C. L'angle caudal de la scapula se projette en regard de C7
- D. Le sommet de la crête iliaque se projette au niveau T7
- E. Aucune des propositions ci-dessus n'est vraie

Cas clinique-1 (Questions 24- 26)

Monsieur Ali 44 ans, professeur de mathématiques, sans antécédents, vient vous consulter pour une douleur lombaire basse, irradiant à la face postéro-externe de la cuisse, à la face externe de la jambe et au dos du pied gauche.

24) Quels sont les éléments de l'interrogatoire à compléter ?

- A. L'horaire de la douleur
- B. La date de début de la douleur
- C. La notion d'un facteur déclenchant
- D. Le retentissement de la douleur
- E. Le mode évolutif de la douleur

25) Quel est le diagnostic à évoquer ?

- A. Lombosciatique LS gauche
- B. Lombosciatique S1 gauche
- C. Lombo-cruralgie L4 gauche
- D. Lombalgie pure
- E. Douleur lombaire projetée

26) Quels sont les critères de gravité à rechercher ?

- A. Une impulsivité à la toux
- B. Une incontinence urinaire
- C. Un déficit moteur
- D. Une douleur résistant aux antalgiques
- E. Un syndrome cérébelleux statique

33) Parmi ses éléments, lequel présente la plus haute densité au scanner : RJ

- A. Le parenchyme cérébral
- B. Le sang frais
- C. Le liquide céphalo-rachidien
- D. La graisse
- E. Le parenchyme cérébelleux

34) Quel est la séquence IRM la plus performante dans le diagnostic des hémorragies sous arachnoïdiennes ? RJ

- A. T2
- B. T2 FLAIR
- C. T2*
- D. Diffusion
- E. T1

35) L'hématome extra-dural : RJ

- A. Est une collection sanguine intra axiale
- B. L'étiologie la plus fréquente est l'HTA
- C. Sur la TDM il apparaît comme une collection spontanément hypodense
- D. Sur la TDM il apparaît comme une collection biconvexe
- E. Toujours accompagner d'une fracture de la voûte du crâne

36) L'hématome sous dural: RF

- A. Est une collection entre l'arachnoïde et la dure mère
- B. L'étiologie la plus fréquente est l'HTA
- C. Sur la TDM il apparaît comme une collection en croissant
- D. Sur la TDM il apparaît comme une collection en bande
- E. L'examen de choix pour le diagnostic est la TDM avec injection de produit de contraste.

37) L'IRM repose sur les propriétés magnétiques de: RJ

- A. Le sodium Na⁺.
- B. Le H₂O.
- C. L'hydrogène H⁺
- D. Le calcium Ca⁺.
- E. L'Oxygène.

38) L'unité de mesure de la densité au scanner est: RJ

- A. Unité Honeywell.
- B. Unité Hounsfield.
- C. Unité Hootsuite.
- D. Unité Hounsflow.
- E. Unité Hansel.

39) Concernant les hémorragies sous arachnoïdiennes: RF

- A. Le traumatisme est l'étiologie la plus fréquente.
- B. La dissection est la cause non traumatique la plus fréquente.
- C. Le scanner est l'examen de choix en urgence pour le diagnostic.
- D. Apparaît en hypo signal sur les séquences T2* à l'IRM.
- E. Apparaît en hyper signal sur la séquence Flair.

40) Parmi les signes biologiques suivants, lequel est commun de la méningite virale, bactérienne et tuberculeuse ?

- A. Protéinorachie basse.
- B. Protéinorachie élevée.
- C. Liquide céphalo-rachidien limpide.
- D. Lymphocytes élevées.
- E. Albuminorachie basse.

41) Une ponction lombaire, chez un patient qui présente une méningite bactérienne, donne un liquide riche en leucocytes, en protéines, et avec une Glycorachie très basse. Parmi les signes suivants, lesquels sont également retrouvés dans ce LCR :

- A. Les leucocytes sont à prédominance lymphocytaire.
- B. Le taux d'albumine est bas
- C. Le liquide est clair
- D. Le taux de lactate est élevé
- E. Le taux de chlorure est élevé

42) Après une ponction lombaire, le dosage d'immunoglobuline et d'albumine dans le LCR montre un index IgG élevé, ce résultat peut orienter vers :

- A. Une altération de la barrière hémato-méningée.
- B. Une synthèse intrathécale d'IgG
- C. Une maladie de Kahler
- D. Une méningite bactérienne
- E. Aucune réponse n'est exacte.

43) Parmi les conditions suivantes, laquelle contre-indique la ponction lombaire :

- A. Suspicion d'une sclérose en plaque
- B. Suspicion d'une tuberculose vertébrale
- C. Hémorragie méningée
- D. Coma fébrile
- E. Hypertension artérielle

44) Une hyperprotéinorachie associée à un taux normal de leucocytes au niveau de l'LCR, s'observe dans quelle affection :

- A. Méningite virale
- B. Compression médullaire
- C. Hémorragie méningée
- D. Méningite parasitaire
- E. Méningite tuberculeuse

45) Parmi les enzymes suivantes, laquelle est une enzyme d'excrétion qui augmente dans le syndrome de cholestase hépatique :

- A. Lipase
- B. Lactate déshydrogénase
- C. Phosphatases acides
- D. Phosphatases alcalines
- E. ASAT

46) Concernant les PAL : cocher la réponse fausse

- A. Sont élevées dans la grossesse
- B. Les valeurs de références sont plus élevées chez les enfants
- C. Sont très élevées dans la maladie de Paget
- D. Peuvent être élevées avec GGT élevées dans les pathologies osseuses
- E. Possède plusieurs iso-enzymes

47) A propos de la CKMB ; cocher la réponse juste

- A. C'est l'iso-enzyme musculaire de la créatine kinase.
- B. Elle présente une activité optimale à pH alcalin
- C. Elle augmente dans l'insuffisance cardiaque
- D. Elle augmente dans la nécrose myocardique
- E. Elle augmente dans les AVC.

48) La 5'nucleatidase: Cochez la réponse juste

- A. Est une Phosphatase acide
- B. Enzyme de la cytolyse hépatique
- C. Produite spécifiquement au niveau des muscles
- D. Diminue au cours des cholestases extra hépatiques
- E. Augmente au cours des cholestases intra hépatiques

49) Parmi les signes cliniques suivants, le(s)quel(s) vous orientent vers un syndrome malin des neuroleptiques ?

- A. Patient confus
- B. Une fréquence cardiaque à 78 battements / minute
- C. Des réflexes ostéotendineux diminués
- D. Un trouble du rythme
- E. Une hypotonie musculaire

50) Parmi les signes biologiques suivants, le(s)quel(s) vous orientent vers un syndrome malin des neuroleptiques ?

- A. Myoglobulinurie
- B. Rhabdomyolyse
- C. Acidose respiratoire
- D. Acidose métabolique
- E. Hypercapnie

51) Vous recevez un patient victime d'une chute dans un puits. Il est confus, vous paraît froid mais ne frissonne pas. Laquelle des températures suivantes peut correspondre à cet état ?

- A. 37°C
- B. 34°C
- C. 30°C
- D. 23°C
- E. Aucune des réponses précédentes

52) L'hypothermie entraîne

- A. Une hypotension artérielle
- B. Une baisse de la fonction ventriculaire
- C. Une augmentation du débit cardiaque
- D. Une baisse du métabolisme cellulaire
- E. Une vasodilatation périphérique

53) En cas d'hypothermie, quels modifications un ECG pourrait-il noter ?

- A. Bradycardie
- B. Allongement du QT et du PR
- C. Une onde delta
- D. Une onde J
- E. Une fibrillation ventriculaire

54) Parmi les étiologies suivantes, lesquelles pourraient conduire à une hypertension intra crânienne (HIC) ?

- A. Un hématome cérébral
- B. Une méningite
- C. Une tumeur cérébrale
- D. Un abcès cérébral
- E. Un traumatisme

55) En cas d'HIC, le risque est :

- A. Un engagement sous falciq (ou sous falcoriel)
- B. Un engagement temporal
- C. Un engagement diencephalique
- D. Un engagement des amygdales cérébelleuses
- E. Un engagement de la protubérance

56) En cas de HIC, quels signes cliniques pourrait-on voir ?

- A. Une diplopie
- B. Un coma
- C. Des céphalées
- D. Des vomissements
- E. Une mydriase unilatérale

57) Le traitement d'une HIC fait appel à

- A. Un décubitus horizontal strict
- B. Osmothérapie
- C. Corticothérapie
- D. Volet décompressif
- E. Toutes ces réponses

58) Laquelle ou lesquelles des situations suivantes se retrouve(nt) lors d'une acidose métabolique ?

- A. Un pH sanguin a 7.26
- B. Des bicarbonates plasmatiques à 15 mmol/l
- C. Une respiration ample et profonde
- D. Des nausées voire vomissements
- E. Un coma

59) Le bilan réalisé chez un patient donne les résultats suivants : pH = 7.30 ; Bicarbonates = [15{mmol/l}]; Chlorémie = [100{mmol/l}]; Na⁺ = [140{mmol/l}]; K⁺ = [5{mmol/l}]; PaO₂ = [80{mmHg}]; PaCO₂ = [30{mmHg}]. Vous concluez à :

- A. Acidose métabolique à trou anionique élevé
- B. Acidose métabolique a trou anionique normal
- C. Alcalose respiratoire à trou anionique élevé
- D. Alcalose respiratoire a trou anionique normal
- E. Aucune de ces réponses

60) Devant un œdème généralisé, vous devez penser à

- A. Une cirrhose hépatique
- B. Une insuffisance rénale
- C. Une insuffisance cardiaque
- D. Un choc anaphylactique

Examen UEI3 : 3^{ème} Année Rattrapage/ 2025**1) Cocher la réponse juste**

- A- L'obésité est définie selon l'OMS par un IMC $> 30 \text{ kg/m}^2$.
 - B- L'insuffisance pondérale ou malgré une difficulté de l'ombre d'établissement.
 - C- L'obésité peut entraîner des complications médicales, métaboliques et respiratoires.
 - D- L'obésité androïde ou obésité viscérale est évaluée par la mesure du périmètre abdominale.
 - E- Le syndrome de cushing fait partie des causes de l'obésité acquise.
- A(a+b), B(a+b+c), C(a+b+c+d+e), D(a+c+e), E(b+c+d+e)

2) Qu'est-ce que l'hypotension blouse blanche ? Cocher la réponse juste (RJ).

- A. Une élévation de la pression artérielle uniquement en milieu médical
- B. Une élévation de la pression artérielle uniquement à domicile
- C. Une pression artérielle normale en milieu médical et à domicile
- D. Une pression artérielle élevée en milieu médical et à domicile
- E. Une pression artérielle normale en milieu médical, avec retentissement sur les organes cibles

3) Toutes ses circonstances peuvent déclencher la prise de poids rapide, sauf une laquelle ?

- A. Choc émotionnel
- B. Tabac actif
- C. Traitement par les dérivés cortisolés
- D. Traitement par les antidépresseurs
- E. Sevrage du tabac

4) La pression pulsée (PP) : Cochez la réponse juste

- A. Est la différence entre la PAS et la PAD
- B. La PP est un facteur de risque
- C. Une PP supérieure ou égale à 60 mm/hg est considérée comme élevée
- D. Chez le sujet âgé, une pression pulsée élevée est un facteur prédictif de syndrome coronaire aigu, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral
- E. Toutes ses réponses sont justes.

5) Quelle est la complication la plus redoutable de la péricardite chronique ?

- A. Tamponnade
- B. Constriction
- C. La surinfection
- D. Les troubles du rythme
- E. Aucune de ses réponses n'est juste.

6) A propos des anomalies du segment ST et des ondes T à l'ECG, choisissez la réponse juste :

- A. Un sus-décalage du segment ST sur un territoire déterminé, oriente vers un courant de lésion sous-epicardique.
- B. Un sus-décalage du segment ST sur un territoire déterminé, oriente vers un courant de lésion sous-endocardique.
- C. Des ondes T positives larges et amples sur un territoire déterminé, orientent vers une ischémie sous-epicardique.
- D. Des ondes T négatives inversées et profondes sur un territoire déterminé, orientent vers une ischémie sous-endocardique.
- E. Toutes les réponses sont justes.

7) Les sibilants sont des râles respiratoires observées en cas : Cochez la réponse juste

- A. Pneumonie franche lobaire aiguë
- B. Epanchement pleural liquidien
- C. Crise d'asthme
- D. Pneumonie interstitielle diffuse
- E. Insuffisance cardiaque

8) Le pneumothorax se caractérise par : Cochez la réponse fausse (RF).

- A. Dyspnée
- B. Douleur thoracique
- C. Triade de Galliard
- D. Crépitants localisés aux bases pulmonaires
- E. Toux sèche irritative

9) Vous recevez en consultation un patient asthmatique en crise : Cochez la réponse fausse (RF).

- A. A l'inspection, vous constatez un tirage sus-sternal
- B. Il s'agit d'une dyspnée expiratoire
- C. A l'auscultation, on retrouve un carnalage
- D. L'expectoration survient à la fin de la crise.
- E. Vous notez une bradypnée à l'inspection

10) Concernant la sémiologie de la voix : Cochez la réponse fausse (RF)

- a) La voix bitonale est une alternance voix aigüe et voix grave.
- b) La voix nasonnée est due à une paralysie d'une corde vocale.
- c) La voix nasonnée est due à l'encombrement du cavum.
- d) La voix rauque se voit au cours de laryngite diphtérique.
- e) La voix bitonale est due à une paralysie d'une corde vocale.

A (b) B (a+c) C (e) D (c+e) E(d)

11) L'hémoptysie : Cochez la réponse juste (RJ)

- a) C'est du sang mêlé a des aliments.
- b) Quand elle est de moyenne abondance son volume est > 300cc.
- c) Elle toujours secondaire seulement a une maladie respiratoire.
- d) Parmi ces diagnostics différentiels il y a l'épistaxis.
- e) C'est du sang provenant des voies aériennes sous-glottiques.

A (b) B (b+d) C (d+e) D (a+b) E (b+c)

12) Une température centrale normale est définie par : Cochez la réponse juste :

- A. Une température corporelle $\leq 37,5$ C le matin et ou $\leq 37,8$ C le soir
- B. Une température corporelle $\leq 37,5$ C le soir
- C. Une température corporelle $\leq 38,3$ C le matin
- D. Une température corporelle $\leq 37,3$ C le soir
- E. Une température corporelle $\leq 36,5$ C le matin et ≤ 37 °C le soir

13) Parmi ces propositions lesquelles sont justes : Cochez la réponse juste (RJ)

- a) La dyspnée de Kussmaul est une Dyspnée à trois temps.
- b) La dyspnée de Cheyne-Stokes est classiquement retrouvée au cours comas acido-cetotique.
- c) La dyspnée de Kussmaul est classiquement retrouvée au cours de l'acidose métabolique.
- d) La respiration periodique du syndrome de pickwick se voit chez certains obèses.
- e) La respiration périodique du syndrome de pickwick s'accompagne d'une apnée inspiratoire complète.

A (e) B (a+c) C (d+e) D (c+d) E (a+b)

14) La valeur normale de l'intervalle QT corrige est : Cochez la réponse juste (RJ)

- A. Inférieur à 400 ms chez l'homme.
- B. Inférieur à 450 ms chez la femme
- C. Inférieur à 450 ms chez l'homme.
- D. Inferieur a 440 ms chez la femme
- E. Inferieur a 470 ms chez l'homme

15) L'hippocratisme digital : cochez la réponse juste (RJ)

- A. Déformation des doigts en crochets
- B. Déformation des dernières phalanges en baguettes de tambour
- C. Ne se rencontre pas dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique.
- D. Il peut être secondaire à une hypercapnie chronique.
- E. Déformation des doigts en coup de vent

16) Le souffle d'insuffisance mitrale : Cochez la réponse fausse (RF)

- A. Siege a la pointe et irradie habituellement vers l'aisselle
- B. Débute habituellement dès le premier bruit
- C. Peut être suivi d'un troisième bruit proto diastolique
- D. A une intensité maximale en mésosystole
- E. Est mieux perçu en décubitus latéral gauche

17) L'index de pression systolique : Cochez la réponse fausse

- A. Est un outil de dépistage de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- B. Il est le rapport de la pression systolique à la cheville sur la pression systolique humérale
- C. Il est utilisé également pour poser le diagnostic d'un lymphœdème des membres inferieurs
- D. Un IPS < 0.9 définit l'artériopathie des membres inférieurs
- E. Un IPS > 1.4 définit la médicalcose

18) Cochez la réponse fausse

- A. Les œdèmes peuvent être localisés ou généralisés
- B. Le tableau d'anasarque est défini par un œdème généralisé et les épanchements des séreuses
- C. Les œdèmes des membres inférieurs peuvent avoir une origine hépatique, rénale ou cardiaque
- D. Le myxoœdème n'entraîne pas de prise pondérale
- E. Les œdèmes d'origine hépatique ou rénale sont blancs, mou, indolores gardant le godet

19) Cochez la réponse juste : Cochez la réponse juste

- A. La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs est à suspecter devant une grosse jambe rouge avec diminution du ballonnement du mollet.
- B. Le diagnostic de la TVP des membres inférieurs fait appel à l'écho doppler vasculaire des membres inférieurs
- C. La TVP des membres inférieurs est une urgence médicale, car elle peut se compliquer d'embolie pulmonaire
- D. La réalisation de l'angioscanner thoracique est indispensable en cas suspicion d'embolie pulmonaire
- E. Toutes ses réponses sont justes

20) Décrire la triade de TROUSSEAU : Cocher la réponse fausse (RF)

- A. Abolition des M V
- B. Abolition des M V
- C. Hypersonnonrité à la percussion
- D. Matité à la percussion
- E. Il reflète la présence d'un sd d'épanchement liquide

22) A l'ECG ; un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à l'obtention d'une onde P bloquée, puis reprise d'une séquence identique évoque un trouble de la conduction de type:

- A. Un bloc auriculo-ventriculaire du 3eme degré ou BAV complet.
- B. Une pré-excitation ventriculaire au cours du syndrome de Wolff-Parkinson-White.
- C. Un bloc de branche gauche.
- D. Bloc auriculo-ventriculaire du 2eme degré Mobitz 1.
- E. Un bloc de branche droit.

23) A l'ECG ; un raccourcissement de l'intervalle associe a un aspect en cupule du segment ST évoque:

- A. Une hyperkaliémie.
- B. Une hypokaliémie.
- C. Une hypercalcémie.
- D. Une hypocalcémie.
- E. Toutes les réponses sont justes.

21) Un liquide pleurale dont la cytologie est fortement lymphocytaire :

Cocher la réponse fausse (RF)

- A. Il est souvent exsudatif
- B. Transudatif
- C. Correspond au taux de protéine dans la plèvre / protéine sérique > 0.5
- D. Oriente souvent vers une origine infectieuse tuberculeuse
- E. Nécessite la réalisation d'une IDR a la tuberculine et la recherche de

24) A l'ECG ; un complexe QRS large dépassant 120 m3 peut se voir dans toutes les situations suivantes sauf une : laquelle ?

- A. Un bloc de branche gauche.
- B. Une hyperkaliémie sévère.
- C. Un bloc de branche droit.
- D. Des extrasystoles ventriculaires.
- E. Des extrasystoles auriculaires.

25) L'emplacement de l'électrode V4 de l'ECG se situe au :

- A. 4e espace intercostal droit au ras du sternum.
- B. 4e espace intercostal droit au ras du sternum.
- C. 5e espace intercostal gauche, sur la ligne médioclaviculaire.
- D. 5e espace intercostal gauche, sur la ligne axillaire moyenne.
- E. 5e espace intercostal gauche, sur la ligne axillaire moyenne.

26) Parmi les techniques d'auscultation suivantes, quelle est la plus adéquate pour rechercher une insuffisance aortique ? (Cocher la RJ)

- A. Patient assis penche en avant et en expiration forcée
- B. Patient en décubitus latéral gauche et après effort
- C. Patient en décubitus latéral droit, en inspiration forcée
- D. Patient en décubitus dorsal
- E. Patient assis penche en avant et en inspiration forcée

27) Au cours du rétrécissement mitral pur, la saillie et l'allongement de l'arc moyen gauche a la radiographie du thorax sont dues à : (Cochez la RJ)

- A. La dilatation du tronc de l'artère pulmonaire
- B. La dilatation de la crosse de l'aorte
- C. La réduction du volume ventriculaire gauche
- D. La stase veineuse dans le hile gauche
- E. La dilatation de veines pulmonaires

28) Dans l'insuffisance aortique pure et importante, on peut retrouver parmi les signes suivants : (Cochez la RF)

- A. Un élargissement de la tension artérielle différentielle
- B. Une hyperpulsatilité artérielle
- C. Un roulement diastolique dépointe
- D. Un souffle systolique au foyer aortique
- E. Une saillie de l'arc moyen gauche a la radiographie du thorax

Cas clinique (28-30) :

Une femme âgée de 40ans, consulte pour une fièvre traitant depuis plus de trois semaines. Elle décrit des sueurs nocturnes, une fatigue et un amaigrissement non chiffre. On ne note pas d'antécédents particuliers.

29) Parmi les causes suivantes, quelle est la cause la plus fréquente de cette fièvre ?

- A. Une infection bactérienne
- B. Une maladie auto-immune
- C. Une cause néoplasique
- D. Une intoxication médicamenteuse
- E. Une cause endocrinienne

30) En dehors d'une toux sèche, l'interrogatoire ne retrouve aucun autre signe fonctionnel et l'examen clinique est normal.

Parmi les examens complémentaires suivants, lequel allez-vous demander en premier ?

- A. Une IDR a la tuberculine
- B. Une CRP
- C. Une hémoculture
- D. Un scanner thoracique
- E. Un bilan thyroïdien

31) Quelle est la cause qui vous semble la plus probable ?

- A. Une pneumonie aigue
- B. Une maladie de Still
- C. Une leucémie aigue
- D. Une brucellose
- E. Une tuberculose pulmonaire

32) Les ultrasons: Cochez la RF.

- A. Sont produites par effet piézomagnétique
- B. C'est des ondes acoustiques.
- C. D'une fréquence supérieure à 20mm.
- D. Ne comportent pas de risque pour traîner.
- E. Leur formation est basée sur la définition de la matière.

33) En échographie les faisceaux perpendiculaires seront:

- A. Atténués
- B. Réfléchies.
- C. Détectées par la sonde d'échographie.
- D. Perdue mais continue à être atténuées.
- E. Se propages en ligne droite.

34) Devrait d'une onde ultrasonore: Cochez la RF.

- A. Atténuées
- B. Réfléchies.
- C. Diffusée.
- D. elle va subir une réfraction.
- E. Absorbée.

35) Parmi ces propositions, laquelle représente l'impudence la plus élevée : Cochez la RJ.

- A. Eau.
- B. Foie.
- C. Os.
- D. Urine.
- E. Sang.

36) Les sondes échographiques a basse fréquence, sont caractérisées par:

- A. utilisés une fréquence de 10Mhz ou plus.
- B. faible pénétration et bonne résolution.
- C. bonne résolution et bonne pénétration.
- D. bonne pénétration et moins bonne résolution.
- E. moins bonne résolution et faible pénétration.

37) Propriétés des rayons X : cochez la RF

- A. Traverses le corps humain.
- B. Ils provoquent une illumination des émulsions photographiques.
- C. Utilisés en radiothérapie.
- D. Ils se propagent en ligne droite.
- E. Provoque l'illumination de certains sels minéraux.

38) En échographie pour l'étude de structures de faible profondeur on utilise : Cochez la juste.

- A. La sonde a plus faible fréquence.
- B. La sonde a plus haute fréquence.
- C. Tout type de sonde.
- D. Sonde à fréquence moyenne.
- E. Le choix de la sonde n'est pas important.

39) Une structure liquidienne en échographie donne : Cochez la réponse juste

- A. Une image anéchogène noire ou transonore.
- B. Une image hyperéchogène avec cône d'ombre.
- C. Une image échogène hétérogène.
- D. Une clarté homogène.
- E. Une image hypoéchogène hétérogène.

40) Un calcul donne en échographie : Cochez la réponse Juste.

- A. Une image anéchogène ou transonore.
- B. une image hyperéchogène avec cône d'ombre.
- C. Une image échogène hétérogène.
- D. Une image hypoéchogène hétérogène.
- E. Une clarté homogène.

41) A propos des indications du dosage de la troponine Hs : cochez la réponse fausse

- le diagnostic d'exclusion des IDM
- le Pronostic de l'IDM
- le pronostic de l'insuffisance cardiaque
- le diagnostic des IDM ST+
- le diagnostic différentiel des douleurs thoraciques

42) Un Homme de 65 ans Fumeur avec douleurs thoraciques de moins de 2h présente une troponine T Hs de 25 ng/L et un ECG Normal vous décidez de : la réponse juste

- A. hospitaliser le malade et le traiter
- B. faire sortir le malade
- C. refaire le dosage de troponines Hs dans 1h
- D. refaire l'ECG
- E. demander le dosage de la CPK

43) Un homme de 36 ans, consulte un ophtalmologiste pour des verres de lecture, celui-ci constate que le patient présente un arc cornéen bilatéral. L'examen complémentaire montre la présence d'axanthome tendineux au niveau des tendons d'Achille. Le patient est normo- pondéral, normo-tendu, normo-glycémique et non-fumeur. Un questionnaire révèle que son père est décédé d'un IDM à 40 ans. Ce tableau clinique est-il évocateur de :

- A. Hypercholestérolémie familiale
- B. Hypertriglycéridémie mixte
- C. Hypertriglycéridémie familiale
- D. Dyslipidémie mixte
- E. Dyslipidémie secondaire

44) Parmi les éléments suivants, lequel représente le potentiel redox de l'organisme et intervenant dans les réactions d'anabolisme :

- A. Hème.
- B. Glutathion
- C. NADPH, H⁺
- D. NADH, H⁺
- E. Vitamine C.

45) Parmi les conditions suivantes, lequel (sont) en faveur d'un état pro-oxydant :

- A. Taux bas de Fer sérique
- B. Un rapport Cu/Zn < 1
- C. Un taux bas en Sélénium
- D. Un rapport NAD⁺/NADH, H⁺ > 1
- E. Un rapport Fer/Cu < 1

46) Un patient de 60ans, présente une cirrhose décompensée, chez qui un liquide d'épanchement non infecté est accumulé au niveau pleural et péritonéal. Cochez la réponse juste :

- A- Il s'agit d'un exsudat
- B- Il s'agit d'un transsudat
- C- Liquide riche en lymphocytes
- D- Liquide riche en polynucléaires neutrophiles
- E- Liquide riche en chylomicron

47) Une tuberculose péritonéale est à l'origine d'une ascite qui se caractérise par : cochez la réponse fausse.

- A- Un test rival ta positif
- B- Un taux de leucocyte > 1000 mm³ à prédominance polynucléaire.
- C- Un taux élevé de protéine.
- D- Un liquide de type exsuda
- E- Un liquide inflammatoire.

48) Un liquide pleural rougeâtre, qui coagule spontanément à l'air libre en caillot sanguin, peut être évocateur de :

- A- Syndrome néoplasique
- B- Hémothorax
- C- Infection virale
- D- Pancréatite aigüe nécrotique
- E- Polyarthrite rhumatoïde

49) Une femme obèse de 50ans avec un diabète type 2 est hospitalisée pour une glycémie à 5.8g/l.

Un prélèvement sanguin est réalisé à jeun, le sérum est fortement lactescent. L'échantillon a été conserve au frais pendant toute une nuit, il présente un surnageant crémeux, la partie inferieure demeure trouble. Cet aspect du sérum est-t-il évocateur de :

- A- Hypercholestérolémie
- B- Un taux élevé d'LDL cholestérol.
- C- Un taux élevé de chylomicron et de VLDL
- D- Un taux élevé d'HDL cholestérol
- E- Une hypertriglycéridémie endogène

50) Un patient présente les chiffres tensionnels suivants : {PAD} = 40{mmHg}, {PAS} = 160{mmHg}. La pression puisée est de :

- A. 100 mmHg
- B. 90 mmHg
- C. 80 mmHg
- D. Environ 65 mmHg
- E. 50 mmHg

51) Cochez la ou les propositions juste(s) :

- A. La noradrénaline augmente la pression artérielle par vasoconstriction
- B. L'adrénaline augmente la pression artérielle en augmentant uniquement le débit cardiaque
- C. L'hormone antidiurétique agit sur la volémie et sur les résistances vasculaires systémiques
- D. Le facteur natriurétique auriculaire abaisse la pression artérielle par augmentation de la sécrétion hydrosodée rénale et par une vasodilatation artériolaire.
- E. Le système récline angiotensine entraîne une augmentation de la pression artérielle en agissant sur plusieurs niveaux

52) Un état de choc ?

- A. Survient lorsque la demande cellulaire dépasse le transport sanguin en oxygène
- B. Il réalise une insuffisance circulatoire aigue
- C. Peut-être quantitatif ou distributif
- D. Peut être compensé au début
- E. Sa prise en charge associe un traitement symptomatique à un traitement étiologique

53) Parmi ces signes, lequel (ou lesquels) peut/en/t se voir dans un état de choc ?

- A. Agitation
- B. Tachypnée
- C. Tachycardie
- D. Oligurie
- E. Marbrures

54) Parmi les étiologies du choc cardiogénique on peut retrouver :

- A. IDM
- B. Intoxication aux antiarythmiques
- C. Bloc auriculo-ventriculaire (BAV)
- D. Fibrillation ventriculaire
- E. Embolie pulmonaire grave

55) Choc septique

- A. Est un choc quantitatif
- B. Résulte d'une réaction inflammatoire massive de l'organisme
- C. Se complique souvent d'une défaillance cardiaque par effet inotrope négatif
- D. Passe par une phase hyperkinétique et une phase hypokinétique
- E. La différence arterioveineuse en oxygène y est très diminuée

56) Origine de la maladie thromboembolique

- A. Est résumée par la triade de Virchow
- B. Comprend un ralentissement de l'écoulement sanguin
- C. Comprend la libération du facteur tissulaire par lésion endothéliale vasculaire
- D. Comprend une augmentation des protéines S et C
- E. Comprend un déficit en facteurs VII et VIII

57) Vous recevez un patient aux antécédents d'HTA qui vous dit être essoufflé depuis peu lorsqu'il monte les escaliers de son bâtiment et ce dès le 2ème étage alors qu'il habite au 4ème ce qui l'oblige à s'arrêter et reprendre son souffle. Parfois il ressent même des palpitations. Vous la classez ?

- A. NYHA I
- B. NYHA II
- C. NYHA III
- D. NYHA VI
- E. NYHA V

58) L'exploration hémodynamique de ce patient revient comme suit : VTD=100ml, VTS=50ml, FC=50 battements/minute.

Vous concluez que :

- A. Son débit cardiaque est normal
- B. Son débit cardiaque est élevé
- C. Son débit cardiaque est bas
- D. Son (volume d'éjection systolique) VES est de 150 ml
- E. Son VES est de 50 ml

59) Ce même patient a une fraction d'éjection du ventricule gauche (VG) calculée à l'échographie cardiaque à 47%. Vous concluez que :

- A. Ceci concorde avec vos précédentes conclusions
- B. Ceci ne concorde pas avec vos précédentes conclusions
- C. Le patient à une fonction VG altérée
- D. Le patient à une fonction VG modérément réduite
- E. Le patient à une fonction VG normale

60) Qu'allez-vous lui proposer comme traitement ?

- A. Rien, le patient a un profile normal.
- B. Dérivés nitrés
- C. Diurétiques
- D. Noradrénaline
- E. IEC

Examen UEI 4 : 3^{ème} Année Rattrapage/ 2025

1) Quelles sont les caractéristiques cliniques de la dysphagie organique : Cocher la ou les réponse (s) juste (s) (RJ)

- A. Elle est souvent d'apparition progressive
- B. Elle touche d'abord les liquides, puis les solides
- C. Elle peut être due à une Achalasie
- D. Elle est souvent associée à une perte de poids
- E. Elle est plus fréquente chez les sujets jeunes sans comorbidité

2) Le pyrosis est: Cocher la ou les réponse (s) juste (s) (RJ)

- A. Une sensation de brûlure ascendante
- B. Souvent amélioré par les antiacides
- C. Un symptôme de pancréatite
- D. Majoré en position allongée
- E. Typiquement postprandial

3) Quel est le signe de Murphy ?

- A. Défense abdominale en fosse iliaque droite
- B. Arrêt inspiratoire à la palpation de l'hypochondre droit
- C. Douleur provoquée par la toux
- D. Douleur à la percussion lombaire
- E. Bruit hydro-aérique augmenté

4) Quels signes cliniques associés à une dysphagie orientent vers une cause organique ?

- A. Amaigrissement non expliqué
- B. Douleur à la déglutition (odynophagie)
- C. Troubles de la déglutition intermittente, non évolutifs
- D. Vomissements alimentaires postprandiaux précoces
- E. Hématémèse ou méléna

5) La présence d'hémorroïdes peut être détectée par : Cochez la réponse juste.

- A. Inspection et toucher rectal
- B. Palpation de l'hypochondre gauche
- C. Percussion du flanc gauche
- D. Auscultation abdominale
- E. Recherche du signe de Blumberg

6) Quel signe évoque une hépatomégalie à l'examen clinique ?

- A. Masse mobile en fosse iliaque droite
- B. Sensibilité au niveau lombaire
- C. Masse ferme, bord inférieur palpable sous le rebord costal droit
- D. Douleur à la palpation du flanc gauche
- E. Tension abdominale

7) Quels sont les signes en faveur d'une ascite de grande abondance (RF):

- A. L'ombilic est déplissé.
- B. Le signe du flot est positif.
- C. Le signe du glaçon est négatif.
- D. Le patient est dyspnéique.
- E. Une circulation veineuse collatérale sous ombilicale.

8) Quel examen permet le diagnostic d'une ascite cloisonnée ? (RJ)

- A. La palpation.
- B. La percussion.
- C. La ponction exploratrice.
- D. L'échographie.
- E. Un Scanner abdominale.

9) Quel est le repère de la ponction d'ascite ?

- A. l'union des 1/3 externe et 2/3 internes de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque antérosupérieure gauche.
- B. l'union des 2/3 externes et 1/3 interne de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque antérosupérieure gauche.
- C. l'union des 1/3 externe et 2/3 internes de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque anterosuperieure droite.
- D. l'union des 2/3 externes et 1/3 interne de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque anterosuperieure droite.
- E. Aucune de ces réponses n'est juste

10) Devant un liquide d'ascite hématique, quelle étiologie évoquez-vous ?

- A. Insuffisance cardiaque droite.
- B. Hypertension portale.
- C. Une tuberculose.
- D. Un syndrome néphrotique.
- E. Une néoplasie.

11) Une douleur de type colique est typiquement : Cochez la ou les réponse (s) juste (s).

- A. En barre
- B. Paroxystique
- C. Calmée par les vomissements
- D. Calmée par l'émission de gaz
- E. Diffuse

12) Les ganglions jugulo-carotidiens drainent (choisissez la réponse fausse):

- A. Le pharynx.
- B. Le larynx.
- C. Les amygdales.
- D. Les poumons.
- E. Le voile du palais

13) Une splénomégalie d'origine infectieuse peut être secondaire à (choisissez la réponse fausse) :

- A. Une maladie de Gaucher.
- B. Une leishmaniose viscérale.
- C. Un kyste hydatique de la rate.
- D. Un paludisme.
- E. Une septicémie.

14) Une diarrhée chronique peut être causée par : Cochez la ou les réponse (s) juste (s).

- A. Intolérance au lactose
- B. Hyperthyroïdie
- C. Syndrome du côlon irritable
- D. Rectocolite hémorragique
- E. Appendicite aiguë

15) Les douleurs de type pancréatique sont : Cochez la ou les réponse (s) juste (s).

- A. En barre
- B. Transfixiantes
- C. Majorées par l'alimentation
- D. Irradiant vers l'épaule droite
- E. Calmé par l'antéflexion

16) Une hépatomégalie douloureuse d'apparition brutale évoque en premier lieu :

- A. Métastases hépatiques
- B. Congestion hépatique aiguë (insuffisance cardiaque droite)
- C. Cirrhose alcoolique
- D. Hépatite auto-immune
- E. Amylose hépatique

17) Quel signe oriente vers une masse hépatique solide d'allure tumorale à l'examen clinique ?

- A. Foie mou, indolore, régulier
- B. Foie rétracté, dur
- C. Foie dur, nodulaire, bosselé
- D. Foie sensible, lisse
- E. Foie homogène avec ascite

18) Parmi les médicaments suivants, lequel est classiquement responsable d'hépatomégalie avec cytolyse ?

- A. Oméprazole
- B. Amiodarone
- C. Furosémide
- D. Salbutamol
- F. Paracétamol (à posologie thérapeutique)

19) Pour le diagnostic évident d'une appendicite aiguë : Cochez la réponse fausse (RF)

- A- Le signe de Blumberg peut être présent.
- B- Le signe de Rosving peut être présent.
- C- La défense de la FID est rarement présente
- D- La douleur de la FID est toujours présente
- E- Toutes ces réponses sont fausses

20) Dans une occlusion intestinale aiguë : Cochez la réponse juste (RJ)

- A- La douleur abdominale peut manquer
- B- La TDM n'est pas obligatoire
- C- L'ASP peut montrer un niveau aérique inter hépato-diaphragmatique
- D- Parmi les signes physiques une contracture abdominale
- E- Aucune réponse n'est juste

Cas clinique-1 (Questions 21-25)

M. L. 25 ans, consulte pour une douleur abdominale aigue débutant il y a 18 heures, diffuse autour de l'ombilic puis localisée dans la fosse iliaque droite. Il a une légère fièvre à 38°C. À l'examen, on note une sensibilité marquée à la palpation du point situe à un tiers de la distance entre l'épine iliaque antero-superieure droite et l'ombilic.

21) Quel est le nom du point sensible décrit à l'examen ?

- A. Point de Murphy
- B. Point de McBurney
- C. Point de Giordano
- D. Point de Labbé
- E. Point de Lanz

22) Quel signe clinique traduit une irritation péritonéale locale dans ce contexte ?

- A. Maître abdominale
- B. Tympanisme généralisé
- C. Douleur augmentée à la palpation profonde de la fosse iliaque droite
- D. Diminution des bruits intestinaux
- E. Douleur à la palpation superficielle de l'hypochondre gauche

23) Quelle technique d'examen permet le mieux d'évaluer la défense abdominale ?

- A. Palpation douce suivie d'un relâchement brusque
- B. Auscultation prolongée
- C. Recherche du reflexe cutané abdominal
- D. Percussion des espaces intercostaux
- E. Palpation profonde avec relâchement brutal

24) Quel signe clinique évoque une péritonite en extension ?

- A. Douleur localisée uniquement à la fosse iliaque droite
- B. Absence de fièvre
- C. Contracture abdominale généralisée
- D. Présence d'un souffle abdominal
- E. Masse palpable dans l'épigastre

25) Quelle région abdominale est le siège typique de la douleur lors de l'appendicite ?

- A. Hypochondre droit
- B. Région péri-ombilicale initiale
- C. Fosse iliaque droite
- D. Région épigastrique
- E. Hypogastre

Cas clinique-2 (Questions 26-28)

Un patient âgé de 50 ans sans antécédents particuliers, se présente en consultation pour une altération de l'état général avec asthénie, anorexie, amaigrissement de 10kg en 2 mois, l'examen clinique révèle un abdomen distendu avec à la percussion une matité déclive.

26) Quel est le signe clinique qui permet d'affirmer que c'est ascite ? Cochez la ou les réponse (s) fausse (s) (RF)

- A. Un signe du flot positif.
- B. Un signe du glaçon positif.
- C. La mobilité de la matité en décubitus latéral.
- D. Signe de Murphy.
- E. Signe de Mc Burney

27) Vous avez confirmé que c'est une ascite de moyenne abondance ; quel est le 1^{er} examen à réaliser pour le bilan étiologique ? Cochez la réponse juste (RJ)

- A. Une ponction évacuatrice et exploratrice.
- B. Une laparotomie.
- C. Une TDM Thoraco-abdomino pelvienne.
- D. Une endoscopie digestive.
- E. Une coelioscopie avec étude anatomopathologique.

Les résultats des examens vous parviennent, la ponction retrouve un liquide jaune citrin, avec un taux de protide à 35g/l, richement lymphocytaire, culture en cours, une TDM Thoraco-abdomino pelvienne retrouve un épaississement péritonéal et la coelioscopie retrouve un aspect en grain de couscous, l'étude anatomopathologique en cours.

28) Quel est le diagnostic le plus probable ? (RJ)

- A. Carcinose péritonéale.
- B. Tuberculose péritonéale.
- C. Tumeurs du foie.
- D. Maladie inflammatoire de l'intestin.
- E. Mésothéliome péritonéale.

Cas clinique-3- (Questions 29- 30)

Monsieur Hamza âgé de 22ans, célibataire, étudiant en médecine, consulte pour une tuméfaction cervicale jugulo-carotidienne droite faisant 02cm de diamètre et évoluant depuis trois semaines. L'interrogatoire retrouve une notion de sueurs nocturnes avec amaigrissement de 05 kg le mois dernier.

29) Quels caractéristiques sémiologiques cherchez-vous à l'examen clinique et pouvant vous orienter vers le diagnostic d'une adénopathie tuberculeuse? (Choisissez la combinaison juste) :

- a) Une consistance dure à la palpation.
- b) Une consistance molle à la palpation.
- c) Une adénopathie fixée aux plans profonds.
- d) La peau qui la recouvre est rouge luisante.
- e) La peau qui la recouvre est normale.

A (a+c) B (c+d) C (b+d) D (a+e) E (d+e)

30) Parmi les propositions suivantes concernant les examens complémentaires réalisés chez votre patient, laquelle est juste?

- A. La ponction ganglionnaire n'est jamais indiquée dans ce cas.
- B. La biopsie ganglionnaire est obligatoire même si la cytoponction retrouve un granulome tuberculeux.
- C. L'échographie cervicale met en évidence l'adénopathie et peut guider la cytoponction.
- D. L>IDR à la tuberculine est un test inutile car il s'agit d'une forme de tuberculose extrapulmonaire.
- E. Toutes les réponses sont justes.

31) L'ASP est une radiographie de l'abdomen : RF

- A. dans la majorité des cas ce fait en position début.
- B. Ce fait en expiration.
- C. Les rayons X sont verticaux quand l'ASP est en décubitus dorsal.
- D. Permet l'étude de la disposition de l'air digestif.
- E. Trois clichés peuvent être réalisés suivant la pathologie suspectée.

32) Les critères de réussite de l'ASP sont : RF

- A. Voir en bas les symphyses pubiennes.
- B. Voir en haut le diaphragme.
- C. 70 à 80 KV au minimum.
- D. 70 à 80 KV au maximum.
- E. Un temps de pause court.

33) L'espace de MORISSON se situe: RJ

- A. Entre la rate et le rein gauche.
- B. Entre la rate et l'estomac.
- C. Entre la rate et le diaphragme.
- D. Entre la rate et le pancréas.
- E. Entre le foie et le rein droit.

34) L'examen le plus performant dans le diagnostic du pneumopéritoine est : RJ

- A. ASP couché.
- B. L'échographie.
- C. ASP début.
- D. Le télé thorax en expiration.
- E. Le scanner.

35) les diagnostics différentiels d'un pneumopéritoine sont : RF.

- A. Clartés graisseuses sous diaphragmatique.
- B. Syndrome de CHILADITI.
- C. Clarté colique inter hépatorénale.
- D. Clarté pulmonaire.
- E. Abscès sous phrénique.

36) caractéristiques de lithiases vésicales à l'ASP : RF

- A. Gros calcul.
- B. Stratifiée.
- C. Dense.
- D. Pelvien.
- E. Latéralisée à droite ou à gauche.

37) caractéristiques d'une masse intra péritonéale a l'ASP: RF.

- A. Cernée par des clartés digestives.
- B. Efface les contours du psoas.
- C. N'efface pas les contours des reins.
- D. Pas de destruction des vertèbres.
- E. Refoule les clartés digestives.

38) diagnostique différentiel d'un pneumopéritoine : RF.

- A. syndrome de CHILADITI.
- B. abcès sous phrénique.
- C. clartés parenchymateuses pulmonaires.
- D. clartés graisseuses sous diaphragmatique.
- E. Une aerobilie.

39) diagnostique topographique d'une masse retro-péritonéale: RF.

- A. Déplacement du rein en bloc vers le bas et l'extérieur.
- B. Déformation des contours du rein.
- C. N'efface pas la ligne du posas.
- D. Atteinte vertébrale de voisinage.
- E. Soulèvement des lignes para vertébrales

40) Parmi les causes des lettres a bilirubine conjuguée : cocher la réponse fausse

- A. Cancer du pancréas
- B. Hépatite virale
- C. Lithiase vésiculaire
- D. Carcinome hépato cellulaire
- E. Immaturité hépatique (prématuré)

41) Le CA19.9, donner la réponse justes

- A. Augmente dans les adénocarcinomes du pancréas
- B. Est efficace pour le dépistage des cancers colorectaux
- C. Est indiquée pour le diagnostic du cancer de la tête du pancréas
- D. N'augmente pas en cas des certaines maladies digestives non cancéreuses
- E. Toutes ces propositions sont fausses

42) Parmi ces tests, lesquelles permettent de poser le diagnostic différentiel entre la malabsorption intestinale et l'insuffisance pancréatique :

- A. Dosage de la lipase sanguine
- B. Dosage de l'amylasurie
- C. Test isotopique à la trioléine marquée
- D. Test au para-amino-benzoïque
- E. Test de stimulation a la sécrétine

43) Parmi les facteurs suivants, lequel, est un facteur de risque de la pancréatite aigue :

- A. Hypercholestérolémie familiale
- B. Hypertriglycéridémie majeure
- C. Diabète insulino-dépendant
- D. Alcoolisme
- E. Tabagisme

44) L'hyper protéinémie s'observe dans le cas suivant :

- A. En cas d'alimentation riche en protéines
- B. En cas d'hémodilution
- C. En cas d'atteinte hépatique
- D. Dans les états de malabsorption
- E. En cas de maladie de kahler

45) Concernant la pancréatite aigue, cochez la réponse fausse :

- A. Est due à une activation prématurée des zymogènes dans le pancréas,
- B. Se caractérise par une douleur épigastrique accentuée par la prise de repas,
- C. L'hypertriglycéridémie majeure est l'une des étiologies fréquentes
- D. La sécrétion de bicarbonate est diminuée
- E. Le taux sanguin de la lipase est élevé

46) Concernant la maladie coeliaque, cochez la réponse fausse :

- A. Elle est déclenchée par l'ingestion de la protéine de blé,
- B. Est une affection inflammatoire non infectieuse de l'intestin,
- C. La malabsorption est due à une atrophie villositaire
- D. Diagnostiqué uniquement chez l'enfant
- E. La biopsie duodénale représente est indiquée pour confirmer le diagnostic

47) Le test à la sueur, cochez la réponse juste:

- A. dosage des chlorures au niveau de la sueur
- B. dosage du sodium au niveau de la sueur
- C. permet le dépistage de la mucoviscidose
- D. permet de diagnostiquer une pancréatite algue
- E. permet de diagnostiquer une pancréatite chronique

48) La maladie de Crhon est une affection inflammatoire de l'intestin qui se caractérise par :

- A. Une élévation de la CRP et des immunoglobulines,
- B. Une hyper protéinémie
- C. Une hyperglycémie
- D. Hypoglycémie
- E. E-Une hypertriglycéridémie

49) Cochez la ou les réponse(s) juste(s) :

- A. Le potassium se trouve en majorité en intracellulaire
- B. Le potassium se trouve en majorité en extracellulaire
- C. Une kaliémie de 4.20 mmol/l est considérée comme normale
- D. Sa régulation est passive
- E. Sa régulation est active

50) Parmi ces étiologies, quelles sont celles qui sont à l'origine d'une hypokaliémie de transfert ?

- A. L'acidose métabolique
- B. L'alcalose métabolique
- C. L'hyperglycémie
- D. Défaut d'apport
- E. Le salbutamol

51) Quels sont parmi ces signes ECG ceux qu'on retrouve lors d'une hyperkaliémie ?

- A. Onde U
- B. Onde P
- C. Onde J d'Osbon
- D. Onde T pointue ample symétrique
- E. Troubles du rythme

52) Que(s) est (sont) le(s) traitement(s) d'urgence d'une hyperkaliémie >6,5mmol/l ?

- A. Kayexalate 30-60 g per os
- B. Gluconate de potassium IV 1g en 10mn
- C. Diurétiques de l'anse
- D. Insuline rapide et sérum glucose hypertonique
- E. KCL à la dose de 1g/n

53) La bilirubine libre ne répond pas à quelle(s) proposition(s) ?

- A. Est aussi appelée indirecte
- B. Est majoritaire
- C. Est liée à l'albumine
- D. Sa solubilité dans l'eau en fait toute sa gravité
- E. Provoque des dégâts en se fixant sur les noyaux gris dans le cerveau

54) Quelle(s) proposition(s) ne correspond (ent) pas à la bilirubine conjuguée ?

- A. Proviennent de la glucuro-conjugaison de la bilirubine non conjuguée
- B. Est fabriquée dans l'hépatocyte
- C. Est sécrétée dans la bile de façon passive
- D. Est éliminée dans les urines
- E. Est éliminée dans les selles

55) L'ictère produit par une hémolyse massive (réponse(s) juste(s))

- A. Est un ictère à bilirubine conjuguée
- B. Est un ictère à urines foncées
- C. Est un ictère à selles décolorées
- D. Le dosage de la bilirubine conjuguée est normal
- E. Dans sa clinique on peut retrouver anémie, splénomégalie et hépatomégalie

56) Parmi les causes suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent entraîner un ictère à bilirubine non conjuguée ?

- A. Drépanocytose
- B. Thalassémie
- C. Lithiase du cholédoque
- D. Accidents transfusionnels
- E. Maladie de Gilbert

57) Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) juste(s) ?

- A. L'ictère des hépatites est mixte
- B. Les lithiases vésiculaires donnent des ictères à bilirubine conjuguée
- C. Les cancers des voies biliaires donnent des ictères à bilirubine non conjuguée
- D. L'ictère néonatal est un ictère à bilirubine conjuguée
- E. Le déficit en G6PD donne un ictère à bilirubine non conjuguée

58) L'angle de Treitz (réponse(s) juste(s))

- A. Correspond à l'angle duodeno-jejunal
- B. Permet de différencier les hémorragies digestives hautes et basses
- C. Correspond à la jonction DII et DIII du duodénum
- D. Fait suite à la partie ascendante du duodénum
- E. Permet de différencier une hématomèse d'une hémoptysie

59) Les variées œsophagiennes (RJ)

- A. Se forment lorsque la pression du territoire porte est élevée
- B. Préviennent se rompre suite à une prise d'AINS
- C. Peuvent être traitées par du sérum glacé à travers une sonde nasogastrique
- D. Se traitent par l'intermédiaire d'une sonde de Blackmore
- E. La Sandostatine permet de les réserver en induisant une vasodilatation splanchnique

60) A propos des hémorragies digestives (R.I.)

- A. Une hématomèse signe toujours une hémorragie haute
- E. Un méléna signe toujours une hémorragie basse
- C. Une rectorragie signe toujours une hémorragie basse
- D. L'endoscopie digestive a un rôle capital
- E. Peuvent nécessiter une transfusion

Examen Immunologie 3^{ème} Année Rattrapage/ 2025**1) Parmi les techniques d'immunoprécipitation en milieu liquide, on peut citer :**

- a) Immunodiffusion double.
- b) Immunodiffusion radiale.
- c) Immunoélectrophorèse.
- d) Electrosynérèse.
- e) Test de l'anneau (Ring test).

2) Concernant les techniques d'immunoprécipitation suivantes:

- a) La Néphélométrie et la turbidimétrie doivent les complexes immuns formes sur une phase solide.
- b) La technique du LAURELL utilise un gel incorporé d'un immunum sérum.
- c) L'Immunodiffusion double (IDD) est positive s'il y a formation d'une ligne de précipitation dans la zone d'équivalence.
- d) L'Electrosynérèse consiste à déposer les réactants et a incubé 24h dans une chambre humide.
- e) L'immunoélectrophorèse donne la concentration des protéines à doser par la mesure du diamètre du cercle de précipitation.

3) Dans les techniques immuno-enzymatiques (ELISA) de type sandwich:

- a) La phase solide contient des antigènes marqués.
- b) La phase solide contient un nombre limité de sites antigènes.
- c) Les enzymes agissent sur la molécule à doser.
- d) L'antigène à doser exprime deux épitopes différents.
- e) La concentration de l'antigène à doser est directement proportionnelle à l'intensité du signal.

4) Les techniques d'immunofluorescence indirecte (IFI):

- a) Sont appliquées à la recherche d'anticorps ou d'antigènes.
- b) Utilisent des anticorps marqués par un fluorochrome.
- c) Sont quantitatives.
- d) Sont basées sur l'utilisation d'anticorps marqués, spécifiques d'antigènes solubles.
- e) Utilisent des frottis cellulaires ou des coupes de tissus pour détecter les auto- anticorps.

5) Les techniques d'agglutination :

- a) S'appliquent à la détection d'antigènes solubles.
- b) Sont utilisées pour mettre en évidence la présence des antigènes ou des anticorps.
- c) Se caractérisent toujours par la formation d'un agglutinat quand la réaction est négative.
- d) Donnent un agglutinat visible au microscope a fluorescence.
- e) Sont des techniques de réalisation facile.

6) Au cours de l'hémolyse intravasculaire :

- a) La concentration de l'orosomucoïde est franchement diminuée.
- b) L'albumine est présente un taux 'diminué.
- c) Associée à une inflammation aigue, l'haptoglobine peut être normale.
- d) L'haptoglobine est effondrée.
- e) Les immunoglobulines sont de concentration augmentées.

7) Au cours de la réaction inflammatoire, on observe une augmentation des taux sériques

- a) Des immunoglobulines au début de la réaction.
- b) De la fraction C3 du complément.
- c) De l'albumine ce qui marque une bonne nutrition.
- d) De la transferrine qui est corrélée avec l'Albumine.
- e) De l'haptoglobine et de l'orosomucoïde.

8) Les protéines de la phase aigüe de la réaction inflammatoire:

- a) Sont le témoin d'une amplification au niveau systémique de la réaction inflammatoire.
- b) Sont produites sous l'action de la cytokine IL-6.
- c) Sont détectables après l'activation du système du complément.
- d) Sont essentiellement représentées par les Gammaglobulines (IgG, IgA et IgM).
- e) Jouent un rôle important au cours de la phase d'initiation de la réaction.

9) L'atopie:

- a) Est une prédisposition génétique à produire des IgE en quantité importante.
- b) Survient lors de la pique d'insectes.
- c) Apparaît suite à une prise médicamenteuse.
- d) S'installe dans un délai de 48 à 72 heures après le second contact avec l'allergène.
- e) Expose à la survenue de pathologies typiques comme l'asthme et l'anaphylaxie.

10) Lors de la phase de sensibilisation des états d'hypersensibilité de type I :

- a) La détection des IgE spécifiques suffit à poser le diagnostic de l'allergie.
- b) L'histamine est libérée suite à la dégranulation des mastocytes et des PN basophiles.
- c) Aucune manifestation clinique n'est présente (phase cliniquement muette).
- d) Les IgE se fixent sur le récepteur de haute affinité F_εRI présent sur les mastocytes.
- e) L'allergène doit être monovalent permettant le pontage d'une molécule d'IgE.

11) L'identification de l'allergène au cours des états d'hypersensibilité de type I repose sur

- a) Le PRICK test (test cutané).
- b) Le Test de COOMBS indirect.
- c) L'intradermo-réaction (IDR) à un allergène donne.
- d) Le dosage des IgE spécifiques de l'allergène.
- e) L'immunofluorescence directe (IFD) sur un fragment biopsique de la muqueuse nasale du patient.

12) La maladie hémolytique du nouveau-né par incompatibilité foeto-maternelle dans le système « Rhésus » :

- a) Résulte du passage, transplacentaire, des IgG maternelles anti-Rhésus.
- b) Suit chez un nouveau-né rhésus négatif dont la mère est rhésus positif.
- c) Est explorée, chez le nouveau-né, par le test de Coombs indirect.
- d) Est prévenue par l'injection d'Ac anti-D, dans les 72 h après l'accouchement, chez toute femme à risque.
- e) Est explorée par le test de Coombs direct chez la mère.

13) Les états d'hypersensibilité de type II font intervenir :

- a) La cytotoxicité cellulaire dépendante du complément.
- b) La cytotoxicité cellulaire restreinte par les molécules du CMH I.
- c) Les anticorps d'isotype IgE
- d) Les anticorps d'isotype IgA.
- e) Les anticorps d'isotype IgG et IgM.

14) Le syndrome de Goodpasture est associé à :

- a) L'activation du système du complément par la voie classique
- b) La dégranulation des mastocytes avec libération de médiateurs préformes
- c) La production d'IgG dirigées contre la membrane basale glomérulaire (MBG)
- d) Une infiltration granulocytaire au niveau des reins.
- e) Un purpura thrombopénique auto-immune.

15) Les éléments intervenant dans les états d'hypersensibilité de type III sont :

- a) Les antigènes solubles multivalents.
- b) Les composants de la voie alterne du système du complément.
- c) Les polynucléaires éosinophiles.
- d) Les cellules NK
- e) Les anticorps précipitants de forte affinité pour l'antigène.

16) Le dépôt tissulaire des complexes immuns circulants dans les états d'hypersensibilité de type III fait intervenir :

- a) L'activation du système du complément avec libération d'anaphylatoxines (C3a et C5a).
- b) L'opsonisation/phagocytose par les macrophages tissulaires.
- c) L'activation des polynucléaires basophiles.
- d) La réduction de la perméabilité vasculaire.
- e) La production d'anticorps d'isotype IgE.

17) Les maladies suivantes font intervenir le mécanisme d'hypersensibilité de type III:

- a) L'allo-immunisation foëto-maternelle dans le système « rhésus »
- b) La Myasthénie (Myasthenia gravis).
- c) Les alvéolites allergiques extrinsèques.
- d) Le lupus érythémateux systémique (LES).
- e) Le Syndrome de Goodpasture.

18) Les réactions d'Hypersensibilité de type IV:

- a) Entraînent des manifestations cliniques lors de l'inhalation de l'allergène.
- b) Impliquent l'activation particulière des mastocytes et des polynucléaires basophiles.
- c) Peuvent être déclenchées par des haptènes.
- d) Peuvent être déclenchées par des agents infectieux.
- e) Apparaissent immédiatement après le premier contact avec l'antigène.

19) Les agents responsables de l'hypersensibilité de contact sont:

- a) Les sels de chrome et le nickel.
- b) Le bacille de Koch.
- c) Le bacille de la lèpre.
- d) Leishmania tropica.
- e) Les solvants organiques.

20) L'hypersensibilité granulomateuse :

- a) Résulte de la persistance de l'antigène dans les macrophages.
- b) Est la conséquence de la stimulation chronique des lymphocytes Th2.Th1.
- c) Apparaît dans un délai de 48 heures.
- d) Implique la formation de granulomes à partir des cellules géantes épithélioïdes.
- e) Intervient dans le rejet cellulaire de greffe.

21) Les éléments intervenant dans la réponse auto-immune sont :

- a) Les polynucléaires neutrophiles.
- b) Les cellules NK.
- c) Les cellules dendritiques immatures.
- d) Les lymphocytes T auto-réactifs.
- e) Les auto-anticorps d'isotype IgG.

22) Dans les étiologies des maladies auto-immunes, on incrimine:

- a) Le microenvironnement hautement inflammatoire qui favorise leur survenue.
- b) Les CPA tolérogènes qui jouent un rôle central dans la présentation de l'auto-antigène.
- c) L'association des gènes HLA qui est bien établie pour certaines maladies.
- d) L'Interleukine 17 (IL-17) qui est responsable des rémissions.
- e) Le microbiote (flore) intestinale qui n'exerce aucun effet sur la réponse auto-immune.

23) Dans les gammopathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS):

- a) Le taux du composant monoclonal est inférieur à 30 g/l.
- b) La présence de la protéine de Bence Jones est constante.
- c) La plasmocytose médullaire est supérieure à 10%.
- d) Les lésions osseuses sont absentes.
- e) La calcémie est élevée.

24) Les gammopathies monoclonales sont caractérisées par :

- a) Une hyperproduction polyclonale d'immunoglobulines.
- b) Une prolifération monoclonale plasmocytaire ou lympho-plasmocytaire.
- c) Une agammaglobulinémie.
- d) La production d'une immunoglobuline monoclonale détectable à l'électrophorèse des protéines sériques.
- e) Un syndrome tumoral constant.

25) La macroglobulinémie de Waldenstrom :

- a) Est une prolifération lympho-plasmocytaire malique.
- b) Est caractérisée par la production d'une IgM monoclonale.
- c) S'accompagne de lésions osseuses.
- d) S'accompagne d'une fuite protéique de chaînes lourdes libres.
- e) Se distingue par l'absence d'hyperviscosité sanguine.

26) Parmi les déficits immunitaires primitifs humoraux, on retrouve :

- a) La maladie de Bruton.
- b) Le déficit en CD40 ligand.
- c) Le déficit dans les sous classes des IgG.
- d) Le déficit en molécules d'adhésion.
- e) La granulomatose septique chronique.

27) Parmi les déficits immunitaires combinés sévères (DICS) on peut citer:

- a) Le déficit en chaîne gamma commune (γ₀).
- b) Le déficit en Janus kinase 3 (Jak3).
- c) Le déficit d'expression des molécules HLA de classe II.
- d) Le déficit en molécules d'adhésion.
- e) Le syndrome de Wiscott-Aldrich.

28) Un déficit héréditaire en protéines de la voie classique du complément peut être observé dans :

- a) Les maladies auto-immunes, en particulier le lupus érythémateux systémique.
- b) Les infections à répétition.
- c) Les gammapathies monoclonales.
- d) L'anémie hémolytique auto-immune.
- e) Les dermatites atopiques.

29) Le bilan immunologique de gré greffe rénale chez le donneur comporte:

- a) Le groupage ABO.
- b) Le typage HLA A, B, DR.
- c) La recherche des Ac anti HLA de classe I et de classe II.
- d) Le test de compatibilité croisée (cross match test).
- e) L'immunophénotypage T, B et NK.

30) Le rejet suraigu d'une greffe rénale :

- a) Est dû à la présence d'anticorps cytotoxiques.
- b) Peut être prévenu par la contre-indication de la greffe en cas de cross match négatif.
- c) Peut-être médié par des lymphocytes T.
- d) Peut faire intervenir des anticorps anti-HLA classe II du donneur.
- e) Peut faire intervenir des anticorps dirigés contre des antigènes du système ABO.

31) Le rejet aigu d'allogreffe :

- a) Peut être lié à la production d'anticorps anti-HLA.
- b) Est prévenu par l'épreuve de compatibilité croisée.
- c) Survient à partir de la 2^e année après la greffe.
- d) Est réversible sous un traitement immunosuppresseur.
- e) Est lié à une incompatibilité pour les antigènes de groupes sanguins ABO entre le donneur et le receveur.

32) En transplantation rénale :

- a) Le traitement immunosuppresseur n'est pas indispensable si le donneur et le receveur sont HLA identiques.
- b) Un cross match positif est une contre-indication formelle à la greffe.
- c) Les anticorps anti HLA ne sont recherchés chez le receveur qu'après la greffe.
- d) Le rejet aigu peut survenir dans les premières heures suivant la greffe.
- e) L'allo reconnaissance directe permet la génération des lymphocytes T cytotoxiques.

33) L'immunité naturelle :

- a) Est spécifique de l'antigène.
- b) Est mise en jeu immédiatement.
- c) Fait intervenir les cellules phagocytaires.
- d) Fait intervenir les lymphocytes T.
- e) Est exclusivement humorale.

34) Concernant l'immunité anti-infectieuse :

- a) L'immunité innée n'est efficace que sur les protozoaires.
- b) Le complément et les cellules phagocytaires sont efficaces contre les bactéries à multiplication extracellulaire.
- c) Les lymphocytes TCD8 cytotoxiques sont les plus efficaces contre les bactéries à multiplication extracellulaire.
- d) Les macrophages et les lymphocytes TH2 sont les plus efficaces contre les protozoaires.
- e) Les TH17 sont impliqués dans l'immunité antifongique.

35) Le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH :

- a) Peut être transmis par le sang, par contact sexuel et par voie aérienne.
- b) Se lie à la molécule CD4 grâce à sa glycoprotéine de membrane la gp120.
- c) Possède un effet cytopathogène sur les cellules NK et les polynucléaires neutrophiles.
- d) Utilise comme corécepteurs, le CCR-5 et le CXCR4.
- e) Le VIH2 est la souche responsable de l'épidémie mondiale.

36) Concernant l'infection par le VIH :

- a) Il existe au cours de la phase asymptomatique, un déficit irréversible en lymphocytes TCD4+.
- b) Les anticorps anti-VIH ne sont détectés qu'un an après la primo-infection.
- c) Les lymphocytes TCD4+ ne sont pas les seules cellules cibles du virus.
- d) Le stade SIDA est défini par un taux de lymphocytes TCD4 inférieurs à 200mm^3 .
- e) Le diagnostic de l'infection chez le nouveau-né d'une mère infectée repose sur la recherche des anticorps anti-VIH.

37) Le suivi biologique de l'infection VIH repose sur :

- a) Le dosage sérique des anticorps anti VIH 1 et 2 et de la protéine P24.
- b) Le dosage sérique de la CRP et des immunoglobulines.
- c) L'évaluation du rapport CD4/CD8.
- d) L'évaluation de la charge virale plasmatique.
- e) Le dosage des anticorps anti VIH et le rapport CD4/CD8.

38) Les vaccins utilisant des micro-organismes vivants atténués :

- a) Confèrent une immunité transitoire.
- b) Nécessitent des injections de rappels.
- c) Sont tolérés chez la femme enceinte.
- d) Ne nécessitent pas d'adjuvants.
- e) Confèrent une immunité humorale et cellulaire.

39) La séroprophylaxie :

- a) Assure une immunité spécifique active.
- b) Consiste en l'administration d'immunoglobulines à activité anticorps.
- c) Est utilisée dans la prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né.
- d) Est contre indiquée chez les immunodéprimés.
- e) Repose sur l'utilisation de vaccins sous unitaires.

40) Les immunoglobulines humaines utilisées en immuno-intervention sont :

- a) Spécifiques lorsqu'elles sont préparées à partir d'un pool plasmatique de donneurs sains.
- b) Polyvalentes lorsqu'elles sont préparées à partir d'un pool plasmatique de sujets hyperimmunisés.
- c) Utilisées par voie intraveineuse.
- d) Indiquées dans certaines maladies auto-immunes.
- e) Contre indiquées dans les déficits immunitaires

Examen Microbiologie Rattrapage/ 2025

1) Une souche isolée à partir d'un patient brûlé croît entre 45C et 60C, mais pas à 37C. Elle est classée comme :

- A. Mésophile
- B. Psychrophile
- C. Cryophile
- D. Hyperthermophile
- E. Thermophile

2) Quelle structure est responsable de la rigidité de la paroi bactérienne ?

- A. ADN
- B. Capsule
- C. Peptidoglycane
- D. Ribosome
- E. Flagelle

3) À quelle phase de la courbe de croissance bactérienne observe-t-on un dédoublement régulier de la population ?

- A. Phase de latence
- B. Phase stationnaire
- C. Phase de déclin
- D. Phase de ralentissement
- E. Phase exponentielle

4) Quelle composition est spécifique de la membrane externe des bactéries Gram négatif ?

- A. Acides téléphoniques
- B. Peptidoglycane à 90 %
- C. Lipopolysaccharides (LPS)
- D. Plasmide
- E. Flagelline

5) Lors de l'analyse d'un mutant bactérien, une purine a été remplacée par une pyrimidine. Cette mutation est appelée :

- A. Transition
- B. Transversion
- C. Délétion
- D. Duplication
- E. Tautomérisation

6) Quel mécanisme permet un transfert génétique entre bactéries par contact direct ?

- A. Transformation
- B. Conjugaison
- C. Transduction
- D. Recombinaison
- E. Transposition

7) Le diagnostic indirect d'une infection bactérienne repose sur :

- A. L'isolement de la bactérie sur gélose.
- B. La mise en évidence directe de l'ADN bactérien.
- C. La détection des antigènes bactériens dans les urines.
- D. La culture sur milieux sélectifs.

8) Parmi les éléments suivants, lequel appartient à l'étape pré-analytique du diagnostic bactériologique ?

- A. Lecture de l'antibiogramme
- B. Réalisation du prélèvement
- C. Recherche d'antigènes solubles
- D. Interprétation des résultats
- E. Ensemencement sur gélose

9) Aciclovir :

- A. Est indiquée dans le traitement de l'Herpès simplex virus.
- B. Inhibiteur de la phase de maturation.
- C. Est indiquée dans le traitement de l'hépatite C.

10) La méningite cérébro-spinale

- A. Est une maladie à transmission féco-oral.
- B. Est une maladie à déclaration obligatoire.
- C. La bactérie en cause *Haemophilus influenzae*.
- D. Le diagnostic biologique se fait sur un prélèvement d'urine.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

11) Les bactéries pathogènes opportunistes sont définies par le fait de:

- A. entraîner une maladie cliniquement bien définie et spécifique.
- B. coloniser certains organes du corps humain d'une façon permanente
- C. coloniser certains organes du corps humain d'une façon transitoire
- D. Entraîner une maladie en cas de faiblesse du système de défense immunitaire
- E. entraîner une maladie chez un individu sain

12) Le virus de l'hépatite A (VHA)

- A. Appartient à la famille des Picornaviridae
- B. Appartient au genre Hepacivirus
- C. Est transmis principalement par voie sanguine
- D. Est responsables d'hépatite aigue principalement chez l'enfant
- E. Est un virus contre lequel aucun vaccin n'existe.

13) Concernant l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC), quelles est la proposition correcte:

- A. Son dépistage se fait par détection du génome virale (RT-PCR)
- B. La persistance de détection des anticorps anti HCV > 6 mois affirme la chronicité de l'infection.
- C. Un TROD (test rapide d'orientation diagnostic) VHC positif est suffisant pour poser le diagnostic
- D. Sa transmission se fait principalement par voie sexuelle
- E. Sa forme aigue est asymptomatique dans 80% des cas.

14) La désinfection a pour but :

- A. de ralentir la multiplication des bactéries.
- B. d'empêcher la multiplication bactérienne.
- C. d'inactiver les micro-organismes indésirables.
- D. d'avoir une action brutale, lente et non spécifique
- E. de détruire des bactéries à faible pouvoir pathogène faible

15) La vaccinothérapie permet de :

- A. stimuler la réponse immunitaire humorale uniquement.
- B. mettre en jeu les défenses immunitaires par injection de sang. »
- C. Avoir une immunité immédiate par injection d'anticorps provenant d'un autre organisme.
- D. créer une mémoire immunitaire spécifique par injection d'un micro-organisme rendu inoffensif.
- E. créer une immunité immédiate par injection de globules blancs provenant d'un autre organisme.

16) La sérothérapie offre une immunité :

- A. immédiate.
- B. non spécifique.
- C. humorale et cellulaire.
- D. qui dure plus de trois mois.
- E. protectrice proche de celle de l'infection naturelle.

17) La diphtérie :

- A. n'est jamais observée en Algérie.
- B. est une infection non contagieuse.
- C. est due à un bacille à Gram positif, sporulé.
- D. est caractérisée par une période d'incubation courte.
- E. peut-être provoquée par une souche non toxigène.

18) Les staphylocoques sont des bactéries :

- A. exigeantes.
- B. ubiquitaires.
- C. cocci à Gram négatif en amas.
- D. qui poussent sur milieu hektoen.
- E. à transmission interhumaine exclusive.

19) Le diagnostic d'une leptospirose, au cours de sa phase la plus précoce, se fait par :

- A. Sérologie.
- B. Hémoculture.
- C. Recherche des leptospires dans le LCR.
- D. Recherche des leptospires dans les selles.
- E. Recherche des leptospires dans les urines.

20) Les spirochètes :

- A. sont des bactéries immobiles.
- B. se colorent bien à la coloration de Gram.
- C. sont commensales du tube digestif de l'homme.
- D. sont largement répandues dans le milieu extérieur.
- E. sont sensibles à l'action de certaines bêta-lactamines.

21) Mycobacterium tuberculosis :

- A. est sensible à l'amoxicilline.
- B. est un bacille à Gram négatif.
- C. cultive sur milieu de Chapman.
- D. peut se retrouver dans le liquide articulaire.
- E. est une bactérie anaérobie stricte a croissance lente.

22) La rougeole est une maladie causée par :

- A. Bocavirus.
- B. Rubulavirus.
- C. Pneumovirus.
- D. Morbillivirus.
- E. Metapneumovirus.

23) Les herpès virus sont des virus à :

- A. ADN monocaténaire linéaire nues.
- B. ADN monocaténaire segmente nues.
- C. ADN bicaténaire linéaire enveloppées.
- D. ADN segmenté de polarité négative nue.
- E. ADN monocaténaire circulaire enveloppées.

24) Le virus de l'hépatite B :

- A. possède un pouvoir oncogène.
- B. est résistant dans l'environnement.
- C. est commun à l'homme et à l'animal.
- D. n'est jamais transmis de la mère à l'enfant.
- E. est un virus à ADN circulaire et à capitale complexe.

25) Toutes les métróbactéries sont résistantes naturellement aux :

- A. Macrolides et Céfoxime
- B. Macrolides et acide fusidique
- C. acide fusidique et Colistine
- D. glycopeptides et aminosides
- E. glycopeptides et fluoroquinolones

26) Brucellose :

- A. Est une bactérie gram positif
- B. Il n'y a pas de techniques de diagnostic indirect pour la brucellose
- C. Fait partie de la famille des Legionellaceae
- D. Peut donner des atteintes ostéoarticulaires chez l'homme
- E. Toutes les réponses sont fausses.

27) La grande variabilité génétique du HIV

- A. est due à l'absence de système de correction chez l'intégrase
- B. le VIH1 n'est pas concerné par la variabilité génétique
- C. est due uniquement à l'infidélité de la retro-transcriptase
- D. le VIH 2 ne présente pas de sous types
- E. les virus du groupe M est le plus répandus dans le monde

28) Les rétrovirus :

- A. sont des virus à ADN double brin partiellement bicaténaire
- B. leur génome après retrotranscription s'intègre dans le génome de la cellule infectée.
- C. sont représentés par le rhabdovirus
- D. se transmettent exclusivement par voie respiratoire
- E. sont des virus non enveloppes donc résistants

29) Le diagnostic virologique direct :

- A. La recherche des IgM s'inscrit dans le cadre d'un diagnostic direct
- B. La biologie moléculaire n'est pas considérée comme une technique de diagnostic direct
- C. Le diagnostic direct n'est possible que pour les virus cultivables
- D. Le microscope optique permet de visualiser la structure du virus
- E. Le microscope électronique est un outil du diagnostic direct

30) Acinetobacter baumannii :

- A. Est une bactérie pathogène spécifique
- B. Est fréquemment impliquée dans les infections communautaires
- C. Est généralement sensible aux antibiotiques
- D. Peut être responsable de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique
- E. Est une bactérie exigeante

31) Concernant l'espèce Vibrio cholerae :

- A. Vibrio cholerae 02 est un agent du cholera
- B. Toutes les souches de l'espèce Vibrio cholerae sont toxigènes.
- C. Vibrio cholerae est une entérobactérie.
- D. Le biotype et l'origine de diarrhées sanglantes.
- E. Vibrio cholerae 0139 peut être responsable de diarrhées en eau de riz

32) Helicobacter pylori :

- A. Est un spirochète.
- B. Fait partie de la famille des Enterobacteriaceae .
- C. Est un virus oncogène.
- D. Entraîne une réaction inflammatoire de la muqueuse gastrique.
- E. Est une bactérie non cultivable.

33) Les bactéries anaérobies strictes :

- A. Ont besoin pour une croissance optimale d'une faible concentration d'oxygène.
- B. Présentent un déficit en enzyme oxydase et super oxyde dismutase .
- C. Ne font pas partie de la flore commensale.
- D. Sont toujours assures.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

34) Le tétanos :

- A. Est une maladie virale. .
- B. Est une infection endogène causée par une bactérie commensale.
- C. Est causée par un bacille gram négatif
- D. L'agent du tétanos produit deux neurotoxines.
- E. Est causée par Clostridium perfringens.

35) Le botulisme :

- A. N'est pas diagnostiquée chez le nouveau-né.
- B. Est une zoonose virale.
- C. Est causée par une bactérie bacille gram positif productrice de toxine.
- D. Est une maladie incurable.
- E. Aucune méthode de prévention n'est efficace.

36) L'Erythromycine :

- A. N'agit que sur les bactéries anaérobies strictes.
- B. Perturbe la synthèse des acides nucléiques.
- C. désorganise la structure des membranes cellulaires.
- D. appartient à la même famille d'antibiotique que la gentamicine.
- E. Est un macrolide.

37) L'imipenème :

- A. appartient à la famille des macrolides.
- B. est une molécule à spectre étroit.
- C. agit par inhibition compétitive.
- D. agit sur les entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre élargi.
- E. est actif sur les souches productrices de carbapénémases.

38) La résistance acquise aux antibiotiques :

- A. est un marqueur d'identification de la bactérie.
- B. définit le profil sauvage d'une bactérie.
- C. est présente chez toutes les souches d'une même espèce.
- D. son support génétique peut être chromosomique ou plasmidique.
- E. toutes les réponses sont fausses.

39) La résistance bactérienne naturelle à un antibiotique :

- A. est un caractère présent chez toutes les souches d'une même espèce.
- B. ne se transmet pas à la descendance
- C. détermine le phénotype de résistance acquise.
- D. n'est possible que par un seul mécanisme qui est le mécanisme enzymatique.
- E. peut être due à l'acquisition de gènes exogènes

40) Le virus est défini par les caractères suivants : (Réponse fausse)

- A. Parasitisme intracellulaire.
- B. Un seul type d'acide nucléique.
- C. Se multiplie par réplication.
- D. Le génome et l'enveloppe obligatoirement dans sa structure.
- E. Spécificité d'hôte.

Examen Cardiologie Rattrapage/ 2025**1. Tous ces items font partie du score CHADSVA sauf un : (RF)**

- A. Hypertension artérielle
- B. Diabète
- C. Insuffisance cardiaque
- D. Âge ≥ 75 ans
- E. Insuffisance rénale chronique

2. En cas de rétrécissement mitral serre symptomatique, quelle est parmi ces propositions la contre-indication a la dilatation mitrale percutanée ? (RJ)

- A. Valves mitrales souples chez un sujet jeune
- B. Dilatation mitrale de sauvetage chez une parturiente
- C. Valves mitrales calcifiées à cordages rétractés
- D. Resténose mitrale survenant quelques années après une dilatation mitrale
- E. Aucune de ces propositions n'est juste

3. Concernant le rétrécissement aortique isolé, cochez la réponse fausse : (RF)

- A. Le souffle du RAO peut irradier vers les vaisseaux du cou.
- B. La survenue d'une syncope est un symptôme habituel
- C. C'est une valvulopathie du sujet âgé le plus souvent
- D. Il existe souvent un souffle diastolique au foyer aortique associé
- E. La présence d'un angor d'effort constitue une indication opératoire

4. Les bêtabloquants valides dans l'insuffisance cardiaque chronique sont : (RF)

- A. Bisoprolol.
- B. Métoprolol.
- C. Acébutolol.
- D. Nébivolol.
- E. Carvedilol

5. Un angor typique est défini comme : (RF)

- A. Gêne constrictive de la poitrine.
- B. Irradie au cou, à l'épaule et au bras.
- C. Ne disparaît pas lors de la prise de dérivés nitrés.
- D. Favorise par l'exercice.
- E. Disparaît lors du repos

6. La durée du traitement anticoagulant d'une TVP post-opératoire est : (RJ)

- A. 1 mois
- B. 3 mois
- C. 6 mois
- D. 9 mois
- E. 12 mois

7. Dans l'Endocardite Infectieuse toutes ces situations imposent la chirurgie précoce sauf RF

- A. L'insuffisance cardiaque
- B. Endocardite infectieuse de siège mitral
- C. Embolies systémiques récidivantes
- D. Infection non contrôlée
- E. Désinsertion de prothèse

8. Toutes ces pathologies peuvent engendrer une surcharge ventriculaire de type systolique sauf une, laquelle ? (RF)

- A. Hypertension artérielle
- B. Rétrécissement aortique
- C. Coarctation de l'aorte
- D. Insuffisance mitrale
- E. Rétrécissement pulmonaire

9. Parmi les traitements de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement réduite, on cite : (RF)

- A. Les bêtabloquants
- B. Les inhibiteurs des co-transporteurs sodium glucose de type 2 (ISGLT2)
- C. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion
- D. Les diurétiques
- E. Les dérivés nitrés

10. Un patient de 50 ans est porteur d'une prothèse mitrale mécanique depuis 2020. Son ECG est en rythme sinusal. A l'échocardiographie la FEVG est normale. Il est sous antivitamine K. Quel sera la zone thérapeutique de son INR ? (RJ)

- A. 4 - 5
- B. 3 - 4.5
- C. 2.5 - 3.5
- D. 2 - 3
- E. 1.5 - 2.5

11. Quels sont les facteurs qui allongent le facteur QT ? (RJ)

- 1. L'hypokaliémie
- 2. L'hypocalcémie
- 3. Les digitaliques
- 4. L'amiodarone

A 1+3 B 1+2 C 1+2+4 D 3+4 E 2+3+4

12. La poussée hypertensive sans retentissement viscérale aigu doit être traitée : (RJ)

- 1. Par voie intraveineuse a la seringue électrique
- 2. Per os
- 3. En milieu hospitalier
- 4. En ambulatoire

A 1+3 B 1+4 C 2+3 D 2+4 E 2

13. Une Fibrillation atriale : (RJ)

- 1. Entraîne un rythme irrégulier, souvent rapide
- 2. L'onde P est positive uniquement en V1
- 3. Se complique fréquemment d'arrêt cardiaque
- 4. Peut être à l'origine d'une IC ou d'un AVC
- 5. Nécessite obligatoirement un AVK

A 1+4 B 3+5 C 2+3 D 2+4 E 1+5

14. Lors d'une endocardite infectieuse, les hémocultures : (RJ)

1. Sont systématiques en cas de fièvre associée à un souffle cardiaque.
2. Doivent contenir 10 cc de sang veineux.
3. La culture sur milieux aérobie seulement est nécessaire.
4. Leurs résultats est impératif pour commencer un traitement par antibiotiques.
5. La culture des emboles septiques après excision chirurgicale permet d'isoler le germe.

A 1+3+5 B 2+4+5 C 1+2+5 D 2+3+4 E 1+2+3

15. Les critères de gravité d'une péricardite qui conduisent à une hospitalisation sont : (RJ)

1. Une fièvre > 40° C.
2. Une tamponnade.
3. Une installation sur quelques semaines
4. L'élévation très importante des troponines cardiaques.
5. L'absence de réponse à l'aspirine ou aux AINS après au moins une semaine de traitement.

A 1+2+3 B 2+3+4 C 1+2+5 D 2+4+5 E 3+4+5

16. Dans l'ITA, toutes ces associations sont synergiques sauf une laquelle ? (RJ)

1. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
2. Inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II
3. Bêtabloquants
4. Inhibiteurs calciques
5. Diurétiques thiazidiques

A 1+2 B 2+3 C 3+4 D 1+3 E 4+5

17. ** Parmi ces cardiopathies, les quelles ne sont pas considérées comme des cardiomyopathies ? (RF)

1. Cardiopathie hypertensive au stade de dysfonction systolique du ventricule gauche.
2. Cardiopathie ischémique au stade de dilatation et dysfonction systolique du ventricule gauche.
3. Cardiomyopathie hypertrophique.
4. Cardiomyopathie restrictive.
5. Dysplasie arythmogène du ventricule droit

A 1+2 B 2+3 C 3+4 D 4+5 E 1+5

18. L'insuffisance mitrale qui complique une endocardite infectieuse est: (RJ)

1. De mécanisme type 1 de Carpentier
2. D'installation chronique
3. De mécanisme type 2 de Carpentier
4. D'installation aiguë
5. De mécanisme type 3 de Carpentier

A 4+5 B 3+4 C 1+2 D 2+3 E 1+4

19. Toutes ces actions cardiaques caractérisent les digitaliques (RJ)

1. Inotrope positif
2. Inotrope négatif
3. Dromotrope négatif
4. Bathmotrope positif
5. Bathmotrope négatif

A 2+4+5 B 1+2+3 C 3+4+5 D 2+3+5 E 1+3+4

20. Parmi ces modifications hémodynamiques, lesquelles surviennent durant la grossesse :

1. Augmentation des résistances vasculaires systémiques
2. Baisse du retour veineux
3. Augmentation du débit cardiaque
4. Augmentation de la fréquence cardiaque
5. Etat d'hypocoagulabilité

A 1+2+3 B 2+3+4 C 3+4+5 D 1+3+5 E 1+4+5

CAS CLINIQUE N°1 :

Madame Y âgée de 27 ans consulte chez vous pour une dyspnée classe II de la NYHA, une notion d'angines à répétitions, une hospitalisation à l'âge de 9 ans non documentée, avec une prescription d'une injection d'Extencilline chaque 21 jours que la patiente a arrêté de son propre chef à l'âge de 19 ans. L'examen clinique retrouve un roulement diastolique au foyer mitral associé à un éclat du B1 sans renforcement pré systolique en rapport très probablement avec un rétrécissement mitral.

Question 21 : Hormis l'échocardiographie, quel examen réaliser en priorité ? (RJ)

- A. Un ECG à la recherche d'ACFA
- B. Biologie standard
- C. Angio-TDM thoracique
- D. Echo-Doppler des membres inférieurs
- E. Dosage des D Dimères

Vous avez réalisé une échocardiographie qui retrouve les paramètres suivants : une surface mitrale anatomique à 0.9 cm², un gradient moyen à 15 mmHg, une fraction d'éjection à 55%, une pression artérielle pulmonaire systolique évaluée à 45 mm Hg
Question 22 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ? (RF)

- A. Il s'agit d'un rétrécissement mitral très serré
- B. L'examen échocardiographie est incomplet, la présence ou l'absence d'une insuffisance mitrale doit être recherchée
- C. La patiente présente une dysfonction ventriculaire gauche modérée
- D. L'examen échocardiographie est incomplet, l'appareil sous valvulaire doit être évalué
- E. La patiente présente une hypertension artérielle pulmonaire

Question 23 : Concernant votre attitude thérapeutique, quelle est la réponse fausse ? (RF)

- A. Si les critères anatomiques et cliniques sont bons, proposer une dilatation mitrale percutanée
- B. La patiente doit être mise uniquement sous traitement médical & surveillance clinique
- C. Le rythme sinusal doit être maintenu le plus longtemps possible chez la patiente
- D. A l'heure actuelle, la patiente présente une contre-indication temporaire à la grossesse
- E. La patiente doit être mise sous diurétiques de l'anse comme traitement de sa dyspnée

Vous avez instauré un traitement adéquat, la patiente n'est désormais plus symptomatique. Vous décidez de la garder sous surveillance annuelle. Trois ans plus tard, elle consulte pour une dyspnée classe III.

L'examen retrouve des crépitants aux bases, l'échocardiographie retrouve un rétrécissement mitral très serré, une insuffisance mitrale grade III, une hypertension artérielle pulmonaire. La patiente s'étant mariée il y a quelque mois, elle vous demande de l'autoriser à avoir une grossesse.

Question 24 : Quelle sera, à ce stade, votre attitude ? (RJ)

- A. Réajuster le traitement de votre patiente et la maintenir sous surveillance mensuelle
- B. Réaliser un angioscanner thoracique à la recherche d'une embolie pulmonaire
- C. Proposer la patiente pour un remplacement valvulaire chirurgical
- D. Autoriser la patiente à avoir une grossesse sous traitement médical optimal
- E. Proposer la patiente pour une dilatation mitrale percutanée

La patiente a bénéficié d'une prise en charge adéquate, vous la revoyez 5 ans plus tard dans le cadre de l'urgence. Elle est pale, très dyspnéique, la pression artérielle est imprenable, son mari vous tend une échographie abdominale faite le matin même qui retrouve un épanchement péritonéal de moyenne abondance.

Question 25 : Quel diagnostic devez-vous évoquer en priorité compte tenu des antécédents de la patiente ? (RJ)

- A. Une poussée d'insuffisance cardiaque droite.
- B. Une embolie pulmonaire à haut risque.
- C. Une allergie médicamenteuse.
- D. Un accident aux antivitamines K.
- E. Aucune de ces propositions n'est juste.

Question 26 : Quelle précaution aurait été prise afin d'éviter cette évolution ? (RJ)

- A. Une augmentation des doses des diurétiques
- B. Une surveillance rigoureuse de l'INR cible
- C. Un contrôle plus strict de la fréquence cardiaque
- D. Un maintien permanent du rythme sinusal
- E. Aucune de ces propositions n'est juste.

CAS CLINIQUE 2 :

Mr M.A âgé de 48 ans consulte aux urgences suite à une douleur thoracique constrictive retrosternale apparu le matin après sa prière et évoluant sans répit depuis 4 heures, l'interrogatoire retrouve une notion de tabagisme actif à raison de 20 paquet/année. Les constantes hémodynamiques sont bonnes.

Question 27 : Quelle est votre attitude immédiate ? (RJ)

- A. Rassurer et libérer le patient.
- B. Demander une TDM thoracique
- C. Faire un téléthorax.
- D. Faire un ECG dans les 10 min
- E. Faire un ECG dans les 30 min

Question 28 : L'ECG retrouve une fréquence cardiaque a 83 bpm et des ondes T négatives et symétriques de V1 à V4 ; vous décidez de : (RJ)

- A. Demander une échocardiographie.
- B. Hospitaliser le patient
- C. Demander un coroscanner.
- D. Libérer le patient
- E. Faire une épreuve d'effort.

Question 29 : Quel diagnostic évoquez-vous en premier ? (RJ)

- A. SCA ST +
- B. Péricardite
- C. SCA ST -
- D. Hypothyroïdie
- E. Embolie pulmonaire
- E. TSH

Question 31 : Le traitement médical en urgence est : (RJ)

- A. Fibrinolyse.
- B. Dérivés nitrés et bêtabloquants
- C. Inhibiteur de l'enzyme de conversion + iSGLT2
- D. Aspirine + Héparine sous cutanée
- E. Aspirine + Clopidogrel + Héparine sous cutanée

Question 32 : Le dosage du bilan demande est positif, quelle est votre attitude ultérieure ? (RJ)

- A. Il s'agit d'un patient à bas risque qui ne nécessite pas de prise en charge.
- B. Vous demandez une épreuve d'effort.
- C. C'est un patient à haut risque, réaliser une coronarographie dans les 24 h
- D. Vous réalisez une thrombolyse
- E. Vous faite un dosage d'autres marqueurs de nécrose myocardique

Question 33 : Quelle est l'ordonnance de sortie de ce patient ? (RJ)

- A. Aspirine 100 + Clopidogrel 75 + Atorvastatine 10 + Ramipril 5 + Bisoprolol 5
- B. Enoxaparine 0.8 ml + Clopidogrel 75 + Atenolol 100 + Atorvastatine 80
- C. Bisoprolol 10 + Ramipril 10 + Atorvastatine 80 + Aspirine 100 + Clopidogrel 75
- D. Molsidomine 2 + Clopidogrel 75 + Atorvastatine 40 + Atenolol 100 + Ramipril 5
- E. Bisoprolol 10 + Ramipril 5 + Atorvastatine 20 + Aspirine 100 + Clopidogrel 75

Question 30 : Quelle est l'examen biologique recommande chez ce patient ? (RJ)

- A. FNS
- B. D-dimères
- C. VS & CRP
- D. Troponines doses 2 fois à 1h d'intervalle.
- E. TSH

CAS CLINIQUE N° 3 :

De garde aux urgences médicales, vous recevez Mme T.R. âgée de 75 ans, pour palpitations et dyspnée aigue évoluant depuis 4 jours. L'histoire est celle d'une dyspnée d'installation rapidement progressive sur les 4 derniers jours, évoluant jusqu'à une orthopnée. A l'arrivée, la pression artérielle est à 165/95 mmHg, la fréquence cardiaque à 105/min, la saturation en air ambiant a 88 % et la température a 37,2 C. L'auscultation pulmonaire révèle des râles crépitants aux deux tiers basaux des deux hemichamps pulmonaires. Le reste de l'examen physique est sans particularité.

L'électrocardiogramme (ECG) réalisé à l'entrée est le suivant :

Question 34 : Le diagnostic exact concernant cette situation clinique est: (RJ)

- A. Insuffisance cardiaque gauche
- B. Insuffisance cardiaque droite
- C. Insuffisance cardiaque globale
- D. Insuffisance respiratoire aiguë
- E. Embolie pulmonaire aigue

Question 35 : Le diagnostic exact concernant cet ECG est : (RJ)

- A. Tachycardie ventriculaire
- B. Fibrillation atriale
- C. Tachycardie sinusale avec BBG
- D. Tachycardie sinusale avec BBD
- E. Fibrillation atriale avec BBG

Question 36 : Sur la radiographie thoracique, quels sont les signes évocateurs de votre diagnostic initial ? (RF)

- A. Redistribution de la vascularisation pulmonaire en faveur des sommets
- B. Arc inferieur gauche saillant
- C. Indice cardio-thoracique supérieur à 0,5
- D. Images floconneuses péri hilaires
- E. Diminution de la vascularisation pulmonaire

Question 37 : Les traitements suivants doivent être entrepris rapidement : (RJ)

- 1. Traitement vasodilatateur par dérivés nitrés
 - 2. Traitement diurétique par furosémide
 - 3. Traitement par Aspirine + Clopidogrel
 - 4. Angioplastie coronaire
 - 5. Traitement ralentisseur par bêtabloquant
- A. 1+3 B. 2+5 C. 3+5 D. 1+2 E. 3+4

L'évolution est rapidement favorable sous traitement d'urgence.

L'échographie cardiaque montre un ventricule gauche très dilaté, avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) à 27 %. Il n'y a pas de valvulopathie significative. La patiente vous informe qu'en réalité elle présente un diabète de type 2 et une HTA qu'elle a négligés ces cinq dernières années. Elle n'a jamais présenté de douleur thoracique auparavant. Le bilan biologique est normal.

Question 38 : Quelles sont les étiologies possibles à évoquer en premier ? (RJ)

1. Cardiopathie ischémique
 2. Cardiopathie hypertensive
 3. Cardiopathie rythmique
 4. Cardiopathie valvulaire
 5. CMD primitive
- A. 1+2 B. 2+4 C. 2+5 D. 1+5 E. 3+2

Question 39 : Quel traitement de fond allez-vous mettre en place chez cette patiente ? (RF)

- A. iSGLT2
- B. Bétabloquants
- C. Anti-aldostérone
- D. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
- E. Dérivés nitrés

Question 40 : Si malgré un traitement médical optimal la patiente reste toujours symptomatique, que proposez-vous ? (RJ)

- A. Coronarographie
- B. Thérapie de resynchronisation cardiaque
- C. Transplantation cardiaque
- D. Défibrillateur automatique implantable
- E. Stimulation cardiaque définitive

Examen Hémato Onco Rattrapage/ 2025**Partie théorique :**

1- Une fille âgée de 09 ans consulte pour une fièvre, des adénopathies cervicales de 02 cm et un purpura pétéchiol évoluant depuis 2 semaines, le diagnostic évoqué est le suivant :

- A-Aplasia médullaire.
- B-Leucémie Lymphoïde Chronique.
- C-Purpura thrombopénique auto-immun.
- D-Leucémie Aigue Lymphoblastique.
- E-Maladie d'hodgkin.

2- Quels sont vos arguments ?

- 1-Le mode d'installation.
 - 2-Le syndrome infectieux.
 - 3-Les adénopathies périphériques.
 - 4-L'âge.
 - 5-Un syndrome hémorragique.
- A) 1+2+3 B) 1+3+4+5 C) 1+2+4+5 D) 1+2+3+5 E) 1+2+3+4+5

3- Toutes ces complications se voient dans ce cas sauf :

- A- Une hyper uricémie.
- B-Une CIVD.
- C-Une infection sévère.
- D-Une anémie microcytaire régénérative.
- E-Une insuffisance rénale.

4- Quelles pathologies parmi les suivantes peuvent être responsables de douleurs osseuses?

- 1- Drépanocytose
 - 2- Leucémie aigue lymphoblastique
 - 3-L'Hémophilie
 - 4- Leucémie lymphoïde chronique
 - 5-Myélome multiple
- A) 1+3+4; B) 1+2+5 ; C) 1+3+5; D) 2+3+5 ; E) 3+4+5

5- Une thrombopénie est observée au cours de :

- 1- La leucémie aigüe.
 - 2- La leucémie lymphoïde chronique stade B.
 - 3- L'Hémophilie B.
 - 4- Coagulation intra vasculaire disséminée.
 - 5- L'hypersplénisme.
- B-1+2+3 C-2+3+4 D-1+2+5 E-3+4+5

6- Quelle (s) est (sont) parmi ces maladies celle (s) qui est (s) en rapport avec un trouble de l'hémostase primaire :

- 1-L'hémophilie
 - 2-Maladie de Von Willebrand
 - 3-Insuffisance hépatocellulaire
 - 4-Purpura thrombopénique immunologique
 - 5-Fibrinolyse aigue primitive
- A-1+2 B-1+3 C-2+3 D-2+4 E-3+4

7- Parmi les propositions suivantes lesquelles sont des facteurs vitamine K dépendants :

- 1- Facteur V
 - 2- Facteur IX
 - 3- Prothrombine
 - 4- Facteur VII
 - 5- Fibrinogène
- A-1+4+5; B-1+2+5; C-2+3+5; D-1+3+4; E-2+3+4

8- Parmi les propositions suivantes, préciser laquelle (ou lesquelles) s'accompagnent d'un Allongement a la fois du temps de céphaline Activé (TCA) et du temps de Quick (TQ) :

- 1- Déficit en vitamine K
 - 2- Déficit en facteur V
 - 3- Un auto anticorps anti facteur VIII
 - 4- Une insuffisance hépatocellulaire
 - 5- Déficit en facteur XIII
- A-1+2+3 B-1+2+4 C-3+4+5 D-1+3+5 E-1+4+5

9- Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont compatibles avec le diagnostic d'une carence en fer ?

- 1- Anémie macrocytaire hypochrome régénérative.
 - 2- Anémie microcytaire hypochrome arégénérative.
 - 3- Ferritine effondrée.
 - 4- Anémie macrocytaire normochrome arégénérative.
 - 5- Ferritine normale ou augmentée.
- A) 1+3; B) 1+5; C) 2+5; D) 2+3; E) 4+5

10- Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont compatibles avec le diagnostic d'une anémie inflammatoire :

- 1-Anémie microcytaire normochrome régénérative
 - 2-Anémie macrocytaire hypochrome arégénérative
 - 3-Ferritine normale
 - 4-Ferritine élevé
 - 5-Anémie microcytaire normochrome, CRP positive, VS accélérée
- A-2+3+4 B-1+2+3 C-3+4+5 D-2+4+5 E-1+4+5

11- Dans la carence en acide folique :

- 1- le VGM est supérieur à 100 fl
 - 2- la CCMH est basse.
 - 3- il existe une hyperleucocytose
 - 4- Une thrombopénie peut se voir
 - 5- Les troubles neurologiques sont présents
- A-1+2 B-1+4 C-2+4 D-3+5 E-1+5

12- Au cours de la maladie de Biermer tous ces signes peuvent se voir :

1-Le syndrome anémique est associé à des signes digestifs

2- L'anémie est macrocytaire régénérative

3-Taux de vitamine B12 est effondré

4-Moelle cellulaire, mégalo-blastique

5-Les signes neurologiques sont présents

A) 1+2+3+4 ; B) 1+2+4+5 ; C) 2 +3+4+ 5 ; D) 1+ 2 + 4 +5 ; E) 1+3+4+5

13- Le frottis sanguin peut montrer :

1-Des cellules blastiques dans les leucémies aiguës.

2-Des cellules en faux dans la drépanocytose

3-Une hypochromie sur les globules rouges dans la carence en vitamine B12

4-une myélémie inférieure à 10% dans la leucémie myéloïde chronique

5-Des cellules de Reed Sternberg dans la maladie de Hodgkin

A-2+3 B-4+5 C-1+2 D- 2+5 E-1+3

14- Le chromosome Philadelphie est le résultat :

1-Translocation réciproque et équilibrée entre les bras longs des chromosomes 9 et 22.

2-Translocation non réciproque entre les bras longs des chromosomes 9 et 22.

3-Inversion entre les bras longs des chromosomes 9 et 22.

4-Cette translocation aboutit à un chromosome 22 très court et un chromosome 9 allongé.

5-Cette translocation aboutit à un chromosome 22 très long et un chromosome 9 court.

A - 1+2 B - 1+3 C - 4+5 D - 3+4 E -1+4

15- Au cours d'une Leucémie Myéloïde Chronique, tous ces signes sont présents :

1-Le Chromosome Philadelphie.

2-Myélémie > 20%.

3-Des adénopathies.

4-Hyperlymphocytose.

5-Une Splénomégalie.

A-1+2+3 B-1+4+5 C- 1+2+5 D- 1+3+5 E-1+3+4

16- Toutes ces complications peuvent se voir dans la leucémie lymphoïde chronique sauf :

A- Les infections.

B- La transformation en leucémie myéloïde chronique.

C- La transformation en lymphome de haut grade de malignité.

D- L'anémie hémolytique auto-immune.

E- L'aplasie sévère post chimiothérapie.

17- Les circonstances pouvant déclencher une crise vasoocclusive chez un patient atteint d'une Drépanocytose homozygote sont:

1-L'infection.

2-L'hypoxie.

3-Le stress.

4-L'hyperhydratation.

5-L'anémie.

A-1+2+3 B-2+3+4 C-1+3+5 D-3+4+5 E-2+4+5

18- La maladie de Cooley :

- 1- Est une forme de drépanocytose homozygote.
 - 2- Est caractérisée par la déformation en faucille des hématies.
 - 3- Est une thalassémie majeure.
 - 4- Entraîne un ictère à bilirubine mixte.
 - 5- Le diagnostic est posé chez le nourrisson.
- A-1+4 B-2+3 C-1+2 D-3+4 E-3+5

19- Dans le déficit en G6PD :

- A-Le tableau réalise est celui d'une hémolyse aigue post transfusionnelle.
- B-Le diagnostic est pose par la résistance globulaire qui est basse.
- C-Est une maladie génétique de transmission autosomale récessive.
- D-Le dosage de la G6PD se fait à distance de l'épisode hémolytique.
- E-Est une anémie hémolytique congénitale qui touche le garçon.

20- L'anémie hémolytique auto Immune est observée au cours de la (ou des) situation(s) suivante (s) :

- 1- La leucémie lymphoïde chronique.
- 2- La maladie hémolytique du nouveau-né.
- 3- Le porteur de prothèse cardiaque.
- 4- Le syndrome d'Evans.
- 5- Le syndrome hémolytique urémique (SHU).

A-1+4 B-2+3 C-3+4 D-2+4 E-4+5

21- Un sujet de groupe sanguin : O Rhésus positif cc ee Kell positif peut être transfusé par :

- 1-O Rhésus négatif cc Ee Kell negatif.
- 2-O Rhésus positif CC Ee Kell positif.
- 3-O Rhésus positif cc ee Kell positif.
- 4-O Rhésus positif cc ee Kell négatif.
- 5-O Rhésus positif CC ee Kell positif.

A-1+2 B -3+4 C -4+5 D - 1+3 E -1+4

22- Une femme de groupe A Rh+ positif épousa un homme de groupe sanguin B Rh- positif. Le groupe Sanguin de leurs enfants est le suivant :

- A-O Rh+
- B-A Rh+
- C-A Rh-
- D-O Rh-

E-Toutes ces réponses sont justes

23- Le myélome multiple est une hémopathie maligne caractérisée par:

- 1-Un pic monoclonal à l'électrophorèse des protides sériques.
- 2-Une insuffisance hépatique.
- 3-Une anémie normocytaire régénérative.
- 4-Une insuffisance rénale.
- 5-Une hypercalcémie.

A-1+3+5 B-2+4+5 C-1+2+3 D-1+4+5 E-2+3+5

24- Parmi les signes suivants, lesquels caractérisent la maladie de Waldenstrom :

- 1- Des géodes osseuses.
 - 2- Un pic monoclonal de type IgM.
 - 3- Une lymphoplasmocytose médullaire.
 - 4- Une myélofibrose médullaire.
 - 5- Une hypercalcémie
- A-2+3 B-3+5 C- 1+2 D-3+4 E-1+5

25- Les étiologies de thrombopathie acquise :

- 1- Prise d'Aspirine et d'AINS.
 - 2-L'Hémophilie A.
 - 3- Le syndrome de Bernard Soulier.
 - 4- La thrombocythémie essentielle.
 - 5- La leucémie myéloïde chronique.
- A-3+4+5 B-1+4+5 C-2+3+5 D-1+2+3 E6 1+3+4

26- Le traitement de la crise vaso occlusive est basé sur les mesures suivantes sauf :

- A-Réchauffement
- B- Réhydratation
- C-Oxygénothérapie
- D-Corticothérapie
- E-Antalgiques (paracétamol, AINS, morphine)

27- La séquestration splénique :

- A-Est une complication chronique de la Beta thalassémie.
- B-Se manifeste par une augmentation brutale douloureuse de volume de la rate.
- C-S'accompagne d'une augmentation du quotient transfusionnel chronique.
- D-Une complication bénigne de la drépanocytose.
- E-La splénectomie est le traitement d'urgence.

28- La drépanocytose homozygote : RF

- A-Est une anémie hémolytique congénitale.
- B-Characterisée par un symptôme majeur qu'on appelle crise vaso occlusive.
- C-Présence d'hémoglobine S majoritaire à l'électrophorèse des protéides.
- D-Le syndrome thoracique aigu est une complication grave de la maladie.
- E-Characterisée par la disparition de la rate après l'âge de 10 ans.

29- La ponction ganglionnaire est réalisée systématiquement dans les situations suivantes :

- 1-Une adénopathie cervicale isolée chronique chez un sujet jeune.
 - 2-Une poly adénopathie chronique généralisée chez un sujet âgé.
 - 3-Une adénopathie cervicale haute chez un nourrisson qui présente une angine pultacée.
 - 4-Des adénopathies cervicales chez un patient jeune qui présente une leucémie aiguë lymphoblastique.
 - 5-Une adénopathie cervicale persistante après traitement antituberculeux.
- A-2+3 B-1+5 C-1+4 D-2+5 E-3+4

30- Toutes ces complications peuvent se voir au cours de la LMC sauf :

- A-Hyper uricémie.
- B-Thrombose.
- C-Hémorragie.
- D-Transformation en leucémie aigue.
- E-L'anémie hémolytique auto immune.

31- Le myélogramme est réalisé dans tous ces cas, sauf :

- 1-L'aplasie médullaire.
 - 2-En cas de thrombopénie.
 - 3-Les Leucémies Aigues Lymphoblastiques.
 - 4-L'hémophilie.
 - 5-La Leucémie Myéloïde Chronique pour le diagnostic.
- A-1+4; B-4+5; C- 2+3; D-3+4; E- 1+5

32- Parmi les anomalies biologiques suivantes, lesquelles sont typiquement observées dans les anémies hémolytiques ?

- 1-Augmentation des LDH
 - 2-Taux de réticulocytes $< 120000/\text{mm}^3$
 - 3-Haptoglobine basse
 - 4-Diminution des érythroblastes médullaires adaptative à l'hémolyse
 - 5-Bilirubine libre augmentée
- A-1+2+3; B- 1+2+4; C- 1+2+5; D- 1+3+4; E- 1+3+5

33- Pourquoi standardiser les évaluations en oncologie ?

- A- Pour réduire le temps de consultation.
- B- Faciliter la communication entre professionnels et comparer les résultats en recherche.
- C- Eviter les erreurs de diagnostic.
- D- Simplifier la prise en charge des patients asymptomatiques.
- E- Limiter l'utilisation des traitements agressifs.

34- Un patient ECOG PS 3 est défini par :

- A- Une activité normale sans symptômes.
- B- Des symptômes légers n'altérant pas les activités quotidiennes.
- C- Une dépendance partielle, alité $>50\%$ de la journée.
- D- Une autonomie totale mais avec fatigue modérée.
- E- Un décès lié au cancer.

35- Un IMC de 17 kg/m^2 chez un patient cancéreux indique :

- A- Obésité.
- B- Surpoids.
- C- Corpulence normale.
- D- Dénutrition.
- E- Sarcopénie isolée.

36- Une réduction de 35 % du diamètre des lésions cibles correspond à

- A- Maladie stable.
- B- Réponse partielle.
- C- Réponse complète.
- D- Progression tumorale.
- E- Réponse non évaluable.

37- Quel outil est adapté pour évaluer la douleur chez un enfant de 6 ans ?

- A- Echelle numérique.
- B- Echelle des visages.
- C- CTCAE.
- D- Classification TNM.
- E- Dosage de la CRP.

38- Quel type de radiothérapie implique l'implantation de sources radioactives directement dans la tumeur

- A- Radiothérapie externe.
- B- Curiethérapie.
- C- Radiothérapie stéréotaxique.
- D- Toutes ces réponses
- E- Cybernife

39- Concernant la chirurgie du cancer, quelles propositions sont exactes?

- 1- La chirurgie d'intervalles est réalisée avant tout traitement néoadjuvant.
 - 2- La chirurgie des métastases n'est jamais proposée en cas de maladie oligo-métastatique.
 - 3- La chirurgie prophylactique peut inclure une double mastectomie en cas de mutations BRCA1 et 2.
 - 4- La chirurgie palliative vise à soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie.
 - 5- La chirurgie de reconstruction est toujours réalisée pendant l'intervention initiale.
- A-1-2-6 B-3-4 C-2-3-4 D-1-3-4 E-3-4-5

40- Parmi les propositions suivantes concernant la radiothérapie, lesquelles sont vraies ?

- 1- La curiethérapie implique l'utilisation d'un accélérateur de particules externe.
 - 2- La radiothérapie métabolique utilise des substances radioactives administrées par voie orale ou intraveineuse.
 - 3- La radiothérapie conformationnelle à modulation d'intensité (IMRT) permet une distribution de dose moins précise que la radiothérapie classique.
 - 4- La protonthérapie est particulièrement adaptée aux tumeurs superficielles.
 - 5- La radiothérapie stéréotaxique est une technique de haute précision pour les petites tumeurs.
- A-1-3-4 B- 2-5 C-1-4-6 D- 2-3-5 E-3-4-5

41- Concernant la chimiothérapie, quelles propositions sont exactes ?

- 1- La chimiothérapie est efficace uniquement sur les cellules en phase G0 du cycle cellulaire.
- 2- La polychimiothérapie est rarement utilisée en pratique clinique.
- 3- Les doses de chimiothérapie sont calculées en fonction de l'âge du patient uniquement.
- 4- La chimiothérapie peut être utilisée en association avec la radiothérapie comme radio-sensibilisant.
- 5- La toxicité de la chimiothérapie est toujours réversible.

A-1; B-3-5 C-4 D-1-3-4 E-2-3-5

42- Comment les thérapies ciblées à base d'anticorps monoclonaux agissent-ils dans le traitement d'ancre ?

- A- Ils bloquent des molécules à l'intérieur des cellules cancéreuses.
- B- Ils se fixent à des cibles à la surface des cellules tumorales ou dans leur environnement.
- C- Ils inhibent la production d'hormones stimulant la croissance tumorale.
- D- Ils délivrent des substances radioactives directement aux cellules cancéreuses.
- E- Ils stimulent le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules cancéreuses.

43- Concernant le lymphome de Hodgkin : RF

- A- Il touche surtout les jeunes adultes.
- B- Il peut s'accompagner de signes généraux (fièvre, sueurs, amaigrissement).
- C- Il se caractérise par des cellules de Reed-Sternberg.
- D- Il exprime typiquement CD15 et CD30
- E- Il dérive d'un lymphocyte T mémoire.

44- Le lymphome du lymphome MALT : RF

- A- Il peut régresser après traitement d'H. pylori
- B- Il touche souvent la muqueuse gastrique
- C- Il dérive de lymphocytes T
- D- Il appartient aux lymphomes non hodgkiniens
- E- Il est généralement de bas grade

45- Le lymphome non hodgkinien le plus fréquent est : RJ

- A- Lymphome folliculaire
- B- Lymphome a cellules du manteau
- C- Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL)
- D- Lymphome de Burkitt
- E- Lymphome T angio-immunoblastique.

Partie pratique :

Cas clinique 1 : Une femme de 28 ans, consulte pour une toux sèche persistante, dyspnée et prurit. A l'examen clinique : polyadénopathies cervicales

La biopsie ganglionnaire montre un infiltrat inflammatoire avec présence de cellules de Reed Sternberg CD30 positif et CD 15 positif.

A la tomodensitométrie thoraco abdominale : masse médiastinale antérieure de 11 x 7 cm, un épanchement pleural bilatéral, une hépatomégalie nodulaire et une splénomégalie.

A l'hémogramme : GB =18 500/mm³ (PNN : 15 500/mm³ lymphocytes : 3000/mm³), Hb= 8 g/dl Plaquettes= 450 000/mm³ VS : 120 mm/H1.

46- Quel est votre diagnostic ?

A-Lymphome folliculaire.

B-Lymphome de Hodgkin.

C-Lymphome a grandes cellules B.

D-Lymphome de Burkitt.

E-Lymphome T.

47- Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez- vous pour compléter le bilan d'extension ?

1-TEP Scan.

2- Ponction lombaire

3-Fibroscopie gastrique.

4-Ponction des nodules hépatiques.

5-Ponction pleurale.

A-1+3 B-1+2 C-1+4 D-1+5 E-1

48- Classez cette maladie selon la classification anatomo-clinique :

A-Stade IV Ab

B-Stade IV Aa

C-Stade III Ba

D-Stade III Ab

E-Stade II Ab

49- Le bilan pré thérapeutique chez cette patiente comporte les examens suivants :

1-Un bilan thyroïdien.

2-Une sérologie de l'hépatite B, C et HIV.

3-Une PCR Covid 19.

4-Echographie mammaire.

5-Un test de grossesse.

A-1+3+5 B-2+4+5 C-1+2+3 D-2+3+4 E-2+3+5

50- En l'absence de réponse au traitement initial, quel traitement proposez- vous à cette patiente ?

1-Chimiothérapie de rattrapage.

2-Radiothérapie.

3-Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

4-Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

5-Radiothérapie + Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

A-1+2 B-2+3 C-1+3 D-3+4 E-1+5

Examen Maladies Infectieuses Rattrapage/ 2025

1- Parmi les propositions suivantes concernant les sepsis à *Staphylococcus aureus* (Les RJ)?

- A. Elles sont toujours d'origine nosocomiale
- B. Elles peuvent être secondaires à une porte d'entrée cutanée
- C. Elles peuvent être responsables d'endocardites
- D. *Staphylococcus aureus* ne possède pas de coagulase
- E. L'amoxicilline constitue l'antibiothérapie de première intention

2- Quel traitement antibiotique est recommandé en première intention pour une arthrite aiguë à *S. aureus* *meti-R* ? (1RJ)

- A. Céfazoline IV
- B. Vancomycine IV
- C. Amoxicilline IV
- D. Cotrimoxazole IV
- E. Céfotaxime IV

3- Quel est le rôle des AINS dans le traitement de l'érysipèle ? (1RJ)

- A- Ils sont utilisés pour réduire l'inflammation cutanée.
- B- Ils sont utilisés pour réduire la douleur.
- C- Ils sont utilisés pour prévenir les récurrences.
- D- Ils sont utilisés pour prévenir le risque de thrombose.
- E- Ils ne sont pas utilisés dans le traitement de l'érysipèle

4- Quel bilan complémentaire indispensable pour confirmer le diagnostic d'un érysipèle ? (1RJ)

- A. Hémocultures
- B. Biopsie cutanée avec mise en culture
- C. Échographie de la jambe
- D. Scanner de la jambe
- E. Aucun

5- Quel signe clinique est-il défini par une flexion involontaire des membres inférieurs à la flexion de la nuque ? : (1RJ)

- A- Signe de Kernig
- B- Signe de Brudzinski
- C- Signe de Babinski
- D- Signe de Romberg
- E- Signe de Lermierre

6- Dans quelles situations une TDM cérébrale doit-elle précéder la réalisation de la ponction lombaire ? (1RJ)

- A- Céphalées intenses rebelles aux antalgiques
- B- Photophobie marquée
- C- Raideur de la nuque importante
- D- Vomissements incoercibles en je
- E- Convulsions

7- Concernant Neisseria meningitidis, les réponses exactes ? (Les RJ)

- A- La contamination par cette bactérie est interhumaine
- B- Il n'existe pas des porteurs sains
- C- Il colonise le rhinopharynx
- D- Il n'existe pas de un vaccin contre cette bactérie
- E- Les méningites à méningocoque peuvent être traitées par les macrolides

8- Quelle est la conduite à tenir en cas de purpura fulminant ? (Les RJ)

- A- Réalisation d'une imagerie cérébrale en urgence
- B- Administration urgente d'antibiotiques sans attendre la ponction lombaire
- C- Attente des résultats de la PL avant d'initier le traitement
- D- Remplissage vasculaire
- E- Administration précoce d'immunoglobulines intraveineuses

9- Quelle est la première cause de méningite virale chez l'adulte ? (1RJ)

- A- Herpès Simplex Virus
- B- Entérovirus
- C- Arbovirus
- D- Neisseria meningitidis
- E- HIV

10- Le choléra : (1RJ)

- A. Contagieuse à transmission aérienne
- B. Le diagnostic est confirmé par les hémocultures
- C. Responsable de selles glairo-sanglantes
- D. Provoque un état de déshydratation aigue sévère
- E. Elle se manifeste par une diarrhée fébrile

11- En cas de morsure de la main par un animal sauvage : (Les RJ)

- A. Suturer rapidement la plaie
- B. Lavage de la plaie
- C. Vaccin antirabique seul
- D. Sérothérapie + vaccin antirabique
- E. L'antibiothérapie n'est pas recommandée

12- La rage : (1RJ)

- A. Transmise à l'homme en Algérie principalement par les chats
- B. Due à un virus diffusant dans l'organisme par voie sanguine a partir de la porte d'entrée
- C. La rage humaine déclarée peut être traitée par des provisions IV d'immunoglobulines antirabiques
- D. La rage humaine déclarée est mortelle dans 80 % des cas
- E. Se manifeste par un tableau d'encéphalomyélite mortelle

13- Concernant le zona : (Les RJ)

- A. L'éruption est habituellement précédée de douleurs dans le même territoire
- B. C'est une primo-infection à VZV
- C. Les séquelles douloureuses sont à craindre surtout chez le sujet âgé
- D. Diagnostic essentiellement biologique
- E. L'éruption est bilatérale dans les métamères symétriques

14- Au cours de la phase d'invasion du tétanos : (Les RJ)

- A. Le patient présente une contracture bilatérale et douloureuse des masséters.
- B. Le patient est fébrile
- C. L'examen physique objective une atteinte méningée
- D. Le patient est dyspnéique
- E. Les muscles para-vertébraux du rachis cervical sont contractés

15- Quelle est la couverture vaccinale recommandée pour prévenir la diphtérie et le tétanos chez l'adulte ? (1 RJ)

- A. Vaccination annuelle
- B. Vaccination tous les 5 ans
- C. Vaccination tous les 10 ans
- D. Une dose unique de vaccin à vie
- E. Vaccination à chaque exposition au risque

16- La Fièvre au cours de la Brucellose : (1RJ)

- A. Est une fièvre en plateau
- B. Est une fièvre oscillante
- C. Est une fièvre ondulante
- D. Est une fièvre intermittente.
- E. Une fièvre tierce

17- Brucellose aigue : Sur quel argument arrêtez-vous votre traitement? (1RJ)

- A. Apyrexie stricte depuis 1 semaine
- B. Négativation du sérodiagnostic de Wright
- C. Après 6 semaines de traitement
- D. Négativation de l'hémoculture
- E. Aucune de ces propositions

18- À propos de la leptospirose : (Les RJ)

- A. Il n'existe pas de vaccin à ce jour
- B. Le réservoir est le chien
- C. Peut-être déclaré comme maladies professionnelles
- D. Le diagnostic se fait par hémocultures
- E. La forme pseudo grippale est la plus fréquente

19- Parmi les propositions concernant la leptospirose : (Les RJ)

- A. L'efficacité de l'antibiothérapie n'est pas bien démontrée dans les formes graves
- B. Une antibiothérapie précoce prévient probablement le passage à une forme grave
- C. La doxycycline est le traitement de référence dans les formes graves
- D. La PCR en temps réel est l'examen de référence durant la première semaine des symptômes
- E. La sérologie ELISA IgM permet le diagnostic en 48 h des symptômes

20- La fièvre boutonneuse méditerranéenne : (1RJ)

- A. Est une septicémie à point de départ lymphatique
- B. L'absence de la tache noire permet d'éliminer le diagnostic
- C. Peut donner une méningite à liquide clair.
- D. Donne une éruption maculopapuleuse généralisée épargnant les paumes des mains, les plantes des pieds.

21- Comment confirmer le diagnostic de fièvre boutonneuse méditerranéenne en pratique courante ? (1RJ)

- A. Hémocultures
- B. PCR
- C. Sérologie Weil et Felix
- D. Immunofluorescence indirecte
- E. Clinique

22- Devant une varicelle chez un enfant, indiquez les mesures à prendre : (Les RJ)

- A. Antihistaminiques pour le prurit.
- B. Isolement pendant 30 jours
- C. Traitement antibiotique
- D. Application d'une solution antiseptique sur les vésicules rompues
- E. Traitement symptomatique par l'aspirine

23- Les sepsis à BGN: (Les RJ)

- A. Sort exclusivement nosocomiales.
- B. Le risque d'évoluer vers un choc septique est rare.
- C. Ont souvent une porte d'entrée urinaire et/ou digestive
- D. Concernant exclusivement les patients immunodéprimés.
- E. E. coli est le principal germe responsable des sepsis communautaires

24- La fièvre typhoïde, au 2ème septénaire, elle se manifeste par : (Les RJ)

- A. Une fièvre en plateau
- B. Une dissociation pouls-température
- C. Présence de la tache noire
- D. Une fosse iliaque droite gargouillante
- E. Une constipation

25- Le diagnostic d'urgence du paludisme repose sur les techniques suivantes : (Les RJ)

- A. Goutte épaisse
- B. Hémocultures
- C. Sérologie
- D. Frottis sanguin
- E. Coproculture

26- VIH/SIDA : (1RJ)

- A. Un sujet séropositif est atteint du SIDA
- B. Le VIH se transmet uniquement au cours de rapports sexuels non protégés
- C. La période asymptomatique correspond à une disparition temporaire (de 1 à 10 ans) du VIH dans l'organisme.
- D. Un sujet séropositif n'est pas malade mais il est contagieux
- E. La primo infection est toujours symptomatique

27- Quels sont les groupes de population qui présente le plus grand risque d'infection VIH ? (Les RJ)

- A. Les HSH
- B. Les hétérosexuels
- C. Les usagers de drogues par voie intraveineuse
- D. Les adultes jeunes
- E. Les travailleurs de la sante

28- La primo-infection à VIH : (Les RJ)

- A. À lieu entre 2 et 8 ans après la contamination.
- B. Se traduit par l'apparition de maladies opportunistes.
- C. Se traduit par des symptômes voisins de ceux de la grippe.
- D. Correspond à une intense augmentation de la charge virale.
- E. Elle est toujours asymptomatique

29- Quelle est l'affirmation exacte concernant le diagnostic de l'infection HIV ? (1RJ)

- A. Le diagnostic d'une infection VIH se pratique à l'aide d'une seule technique ELISA
- B. Un dépistage positif doit être obligatoirement confirme par un Western-blot
- C. Le diagnostic d'une infection chez le nouveau-né de mère séropositive est effectué par une recherche d'AC anti HIV a la naissance
- D. La recherche de l'antigène P24 est obligatoire après un dépistage positif chez l'adulte
- E. Il n'existe pas de faux positif dans les tests de VIH

30 - VIH : Le traitement par trithérapie ARV est indiqué en cas : (1RJ)

- A. $CD4 < 100 / mm^3$
- B. $CD4 < 200 / mm^3$
- C. $CD4 < 350 / mm^3$
- D. $CD4 < 500 / mm^3$
- E. Dès la découverte de la séropositivité VIH

Epreuve Pratique :**Cas clinique :**

Aux urgences, vous recevez un étudiant universitaire de 21 ans, sans antécédents médicaux connus, présentant des céphalées fébriles évoluant depuis 48 heures.

Examen clinique :

- Fièvre à 39 C
- Raideur de nuque
- Absence de porte d'entrée infectieuse
- Pas de signe de focalisation neurologique
- Présence de taches purpuriques sur les deux jambes

Ponction lombaire (LCS purulent) :

- 2000 éléments/mm² (90 % PNN, 10 % lymphocytes)
- Protéïnorachie : 1 g/L
- Glycorachie : 0,3 g/L (glycémie 1 g/L)

1. Quel est le signe clinique le plus évocateur d'une méningite ? (1RJ)

- A. Céphalées
- B. Photophobie
- C. Vomissements
- D. Raideur méningée
- E. Fièvre

2. Face aux résultats de la ponction lombaire, quel diagnostic devez-vous évoquer ? (1RJ)

- A. Méningite bactérienne
- B. Méningite virale bénigne
- C. Méningo-encéphalite herpétique
- D. Méningite décapitée
- E. Réaction méningée

3. Quels examens microbiologiques permettent de confirmer le diagnostic ? (les RJ)

- A. Hémocultures
- B. Sérologies virales
- C. Examen direct et culture du LCR
- D. Frottis sanguin
- E. PCR méningocoque sur sang

4. Avec le purpura, quel germe est le plus probable ?? (1RJ)

- A. Méningocoque
- B. Tuberculose
- C. Pneumocoque
- D. Haemophilus influenzae
- E. Herpes virus

5. Vous débutez un traitement en urgence. Quel est votre choix ? (Les RJ)

- A. Céfazoline
- B. Dexaméthasone
- C. RHZE
- D. Céfotaxime
- E. Acyclovir

6. Quelles mesures prophylactiques allez-vous prendre ? (les RJ)

- A. Désinfection des locaux
- B. Séroprophylaxie
- C. Chimio prophylaxie des contacts
- D. Isolement respiratoire (24 h après début ATB)
- E. Vaccination des sujets contacts

Examen Psychiatrie Rattrapage/ 2025**1. La schizophrénie débute le plus souvent :**

- A. Avant 10 ans
- B. Entre 15 et 35 ans
- C. Après 50 ans
- D. Exclusivement à l'adolescence

2. Le symptôme le plus spécifique de la schizophrénie est :

- A. Trouble de l'humeur
- B. Dissociation de la pensée
- C. Anxiété généralisée
- D. Amnésie

3. Dans la schizophrénie, le traitement de fond repose

- A. Antidépresseurs
- B. Anxiolytiques
- C. Antipsychotiques (neuroleptiques)
- D. Psychothérapie uniquement

4. L'épisode dépressif caractérisé dure au minimum :

- A. 1 jour
- B. 1 semaine
- C. 2 semaines
- D. 2 mois

5. Parmi les symptômes suivants, lequel appartient à la dépression ?

- A. Euphorie
- B. inhibition psychomotrice
- C. Fuite des idées
- D. insomnie paradoxale

6. Le traitement de première intention d'un épisode dépressif :

- A. Benzodiazépines
- B. Antidépresseurs
- C. Thymorégulateurs (lithium, valproate)
- D. Psychothérapie

7. L'attaque de panique survient

- A. Au cours de la nuit
- B. De façon brutale et imprévisible
- C. Toujours liée à un traumatisme
- D. Après un effort physique

8. Le trouble anxieux généralisé se définit par :

- A. Anxiété diffuse $\geq$ 6 mois
- B. Attaques de panique répétées
- C. Phobies spécifiques
- D. Amnésie sélective

9. Le traitement de fond du trouble anxieux généralisé

- A. Benzodiazépines au long cours
- B. Antidépresseurs ISRS
- C. Neuroleptiques
- D. Aucun

10. Le delirium tremens survient :

- A. Après intoxication alcoolique
- B. Après sevrage brutal d'alcool
- C. Après consommation de cannabis
- D. Après prise de cocaïne

11. Le traitement du delirium tremens :

- A. Antidépresseurs
- B. Benzodiazépines + vitamine B1
- C. Neuroleptiques seuls
- D. Abstinence stricte

12. Le craving correspond à :

- A. Symptôme négatif de schizophrénie
- B. Désir irrépressible de consommer
- C. Amnésie antérograde
- D. Compulsion alimentaire

13. La personnalité borderline se caractérise par :

- A. Instabilité affective
- B. Rigidité excessive
- C. Méfiance permanente
- D. Indifférence affective

14. La personnalité paranoïaque se définit par :

- A. Relations sociales riches
- B. Méfiance et idées de persécution
- C. Goût pour l'ordre
- D. Hypersociabilité

15. Effet secondaire majeur du lithium :

- A. Insuffisance rénale et dysthyroïdie
- B. Hypoglycémie
- C. HTA
- D. Dépression respiratoire

16. Les benzodiazépines exposent surtout à

- A. Dépendance et troubles mnésiques
- B. HTA
- C. Hypothyroïdie
- D. Schizophrénie

17. Les ISRS agissent sur :

- A Dopamine
- B. Sérotonine
- C. Noradrénaline
- D. GABA

18. L'autisme infantile débute

- A. Avant 3 ans
- B. Après 10 ans
- C. A l'adolescence
- D. Après 20 ans

19. La triade autistique comprend

- A. Trouble du langage + relations sociales altérées + intérêts restreints
- B. Hyperactivité + impulsivité + anxiété
- C. Euphorie + insomnie + logorrhée
- D. Mutisme + hallucinations + catatonie

20. Le TDAH associe

- A. Inattention + hyperactivité + impulsivité
- B. Dépression + anxiété
- C. Hallucinations + délire
- D. Crises convulsives

21. Le risque majeur en cas de mélancolie grave :

- A. Violence hétéro-agressive
- 9. Suicide
- C.TOC
- D. Confusion

22. Un patient agité en urgence, première mesure :

- A. Contention immédiate
- B. Isolement + sédation adaptée
- C. Hospitalisation obligatoire
- D. Appeler la famille

23. La bouffée délirante aiguë évolue souvent vers :

- A. Guérison
- B. Démence
- C. Trouble anxieux
- D. Trouble bipolaire

24. La maladie s'Alzheimer débute par :

- A. Troubles du langage
- B. Troubles de mémoire épisodique
- C. Troubles moteurs
- D. Hallucinations

25. Le MMSE évalue

- A. Anxiété
- B. Fonctions cognitives
- C. Schizophrénie
- D. Dépression

26. Hallucination la plus fréquente dans Alzheimer

- A. Visuelle
- B. Auditive
- C. Olfactive
- D. Gustative

27. La catatonie est fréquente dans

- A. Schizophrénie
- B. TAG
- C. Alcoolisme
- D. Trouble bipolaire

28. Les idées de référence appartiennent au registre

- A. Délirant
- B. Anxieux
- C. Amnésique
- D. Dépressif

29. Un patient qui répète les paroles de l'interlocuteur

- A. Palilalie
- B. Echolalie
- C. Logorrhée
- D. Mutisme

30. La clinophilie signifie :

- A. Rester couché
- B. Peur des lieux publics
- C. TOC
- D. Délire hypocondriaque

Examen Gynécologie Rattrapage/ 2025**1- Le syndrome de ROKITANSKY-KUSTER-HAUSLER se caractérise par :(RJ)**

- A/ Une aménorrhée primaire par aplasie congénitale des ovaires
- B/ Une aménorrhée primaire par aplasie congénitale de l'utérus et du vagin
- C/ Des douleurs cycliques chroniques
- D/ Des caractères sexuels secondaires absents
- E/ Un caryotype XY

2- Parmi les étiologies de l'aménorrhée secondaire : (RF)

- A/ Synéchie utérine
- B/ Syndrome de Sheehan
- C/ Hyperprolactinémie
- D/ Choc psycho-affectif
- E/ Syndrome de Turner

3- Le mécanisme d'action de la contraception hormonale est le suivant: (RF)

- A/ Inhibition de la croissance folliculaire
- B/ Pic LH-FSH
- C/ Modifications de la glaire cervicale
- D/ Inhibition de l'ovulation
- E/ Atrophie de l'endomètre

4- Citer les méthodes contraceptives les plus efficaces parmi les suivantes : (RJ)

- 1/ DIU au cuivre
- 2/ Coït interrompu
- 3/ Abstinence périodique
- 4/ Pilule gastro-progestative
- 5/ Spermicides

A/ 1+2+4 B/ 2+4 C/ 1+4 D/ 1+4+5 E/ 1+3+4

5- La menace d'accouchement prématuré peut associer : (RF)

- A/ contractions utérines irrégulières et espacées
- B/ col mou raccourci
- C/ signes d'infections
- D/ col efface et perméable
- E/ écoulement de liquide amniotique

6- Parmi les étiologies de l'accouchement prématuré spontané : (RF)

- A/ syndrome vasculo-rénal
- B/ béance cervico-isthmique
- C/ malformation utérine
- D/ infection génitale
- E/ anémie

7- la présentation de l'épaule : (RJ)

- 1/ est fréquente
 - 2/ se voit pendant la grossesse
 - 3/ évolue spontanément vers la rupture utérine
 - 4/ s'accompagne d'une PDE rompue
 - 5/ est une indication à la césarienne
- A/ 1+3+4 B/ 2+3+4 C/ 1+2+5 D/ 2+5 E/ 3+5

8- Quels marqueurs immunohistochimiques permettent de distinguer une dysplasie de bas grade d'une dysplasie de haut grade ? (RJ)

- A. P16 et Ki67
- B. P16 seule
- C. Ki67 et les récepteurs à l'œstrogène
- D. P40 et P63
- E. Les récepteurs à l'œstrogène seuls

9- L'adénofibrome mammaire : (RF)

- A. C'est la tumeur bénigne la plus commune du sein
- B. Il touche préférentiellement la femme jeune
- C. Il associe une prolifération épithéliale et conjonctive bénigne
- D. Il présente toujours un potentiel de transformation maligne élevé
- E. Il est bien encapsulé avec des glandes régulières

10- Concernant la gynécomastie, quelle est la proposition exacte ?

- A. Elle touche exclusivement les hommes de moins de 18 ans
- B. Elle est due à un déséquilibre hormonal androgène/œstrogène
- C. Elle ne présente jamais de phase fibreuse
- D. Elle se localise toujours de façon bilatérale
- E. Elle ne comporte qu'une seule phase évolutive

11- L'adénomyose: (RJ)

- A. Est une prolifération de glandes endométriales à l'intérieur du myomètre.
- B. Macroscopiquement, la paroi utérine est amincie avec de multiples kystes remplis de sang noirâtre.
- C. Est la présence de glandes endométriales et de stroma cytogène à l'intérieur du myomètre.
- D. Peut être simple ou complexe.
- E. Peut-être avec ou sans atypies cytonucléaires.

12- En cas de grossesse tubaire, l'examen histologique montre : (RJ)

- A. Une hyperplasie glandulaire endométriale
- B. Des villosités choriales dans la paroi tubaire
- C. Un épaissement de la musculature
- D. Des granulomes tuberculoïdes
- E. Une atrophie des plis muqueux

13- L'avortement spontané en cours s'accompagne de : (RF)

- A/ fièvre
- B/ hémorragie de volume variable
- C/ douleur à type de coliques expulsives
- D/ col dilaté
- E/ isthme comblé

14- La salpingite aigue est : (RF)

- A. Une infection de la trompe utérine
- B. Peut survenir suite à une maladie sexuellement transmise (MST)
- C. Se traduit microscopiquement par une fibrose
- D. Est rarement liée à une infection de voisinage (appendicite, sigmoïdite)
- E. A la macroscopie les trompes sont œdémateuses, érythémateuses, à contenu purulent

15- Les Chorioamniotites (RF)

- A. Sont les plus fréquentes des inflammations placentaires
- B. La cause principale est la rupture prématurée des membranes (RPM).
- C. Des polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, plasmocytes, cellules géantes sont présents dans l'axe des villosités choriales
- D. Un infiltrat à polynucléaires neutrophiles est retrouve dans l'amnios et le chorion
- E. Les germes responsables sont : Escherichia coli, staphylocoque, streptocoque B

16- Quels sont les modes d'action des pilules œstroprogestative :

- a- Blocage de l'ovulation
- b- Blocage de la folliculogenèse
- c- L'absence de formation du corps jaune
- d- Modification de la glaire cervicale
- e- Muqueuse endométriale impropre a la nidation

A-(a-b-c) B-(c-d-e) C-(a-d-e) D-(b-c-d) E(a-e-c)

17- parmi les contre -indications absolues a l'emploi du stérilet :

- a- grossesse en cours
- b- cardiopathie valvulaire
- c- traitement pas les AINS ou corticoïde au long cours
- d- maladie de Wilson pour les stérilets en cuivre
- e- fibrome sous muqueux

A-(a-b-c) B-(c-d-e) C-(a-b-d) D- (b-c-d) E-(a-e-c)

18- Quel antigène érythrocytaire est le plus fréquemment impliqué dans l'allo-immunisation foeto-maternelle ?

- A. Kell
- B. Rhésus D
- C. Rhésus C
- D. Duffy
- E-Aucune

19- Quel est le principal mécanisme physiopathologique de l'anémie fœtale dans l'allo-immunisation ?

- A. Destruction des globules rouges fœtaux par des toxines maternelles
- B. Infiltration médullaire fœtale par des cellules immunitaires maternelles
- C. Hémorragie fœto-maternelle massive spontanée
- D. Passage transplacentaire d'anticorps maternels dirigés contre les antigènes érythrocytaires fœtaux
- E. Blocage de la synthèse d'érythropoïétine fœtale

20- Quel est le principal signe échographique évocateur d'une anémie fœtale modérée à sévère ?

- A. Diminution de l'indice de liquidité amniotique
- B. Hyper débit dans l'artère cérébrale moyenne (doppler cérébral)
- C. Bradycardie fœtale persistante
- D. Disparition de l'activité motrice fœtale
- E. Dilatation des ventricules cérébraux

21- À quel moment de la grossesse doit-on proposer une injection de prophylaxie anti-D chez une femme Rhésus négatif non immunisée ?

- A. À 16 SA
- B. À 20 SA
- C. À 28 SA
- D. À l'accouchement uniquement
- E. uniquement si saignement

22- Quelle est la tumeur ovarienne bénigne la plus fréquente chez la femme en Age de procréer ?

- A. Fibrome ovarien
- B. Cystadénome mucineux
- C. Kyste fonctionnel
- D. Cystadénome séreux
- E. Tératome mature

23- Quel est le marqueur tumoral le plus couramment utilisé dans le suivi des cancers de l'ovaire d'origine épithéliale ?

- A. CA 15-3
- B. AFP
- C. CA 19-9
- D. CA 125
- E. HCG

24- Le tératome ovarien mature présente le plus souvent les caractéristiques suivantes :

- A. Tumeur maligne à croissance rapide
- B. Tumeur contenant des cellules germinales indifférenciées
- C. Tumeur bénigne contenant des tissus différenciés de différents feuillets embryonnaires
- D. Tumeur strictement uniloculaire à contenu séreux
- E. Tumeur sécrétant de l'œstrogène chez la femme ménopausée

25- Parmi les éléments suivants, lequel est le plus en faveur d'une tumeur ovarienne maligne à l'échographie pelvienne ?

- A. Tumeur uniloculaire de 4 cm, paroi fine
- B. Présence de cloisons épaisses, végétations endokystiques et ascite
- C. Kyste anéchoogène sans cloison
- D. Image en verre dépoli ; typique de l'endométriome
- E. Tumeur mobile, sensible, avec paroi lisse

26- 9-Parmi les propositions suivantes, quelle tumeur ovarienne est le plus souvent hormonosécrétoire ?

- A. Cystadénome séreux
- B. Fibrome ovarien
- C. Tumeur de la granulosa
- D. Tératome mature
- E. Cystadénome mucineux

27- les principales étiologies des hémorragies du post partum :

- a-inertie utérine
- b-sur distension utérine
- c-respect de la physiologie de la délivrance
- d- un travail rapide
- e-délivrance incomplète

A(a-b-c) B(a-b-c-e) C(c-d-e) D(a-d-e) E(b-d-a)

28- Les leucorrhées en relation avec une mycose : (RI)

- 1 Favorisées par un pH acide
- 2 Grumeleuses
- 3 Prélèvements systématiques à la recherche de filaments mycéliens
- 4 Spumeuses
- 5 Accompagnées volontiers de lésions périnéales

A 1+2+3+4+ B 2+3+4 C 2+4 D 2+4+5 E 1+2+5

29- Une infection génitale à chlamydia peut entraîner (RF)

- A Une perihépatite
- B Une pelvi péritonite
- C Une péri splénite
- D Un pyosalpinx
- E Une endométrite

30- La flore vaginale subit des modifications en fonction de :RF

- A Age
- B Grossesse
- C Contraception
- D Activité sexuelle
- E Toutes les réponses sont fausses

31- Parmi les propositions concernant la toxoplasmose congénitale, une seule est fausse, laquelle ?

- A. L'infection fœtale résulte classiquement du passage de toxoplasmose par voie transplacentaire
- B. Elle peut entraîner des atteintes cérébrales chez l'enfant
- C. Il faut que la primo-infestation de la mère ait lieu au cours de la grossesse
- D. La fréquence de transmission est d'autant plus grande que la grossesse est avancée
- E. L'atteinte fœtale est d'autant plus sévère qu'elle est tardive

32- L'agent responsable des lésions tubaires, cause d'infertilité le plus fréquent : RJ

- A Le bacille de koch
- B Le mycoplasme
- C Le trichomonas
- D Le chlamydia trachomatis
- E Le gonocoque

33- Les conséquences de l'infection rubéolique : RF

- A Malformation cardiaque
- B Malformation oculaire
- C Malformation cochléaire
- D Retard de croissance intra-utérin
- E Malformation rénale

34- Les infections sexuellement transmises sont : {LRF}

- A Infection à HPV
- B Infection à gonocoque
- C Mycose
- D Infection à chlamydia
- E Infection à tréponème pallidum

35- Un bassin est dit comme modérément rétréci dans les situations suivantes (RJ)

- 1. Le diamètre promonto-rétropubien est inférieur à 9,5 cm
 - 2. Le diamètre transverse médian est compris entre 9,5 et 11 cm
 - 3. L'indice de Magnin est compris entre 20 et 22
 - 4. Le diamètre bi-Ischiatique est inférieur à 8 cm
 - 5. Le diamètre promonto-retropubien est compris entre 9,5 et 10,4 cm
- A) (2+3+5) B) (1+3+4) C) (2+4+5) D) (1+2+3) E) (1+4+5)

36- Le détroit supérieur est le lieu : {RI}

- A. De l'accommodation de la présentation fœtale
- B. De l'engagement de la présentation fœtale
- C. De l'engagement-rotation de la présentation fœtale
- D. Du dégagement de la présentation fœtale
- E. Du complément de flexion de la présentation

37- Les moyens thérapeutiques devant un prolapsus urogénital de la femme sont : RJ.

1. Mesures hygiéno-diététiques
2. Rééducation périnéale
3. Pessaires
4. Chirurgie
5. L'estrogenotherapie

A (2+5) B (2+3+4) C (1+3+4+5) D (1+3+4) E (2+3+5)

38- La manœuvre de Victor Bonney a pour objectif : Cochez la réponse juste

- A. De simuler l'impact des principales interventions proposées pour traiter une incontinence urinaire d'effort non neurologique chez la femme.
- B. D'assurer une compression urétrale permettant d'arrêter la fuite d'urine lors de l'examen.
- C. De s'assurer du degré de mobilité vésico-urétrale.
- D. De simuler l'impact des principales interventions proposées pour traiter une colpocytocèle.
- E. Est une manœuvre pour la stadification de la cytocèle

39- Quelle est la position fœtale idéale pour un accouchement en présentation du sommet :

- A. Occipito-antérieure
- B. Occipito-postérieure
- C. Occipito-transverse
- D. Frontale
- E. Podalique

40- Une parturiente de 38 SA se présente en salle de travail pour contractions régulières. À l'examen clinique : la hauteur utérine est normale, la présentation est fixe, les BCF sont réguliers. On suspecte une présentation céphalique. Quel est l'examen permettant de confirmer avec certitude le type exact de présentation (sommet, face, front) et son orientation ?

- A) Palpation abdominale par les manœuvres de Leopold
- B) Radiopelvimétrie
- C) Toucher vaginal obstétrical
- D) Échographie obstétricale
- E) Enregistrement du rythme cardiaque fœtal

41- Lors du toucher vaginal, vous palpez une présentation céphalique. Quels sont les éléments qui permettent de préciser qu'il s'agit d'une présentation du sommet ?

- A) Présence de la grande fontanelle et des sutures sagittales
- B) Présence de la grande fontanelle et du menton
- C) Palpation des orbites et du nez
- D) Présence des fontanelles, du sillon interpariétal et d'un repère occipital
- E) Palpation du lobule de l'oreille

42- Dans le cas d'une présentation du sommet bien fléchie, quel est le diamètre obstétrical engagé ?

- A) Sous-occipito-bregmatique (9,5 cm)
- B) Occipito-frontal (11 cm)
- C) Mento-vertical (13,5 cm)
- D) Sous-mento-bregmatique (9,5 cm)
- E) Bipariétal (9,5 cm)

43- Si, au toucher vaginal, vous trouvez la grande fontanelle en avant et latéralisée à gauche, comment qualifieriez-vous la variété de la présentation ?

- A) OIGA (occipito-iliaque gauche antérieure)
- B) OIGP (occipito-iliaque gauche postérieure)
- C) OIDA (occipito-iliaque droite antérieure)
- D) OIDP (occipito-iliaque droite postérieure)
- E) OSA (occipito-sacrée antérieure)

44- Les toxémies gravidiques admettent comme critère(s) de gravité

- 1. Elévation de l'acide urique sérique
 - 2. Diminution des plaquettes sanguines
 - 3. Diminution du fibrinogène
 - 4. Diminution de la créatinine sérique
 - 5. Une hyperglycémie
- A (2+5) B (1+2+3) C (1+3+4+5) D(1+3+4) E(2+3+5)

45- Quelle est la définition clinique de la ménopause :

- A. Absence de menstruations pendant 6 mois successifs
- B. Apparition du syndrome climatérique
- C. Absence de menstruations pendant 12 mois successifs
- D. Apparition des bouffées de chaleur au-delà de 45 ans
- E. Taux de FSH élevé

46- Quelle est la complication la plus associée à la ménopause à long terme :

- A. Cancer du sein
- B. Cardiomyopathie
- C. Diabète type 2
- D. Ostéoporose
- E. Cancer colorectale

47- Quel est le changement hormonal le plus caractéristique de la ménopause :

- A. Hyperœstrogenie
- B. Taux de FSH élevé
- C. Hyper cholestérolémie
- D. Augmentation du taux de progestérone
- E. Taux de FSH bas

48- L'hystérosalpingographie est un examen invasif qui permet de diagnostiquer (RF) :

- A. Les troubles de la diffusion péritonéale
- B. La perméabilité des trompes
- C. Les malformations de l'utérus
- D. Les grossesses extra-utérines cervicales
- E. Les synéchies utérines

49- Une de ces propositions ne fait pas partie des parties des contres indications de l'hystérocopie : (RJ)

- A. Grossesse débutante
- B. Allergie au cuivre
- C. Infection en cours
- D. Hémorragie non diagnostiquée
- E. Cancer du col

50- Les facteurs de risques de grossesse extra-utérine comportent :

- A- Les antécédents de salpingite aigue
- B - Les microprogestatifs
- C - Le DIU
- D - Les antécédents d'appendicectomie
- E - La multiparité

VRAI/ FAUX**51- le dosage de la FSH est indispensable au diagnostic de la ménopause**

- A/ Vrai B/ Faux

52-L'examen du bassin ne nécessite pas de radiographie ou d'imagerie dans la plupart des cas, car il est base sur des mesures cliniques simples.

- A- Vrai B- Faux

53- Le mécanisme de flexion est essentiel au bon déroulement de l'accouchement, car il permet à la tête fœtale de s'adapter a la forme du bassin. Mécanique général de l'accouchement

- A- Vrai B- Faux

54- Le premier geste face à une hémorragie de la délivrance

- A- Laparotomie exploratrice B- Révision utérine

55- Les synéchies utérines et les traumatismes cervicaux sont parmi les complications redoute lors de la réalisation d'une révision utérine

- A) Vrai B) Faux

56- Parmi les explorations en gynécologies, l'hystérocopie paraît un examen clef pour l'exploration de la pathologie de la paroi utérine

- A) Vrai B) Faux

57- Les présentations céphaliques postérieures sont considérées parmi les présentations les plus eutociques

- A) Vrai B) Faux

58- L'apparition d'un filet sanguin après l'expulsion du fœtus après l'accouchement peut être un signe de début de décollement placentaire

- A) Vrai B) Faux

59- L'échographie du 1er trimestre permet de diagnostiquer une grossesse gémellaire et de préciser la chronicité.

- A) Vrai B) Faux

60- La montée laiteuse survient généralement entre 48 et 72 heures après l'accouchement et peut provoquer des douleurs mammaires.

- A) Vrai B) Faux

Partie pratique :

61- Lors de l'échographie obstétricale réalisée autour de 12 SA, quel est l'objectif fondamental de l'examen ?

- A. Évaluer la clarté nucale pour le dépistage précoce
- B. Apprécier la localisation et l'aspect du placenta
- C. Rechercher d'éventuelles anomalies cardiaques fœtales
- D. Vérifier la vitalité embryonnaire et établir la datation de la grossesse
- E. Observer les premières structures du système nerveux central

62- Lors de l'échographie du 2e trimestre, l'objectif principal de l'échographie morphologique est :

- A. Vérifier la croissance harmonieuse du fœtus
- B. Evaluer la quantité de liquide amniotique
- C. Déterminer la localisation placentaire
- D. Dépister les malformations fœtales
- E. Contrôler la vitalité fœtale

63- Lors du dépistage de la trisomie 21 au 1er trimestre, l'élément essentiel de l'échographie est :

- A. L'épaisseur de la clarté nucale
- B. La longueur cranio-caudale
- C. L'aspect du placenta
- D. L'activité cardiaque fœtale
- E. Le diamètre bipariétal

64- L'hystérosalpingographie est particulièrement indiquée chez les femmes présentant :

- A. Des antécédents de césarienne
- B. Des douleurs pelviennes chroniques
- C. Une infertilité inexplicée après 1 an de tentative de conception
- D. Une grossesse extra-utérine précédente
- E. Une anomalie du spermogramme

65- L'hystérosalpingographie est contre-indiquée en cas de :

- A. Suspicion de grossesse en cours
- B. Infection pelvienne évolutive
- C. Antécédent de grossesse extra-utérine
- D. Saignements génitaux inexplicés
- E. Allergie connue aux produits de contraste iodes

Examen Pédiatrie Rattrapage/ 2025**Questions Examen théorique :**

1. Donnez la définition de la diarrhée aigue
2. Citez les germes en cause dans l'infection néo natale précoce.
3. Donnez la définition du syndrome néphrotique idiopathique.
4. Citez les bactéries responsables de la pneumonie aigue communautaire, et l'antibiotique indiqué dans chaque cas.
5. Citez 4 critères permettant de retenir le diagnostic de convulsions fébriles simples.

Examen Gériatrie Rattrapage/ 2025

Partie théorique :

1/ citez 4 principales règles de la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé?

2/ définissez la polymédication?

3/quels sont les facteurs favorisant l'incontinence urinaire du sujet âgé ?

4/ citez les 3 principaux syndromes cognitifs du sujet âgé ?

5/ définissez le sujet âgé ?

6/ qu'est-ce que le syndrome de Chute chez le sujet âgé ?

7/ quels sont les principaux facteurs de dénutrition chez le sujet âgé ?

8/ citez 4 principes de la prise en charge de la douleur chez le sujet âgé ?

9/ citez les 4 principales causes des troubles du sommeil chez le sujet âgé ?

10/ expliquez brièvement la position de la législation Algérienne vis à vis du sujet Agé ?

Partie pratique :

Patient de 60 ans, tabagique à raison d'un paquet par jour depuis plus de 30 ans, qui consulte pour otalgie droite accompagnée d'une obstruction nasale de même coté évoluant depuis un mois.

21- Quel examen vous devez impérativement pratiquer en premier ?

- a- La palpation cervicale
- b- L'examen otoscopique
- c- Une laryngoscopie directe
- d- L'endoscopie du cavum
- e- Une TDM de la face

La palpation cervicale retrouve une tuméfaction cervicale droite, spinale de 2 cm mobile, l'otoscopie objective une congestion tympanique.

22- Quel diagnostic suspectez-vous en premier ?

- a- Une déviation de la cloison nasale
- b- Une polypose naso-sinusienne
- Une sinusite maxillaire aigue
- d- Un cancer du cavum
- e- Une adénopathie tuberculeuse

23- Pour étayer votre diagnostic quel examen complémentaire vous demander ?

- a- Une échographie cervicale
- b- L'IDR a la tuberculine
- c- Une cytoponction ganglionnaire
- d- Une IRM du cavum
- e- Une angiographie du cavum

24- Quel examen complémentaire pratiquez-vous pour confirmer vitre diagnostic ?

- a- Une laryngoscopie directe avec examen histologique
- b- Une cytoponction ganglionnaire
- c- Une biopsie du cavum avec examen histologique
- d- Une TDM cervicale
- e- Une IRM du cavum

25- Quel est le type histologique le plus souvent retrouvé chez votre patient ?

- a- Un carcinome bien différencié
- b- Un mélanome
- c- Un sarcome
- d- Un UCNT
- e- Un adénocarcinome

26- Une fois le diagnostic est fait chez votre patient, quel bilan demandez-vous systématiquement pour rechercher une localisation secondaire à distance ?

- a- Une TDM cervicale
- b- Une IRM cervicale
- c- Une scintigraphie osseuse
- d- Une angiographie du cavum
- e- Une TDM thoraco- abdominopelvienne

L'examen endoscopique retrouve une tumeur confinée dans le cavum avec un bilan d'extension négatif chez votre patient

27- Comment classez-vous votre patient selon la classification TNM ?

- a- T2NOMO
- b- T2N1MO
- c- T3N1MO
- d- T1N1MO
- e- T1N1M1

28- Quelle serait votre conduite à tenir chez votre patient ?

- a- Une résection chirurgicale
- b- Une surveillance clinique et radiologique
- c- Une chimiothérapie exclusive
- d- Une radiothérapie exclusive
- e- Une radio-chimiothérapie concomitante

29- Quels sont les facteurs de risque de développer cette tumeur (RF) ?

- a- Facteur génétique
- b- Infection virale à EBV
- c- Une exposition prolongée au formaldéhyde
- d- Tabagisme
- e- Facteur alimentaire

30- La surveillance post-thérapeutique de votre patient se fait par ? (RF)

- a- Examen clinique du cavum tous les 3mois
- b- Un téléthorax tous les ans
- c- Sérologie EBV
- d- Une IRM
- e- Une laryngoscopie directe

Examen UroNéphro Rattrapage/ 2025**1/Dans une insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire aigue : la ou les RF**

- A. La récupération de la fonction rénale antérieure est la règle
- B. La protection biopsie rénale est indiquée d'emblée
- C. Il existe une hématurie macroscopique
- D. Une IRA fonctionnelle peut évoluer vers une nécrose tubulaire aigue en l'absence de traitement
- E. La protéinurie est supérieure à 2 g/24h.

2/Le bilan à réaliser en urgence devant une IRA est : la ou les RF

- A- Toucher rectal et recherche de globe vésical
- B - ECG
- C - Radiographie pulmonaire
- D - Échographie vésico-rénale
- E - Uro-TDM

3/Au cours de la grossesse normale: la ou les RJ

- A. Le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire (DFG) augmentent d'environ 30 %.
- B. La pression artérielle est normale au cours du 2^{ème} trimestre
- C. Le bilan sodé est positif (+ 500 à 900 mmoles de sodium)
- D. Au cours de la grossesse normale, le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire (DFG) augmentent d'environ 40%.
- E. Le bilan hydrique est positif (+ 6 à 8 litres d'eau)

4/Au cours de la grossesse normale, on assiste à (RJ):

- A. Une augmentation de l'uricémie
- B. Une baisse de la créatininémie
- C. Une augmentation de la créatininémie
- D. Une créatinine normale
- E. Une baisse des résistances vasculaires périphériques

5/Dans les tumeurs de la vessie RJ : QCM

- A. L'hématurie est constante si les localisations sont multiples
- B. Les principaux facteurs de risque de progression d'une TVINM sont : le haut grade et CIS associé
- C. L'uroscanner est demandé après le diagnostic d'une TVINM pour rechercher une tumeur concomitante du haut appareil et dans le cadre du bilan d'extension
- D. La cystectomie avec curage ganglionnaire est le traitement de choix en cas de TVIM avec bilan d'extension négatif
- E. La présence de CIS est un élément de mauvais pronostic

6/Parmi les options thérapeutiques d'une tumeur de vessie non infiltrant le muscle de bas grade : peut retrouver : IRJ

- A. Une radiothérapie conformationnelle
- B. Résection Transurétrale de la prostate
- C. Cystoprostectomie totale
- D. Résection transurétrale de la vessie
- E. Chimiothérapie

7/Un traumatisme de l'artère prostatique peut être évoqué devant : QCM

- A. Colique nephretique fébrile
- B. Pollakiurie
- C. Urétrorragie
- D. Hématome péri rénal.
- E. Hématocèle de la vaginale

8/Lors d'une fracture du bassin, la portion artérielle la plus fréquemment atteinte est : RJ

- A. L'urètre bulbaire
- B. L'urètre membraneux
- C. L'urètre prostatique
- D. Le col vésical
- E. L'urètre pénien.

9/Parmi les étiologies suivantes, laquelle ou lesquelles ne sont pas une cause de survenue d'un dysfonction érectile ?

- A. L'hypertension artérielle
- B. Epouse compréhensive
- C. Dépression
- D. Trouble hormonaux notamment l'hypertestosteronémie
- E. L'activité sportive

10/Quels sont les marqueurs tumoraux en rapport avec un cancer du testicule : RJ

- 1.CA19-9
- 2.Alphafoctoprotéine
- 3.LDH
- 4.CA 125
- 5.HCG

A(1+4) ; B(2+3+4) ; C(1+3+5) ; D(1+5) ; E(2+3+5)

11/Les traumatismes rénaux : RF

- A- Ils représentent 10% des traumatismes abdominaux
- B- Ils sont associés à d'autres lésions abdominales dans 60% des cas
- C- L'échographie abdominale est l'examen de choix pour détecter et classer les lésions
- D- Le traitement conservateur est le plus souvent entrepris
- E- Les traumatismes graves peuvent engendrer un état de choc hémodynamique

12/Quels sont les signes électriques attendus à ECG lors d'une hyperkaliémie :

- 1/Onde T ample symétrique
- 2/ Onde U
- 3/ QRS larges
- 4/Asystolie
- 5/ Disparition de l'onde P

A (1+2+3+4) B(1+3+4+5) C(1+2+4+5) D(1+2+3+4+5) E(2+3+4+5)

13/ Quelle est votre démarche thérapeutique pour corriger l'hyperkaliémie chez votre patient? RJ

1. Gluconate de calcium en IVD
2. Perfusion de Bicarbonate de Sodium
3. Augmenter les doses de Diurétiques
4. arrêter les IEC
5. Assurer une Séance d'Hémodialyse

A (1+2+3+4) B(1+2+3+4+5) C(1+2+4+5) D(1+3+4+5) E(2+3+4+5)

14/ Une ponction biopsie rénale réalisée chez un patient objective un épaississement de la membrane avec un aspect en chaînettes au MO et des dépôts granuleux d'IGg et de C3 à Immunofluorescent est le type de glomérulopathie à retenir chez ce patient :

- A/ Lésions glomérulaire minime (LGM)
- B/ Néphropathie à dépôts IgA
- C/ Glomérulonéphrite extra capillaire
- D/ Glomérulonéphrite extra membraneuse
- E / Hyalinose segmentaire et focale

15/Dans quelle(s) situation(s) le PSA peut-il être élevé ? (la/les RJ)

- A - Prostatite aigue.
- B - Rétention aigue d'urine.
- C - Pose de néphrostomie.
- D - Toucher rectal.
- E - Origine médicamenteuse : inhibiteur de la 5a-reductase.

16/Au cours d'une déshydratation EC pure, on observe (la/les RF)

- A/hémoconcentration plasmatique
- B/Baisse du pool sodé
- C/Un pool sodé normal
- D/Perte d'eau accompagnatrice
- E/Pli cutané persistant

17/La déshydratation intracellulaire se caractérise par : (la/les RF)

- A/Déficit hydrique
- B/Déficit hydrosodé
- C/Contraction du secteur intracellulaire
- D/Hyperosmolarité plasmatique
- E/Natrémie < 145 mmol/L

18/Quel est le type histologique le plus fréquent dans le cancer de la prostate : RJ

- A - Adénocarcinome
- B - carcinomes épidermoïdes
- C - carcinomes neuroendocrines
- D - rhabdomyosarcome
- E - léiomyosarcome

19/Le cancer de la prostate se localise essentiellement : RJ

- A - dans la zone transitionnelle
- B - dans la zone centrale
- C - dans la zone périphérique
- D - dans la zone fibromusculaire antérieur
- E - dans la zone centrale et transitionnelle

20/Le dépistage du cancer de la prostate se fait par : RJ

- A - une biopsie prostatique
- B- un toucher rectal et un dosage de PSA
- C- une IRM prostatique
- D - un PET scann
- E - une échographie prostatique

21/L'examen de référence dans le diagnostic du cancer du rein est : RJ

- A. Echographie rénale
- B. Urino-TDM
- C. AngioTDM
- D. Uro-TDM
- E. IRM rénale.

22/La triade urologique caractéristique du cancer du rein est : RJ

- A. Hématurie + douleur lombaire + masse lombaire
- B. Hématurie + douleur lombaire + dysurie
- C. Hématurie + douleur lombaire + pollakiurie
- D. Hématurie + douleur lombaire + fièvre
- E. douleur lombaire + masse lombaire + dysurie

23/L'HBP se développe au dépend de : RJ

- A. zone centrale
- B. zone transitionnelle
- C. zone périphérique
- D. zone fibromusculaire antérieur

24/ Concernant l'insuffisance rénale chronique, quel(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

- A. Elle peut être responsable d'une HTA
- B. Elle est définie par une augmentation du DFG
- C. Elle s'accompagne d'une réduction du nombre de néphrons fonctionnels
- D. Elle s'accompagne toujours d'une baisse du débit urinaire
- E. Elle peut être responsable d'une Hypovolémie.

25/Quel(s) élément(s) permet (tent) d'orienter vers le caractère chronique d'une insuffisance rénale ?

- A. L'existence depuis plus de 3 mois d'une protéinurie et d'une anomalie du sédiment urinaire
- B. Une augmentation du débit de filtration glomérulaire évoluant depuis plus de 3 mois
- C. La présence d'une hyperkaliémie associée à une acidose métabolique
- D. La présence de reins dont la taille est significativement réduite
- E. La présence d'une anémie normochrome normocytaire et régénérative au moment du diagnostic.

26/ Quelle(s) est (sont) la (les) mesure(s) de Néphroprotection à mettre en place chez un patient qui présente une insuffisance rénale de stade 3 ?

- A. Régime normo-protidique.
- B. Prescrire un régime hypo-protidique modéré.
- C. Traitement par inhibiteurs calciques dans les néphropathies glomérulaires
- D. Contrôle tensionnel optimal avec des cibles de PA < 130/80 mmHg
- E. Mise en place d'une voie d'abord pour la dialyse

27/Parmi les propositions suivantes, quelles sont les anomalies physiopathologiques associées a une insuffisance rénale chronique : la ou les RF

- A. Hypertension artérielle
- B. Hypercalcémie
- C. Hypophosphatémie
- D. Anémie normocytaire normochrome arégénérative
- E. Anémie normocytaire normochrome régénérative

28/La néphrite interstitielle aiguë se caractérise par : RJ

- 1. Une réaction immuno-allergique médiée par les lymphocytes B
- 2. Un infiltrat interstitiel de lymphocytes a la biopsie rénale
- 3. L'évolution est toujours favorable
- 4. La corticothérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique
- 5. La corticothérapie peut donner une néphrite interstitielle

29/Un bilan minimum d'une hypertension artérielle comporte : (la ou les RF)

- A. Coronarographie
- B. Examen clinique
- C. ECG
- D. Echocardiographie
- E. Recherche de protéinurie

30/Parmi les propositions suivantes, quels sont les facteurs de risque modifiables de l'hypertension artérielle ? (La ou les RJ)

- A. Le tabac
- B. La sédentarité
- C. Le surpoids
- D. Les antécédents familiaux
- E. L'âge

II/PRATIQUE

31/Quelles sont les complications du syndrome néphrotique (1RF) :

- A. Infections
- B. Insuffisance rénale
- C. Thromboses
- D. Dyslipidémies
- E. Hypercalcémie

32/Toutes ces propositions concernant le syndrome néphrotique sont justes sauf Une laquelle :

- A. Protéinurie > 3g/24H
- B. hypoAlbuminémie < 30g/L
- C. est toujours secondaire a une infection ORL
- D. Se manifeste par un syndrome œdémateux
- E. Hypoprotéïnémie < 60 g/L

33/Quelle(s) est(sont)(la(les)proposition(s)exacte(s)) concernant le mode d'action des Diurétique?

- A. Les Diurétiques de l'Anse agissent en inhibant le cotransporteur Na-k-2cl situe sur la membrane apical des cellules de tube contourne proximal.
- B. Les Diurétiques de l'anse permettent d'Induire une excrétion fractionnelle de 20 à 25% du sodium filtre.
- C. Les Diurétiques thiazidiques inhibent le cotransporteur NaCl situe sur la membrane apicale des cellules de tube contourne distal.
- D. La spironolactone et l'epilorenone s'opposent à l'action d'aldostérone.
- E. en cas de prescription des Diurétiques, il est inutile de diminuer l'apport sodé.

34/Quelles sont les indications de dialyse en urgence en cas d'IRA ? (RF)

- A. Un taux d'urée élevé
- B. Une hyperkaliémie menaçante
- C. Un œdème aigu des poumons (OAP)
- D. Acidose métabolique
- E. un œdème d'un membre inferieur unilatéral.

35/ Devant une hypercalcémie (RF)

- A. Notre objectif est de baisser la calcémie
- B. Expansion volémique
- C. réduction du volume extra-cellulaire
- D. forcer la diurèse
- E. corticothérapie

36/Parmi les propositions suivantes, laquelle ne fait pas partie des protéinuries transitoires (1RF)

- A. Infections de l'appareil urinaire
- B. Insuffisance ventriculaire droite
- C. Syndrome d'hyperviscosité (Polyglobulie)
- D. Protéinurie d'orthostatisme
- E. Protéinurie de repos

37/Le syndrome néphrotique est dit impur quand il associe (RJ) :

- A. Une hématurie
 - B. Une HTA
 - C. Une hypoalbuminémie < 30 g/L
 - D. Une insuffisance rénale fonctionnelle
 - E. Une insuffisance rénale organique
- A(1+2+3) ; B(1+2+4) ; C(1+3+5) ; D(1+2+5) ; E(1+2)

39/lors d'une hypercalcémie aiguë, on peut retrouver le(les) signe(s) suivant(s) :

- A. Nausée
- B. HTA
- C. Allongement du QT à l'ECO
- D.
- E. Coma

40/les signes d'une hypercalcémie chronique sont :(la/les RF)

- A. Lithiases rénales
- B. Néphrocalcinose
- C. Calcifications coronaires
- D. Insuffisance rénale chronique
- E. Aucune de ces réponses.

41/les étiologies responsables d'une hypercalcémie ? (RF)

- A. Hyperparathyroïdie Primaire
- B. Hypervitaminose A
- C. Immobilisation prolongée
- D. Myélome
- E. Insuffisance rénale chronique

42/ Quelles sont les conditions pour débuter une hémodialyse ? (la/les RJ)

- A. Accès vasculaire
- B. Circuit sanguin extracorporel
- C. Eau ultra-pure
- D. Bain de dialyse
- E. Toutes ces réponses.

43/ Quel est l'accès vasculaire qui donne la meilleure longévité en hémodialyse ? (RJ)

- A. Fistule artério-veineuse
- B. Cathéter jugulaire
- C. Cathéter tunnelisé
- D. Fistule prothétique
- E. Cathéter fémoral.

44/ L'anémie au cours de l'IRC : la ou les RJ

- A. Normocytaire Normochrome
- B. Microcytaire Hypochrome
- C. Microcytaire Normochrome
- D. Toujours Macrocytaire Normochrome
- E. Toujours Microcytaire Hypochrome

45/ La créatinine Sanguine est: RF

- A. Formée dans le muscle
- B. Issue du catabolisme de la chromatine
- C. Dépend uniquement de la masse musculaire
- D. Elle est inerte
- E. Calculer selon le poids, la taille et l'ethnie

46/Quelle est la formule la plus adaptée pour calculer le DFG chez l'enfant : RJ

- A- Cockcroft et Gault
- B-MDRD
- C-CKD-EPI
- D-SCHWARTZ
- E-MDRD et CKD-EPI

47/ Quelles sont les propositions exactes concernant la ponction biopsie rénale : la ou les RJ

- A- est une procédure invasive, nécessite une évaluation clinique et biologique
- B- a un intérêt diagnostique seulement.
- C- peut être faite en ambulatoire
- D- Peut-être réalisée sur un rein unique fonctionnel.
- E- Peut-être compliquée par un hématome péri rénal.

48/Une biopsie rénale est indiquée devant :la ou les RF

- A- un syndrome de néphropathie glomérulaire.
- B- syndrome néphrotique pur chez un enfant âgé de 1 à 10 ans.
- C- insuffisance rénale aigue (IRA) en absence de cause reconnue.
- D- maladie de système associée à une protéinurie.
- E- syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP).

**49/Quel est ou quels sont les diurétiques utilis(es)en 1ere intention pour traiter une HTA?
la ou les RJ**

- A) Amiloride
- B) Éplérénone
- C) Hydrochlorothiazide
- D) Acétazolamide
- E) furosémide

50/Quel est le mécanisme de l'apparition des œdèmes dans le syndrome néphrotique ?

- A. Lésions vasculaires.
- B. Augmentation de la pression hydrostatique.
- C. Diminution de la pression oncotique.
- D. Diminution du drainage lymphatique.
- E. Aucune de ces propositions.

Examen ORL Rattrapage/ 2025**1. La fistule pré tragienne :**

- A. Une malformation congénitale
- B. Peut-être sèche ou purulente
- C. Peut être compliqué par un abcès sous cutané
- D. Entraîne une surdité de transmission
- E. Peut être associé à d'autres malformations congénitales

2. Le bouchon du cérumen

- A. Est dû à une desquamation de la peau du conduit auditif externe
- B. Entraîne souvent des otalgies
- C. Entraîne rarement une surdité
- D. Son traitement est chirurgical
- E. Peut se manifester par des bourdonnements d'oreille

3. La rhinite allergique peut se manifester par (RF)

- A. Une obstruction nasale
- B. Une anosmie
- C. Une cacosmie
- D. Des épistaxis
- E. La présence des croûtes

4. La rhinite allergique entraîne souvent

- A. Des éternuements en salve
- B. Un prurit nasal
- C. Une obstruction nasale
- D. Une rhinorrhée unilatérale
- E. Rarement des épistaxis

5- Qu'évoquer-vous en premier devant un enfant qui présente une tuméfaction cervicale médiane, de la région hyoïdienne mobile avec la protrusion de la langue ? RJ

- A. Une adénopathie cervical
- B. Un nodule thyroïdien
- C. Un kyste dermoïde
- D. Un kyste du tractus thyroglosse
- E. Un kyste thymique

6. On suspecte un cancer des fosses nasales chez un patient de 67 ans, devant ? RF

- A. Une rhinorrhée purulente unilatérale
- B. Des épistaxis unilatérales
- C. Des algies faciales
- D. Une obstruction nasale
- E. Des rhinorrhées claires

7. Parmi les propositions suivantes, laquelle est responsable d'une surdité de transmission :

- A. Une presbyacousie
- B. La maladie de Ménière
- C. Le schwannome vestibulaire
- D. Surdité médicamenteuse
- E. Otite seromuqueuse

8. Le nerf facial, dans son trajet traverse (RF)

- A. La parotide
- B. L'angle ponto-cérébelleux
- C. La paroi postérieure de la caisse de tympan
- D. La paroi supérieure de la caisse de tympan
- E. La paroi interne de la caisse de tympan

9. Une adénopathie suspectée de malignité est caractérisée par

- A. Une consistance molle
- B. Sa souplesse par rapport aux plans profond et superficiel
- C. Sa fistulisation là la peau
- D. Sa consistance dure et fixe
- E. Son phénomène inflammatoire et sa sensibilité

10- Parmi les propositions suivantes sur le cancer du larynx, laquelle est fausse ?

- A. C'est un cancer qui touche essentiellement le sexe masculin
- B. Le tabagisme est incriminé dans son carcinogénèse
- C. Le virus HPV est incriminé dans ce cancer
- D. Le facteur héréditaire est souvent retrouvé dans ce cancer
- E. Les laryngites peuvent faire le lit de ce cancer

11. Parmi les réponses suivantes sur le cancer du nasopharynx, laquelle est fausse :

- A. La fréquence du carcinome bien différencié
- B. Sa sensibilité à la radio chimiothérapie
- C. Sa relation sérologique avec le virus EBV
- D. Sa fréquence intermédiaire dans les pays du Maghreb
- E. La symptomatologie trompeuse

12. Parmi les réponses suivantes laquelle est fausse ; Une OMC choléstestomateuse peut être responsable de :

- A. Une cophose
- B. Une lyse de canal semi circulaire antérieur
- C. Lyse de la chaîne ossiculaire
- D. Un trouble d'équilibre
- E. Adénopathies cervicales bilatérales

13. Un nourrisson de 14 mois, apyrétique, présente une dyspnée laryngée d'apparition brutale. Qu'évoquez-vous en premier ?

- A. Une épiglottite
- B. Une laryngite striduleuse
- C. Un corps étranger laryngé
- D. Une papillomatose laryngée
- E. Un angiome sous glottique

14. Parmi les angines suivantes, laquelle est habituellement unilatérale ?

- A. Angine de la mononucléose infectieuse
- B. Angine de Vincent
- C. Angine streptococcique
- D. Angine diphtérique
- E. Angine virale

15. Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse. Les carcinomes épidermoïdes synchrones ?

- A. Leur fréquence est estimée de 7 à 15% au moment du diagnostic
- B. Ils sont le témoin d'une maladie générale des VADS
- C. Ils sont secondaires à l'intoxication alcoolo-tabagique
- D. Il s'agit d'une deuxième localisation tumorale qui apparaît après le diagnostic initial
- E. Ils soulignent l'intérêt de la pan endoscopie lors du bilan initial

16. Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) :

- A. C'est le plus fréquent des vertiges
- B. Sa durée est entre 20 et 40 secondes
- C. S'accompagne souvent des signes cochléaires
- D. Du le plus souvent à une cholestéatome
- E. Son diagnostic repose essentiellement sur la positivité des manœuvres de Dix et Hallpike

17- Le neurinome de l'acoustique ou shwanomme vestibulaire peut se manifester par :

- A. Une surdité de transmission unilatérale
- B. Des acouphènes
- C. Des vertiges
- D. Parfois une paralysie faciale périphérique
- E. Son traitement repose sur la surveillance ou radiothérapie ou la chirurgie

18- Le cancer du cavum est évoqué devant tous ces signes sauf un. Lequel ?

- A. Une adénopathie cervicale haute
- B. Des épistaxis
- C. Une surdité de transmission unilatérale
- D. Des vertiges
- E. Une diplopie

19- Toutes ces propositions sur l'otite moyenne cholestéatomateuse sont justes sauf une. Laquelle?

- A. C'est une otite dangereuse sur le plan vital et fonctionnel
- B. Se manifeste par une otorrhée chronique fétide
- C. Peut se manifester d'emblée par une paralysie faciale périphérique
- D. Son traitement est chirurgical
- E. La perforation tympanique est souvent centrale

20- Toutes ces affections peuvent être responsable d'une obstruction nasale et d'épistaxis, sauf une. Laquelle ?

- A. Cancer du cavum
- B. Adénocarcinome de l'éthmoïde
- C. Tumeur maligne des fosses nasales
- D. Une déviation de la cloison nasale
- E. Hémangiome des fosses nasales

Partie pratique :

Patient de 60 ans, tabagique i raison d'un paquet par jour depuis plus de 30 ans, qui consulte pour otalgie droite accompagnée d'une obstruction nasale de même coté évoluant depuis un mois.

21- Quel examen vous devez impérativement pratiquer en premier ?

- A. La palpation cervicale
- B. L'examen otoscopique
- C. Une laryngoscopie directe
- D. L'endoscopie du cavum
- E. Une TDM de la face

La palpation cervicale retrouve une tuméfaction cervicale droite, spinale de 2 cm mobile, l'otoscopie objective une congestion tympanique.

22- Quel diagnostic suspectez-vous en premier ?

- A. Une déviation de la cloison nasale
- B. Une polypose naso-sinusienne
- C. Une sinusite maxillaire aiguë
- D. Un cancer du cavum
- E. Une adénopathie tuberculeuse

23- Pour étayer votre diagnostic quel examen complémentaire vous demander ?

- A. Une échographie cervicale
- B. L'IDR a la tuberculine
- C. Une cytoponction ganglionnaire
- D. Une IRM du cavum
- E. Une angiographie du cavum

24- Quel examen complémentaire pratiquez-vous pour confirmer vitre diagnostic?

- A. Une laryngoscopie directe avec examen histologique
- B. Une cytoponction ganglionnaire
- C. Une biopsie du cavum avec examen histologique
- D. Une TDM cervicale
- E. Une IRM du cavum

25- Quel est le type histologique le plus souvent retrouvé chez votre patient ?

- A. Un carcinome bien différencié
- B. Un mélanome
- C. Un sarcome
- D. Un UCNT
- E. Un adénocarcinome

26- Une fois le diagnostic est fait chez votre patient, quel bilan demandez-vous systématiquement pour rechercher une localisation secondaire à distance ?

- A. Une TDM cervicale
- B. Une IRM cervicale
- C. Une scintigraphie osseuse
- D. Une angiographie du cavum
- E. Une TDM thoraco- abdominopelvienne

L'examen endoscopique retrouve une tumeur confirmée dans le cavum avec un bilan d'extension négatif chez votre patient

27- Comment classez-vous votre patient selon la classification TNM ?

- A. T2N0M0
- B. T2N1M0
- C. T3N1M0
- D. T1N1M0
- E. T1N1M1

28- Quelle serait votre conduite à tenir chez votre patient ?

- A. Une résection chirurgicale
- B. Une surveillance clinique et radiologique
- C. Une chimiothérapie exclusive
- D. Une radiothérapie exclusive
- E. Une radio-chimiothérapie concomitante

29- Quels sont les facteurs de risque de développer cette tumeur (RF) ?

- A. Facteur génétique
- B. Infection virale à EBV
- C. Une exposition prolongée au formaldéhyde
- D. Tabagisme
- E. Facteur alimentaire

30- La surveillance post-thérapeutique de votre patient se fait par ? [RF]

- A. Examen clinique du cavum tous les 3mois
- B. Un téléthorax tous les ans
- C. Sérologie EBV
- D. Une IRM
- E. Une laryngoscopie directe

Examen Maladies de systèmes Rattrapage/ 2025**1. Le syndrome de Hughes Stovin associe (choisissez la réponse juste):**

- A- Anévrisme rénale et pulmonaire
- B- Anévrisme pulmonaire et thrombose veineuse.
- C- Thrombose veineuse profonde et superficielle.
- D- Thrombose veineuse et embolie pulmonaire.
- E- Anévrisme coronaire et rénale.

2. L'atteinte neurologique au cours de la maladie de Behçet (choisissez les réponses justes):

- A. Est une manifestation grave.
- B. Peut être responsable de méningo-encéphalite.
- C. Ne concerne jamais les nerfs crâniens.
- D. La ponction lombaire est formellement contre-indiquée.
- E. Toutes les réponses sont justes.

3. Au cours de la maladie de Behçet, le test pathergique permet de (choisissez la réponse juste):

- A- Rechercher une réaction allergique.
- B- Détecter une forme viscérale grave.
- C- Évaluer l'hyperréactivité cutanée.
- D- Détecter une pustule bactérienne.
- E- Toutes les réponses sont justes.

4. Quelles situations justifient l'introduction précoce d'un anti-TNF alpha dans la maladie de Behçet ? (Choisissez les propositions justes):

- A- Une thrombophlébite veineuse superficielle isolée.
- B- Un anévrisme réfractaire de l'artère pulmonaire.
- C- Une méningite asymptomatique.
- D- Une uvéite postérieure récidivante menaçant la vision.
- E- Une aphtose bipolaire isolée.

5. Les facteurs prédictifs de lymphome au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren sont (choisissez les réponses justes):

- A- La présence d'un purpura vasculaire.
- B- L'atrophie des glandes salivaires principales.
- C- La présence de cryoglobulinémie.
- D- L'absence d'un composant monoclonal.
- E- L'absence de lymphopénie.

6. Dans le syndrome de Gougerot-Sjögren, on décrit (choisissez les réponses

- A- La forme primitive.
- B- Son association fréquente aux vascularites de gros calibres.
- C- Des formes secondaires aux maladies auto immunes
- D- Le risque de cancer solide
- E- Une atteinte articulaire érosive.

7. La biopsie des glandes salivaires accessoires (choisissez les réponses justes) :

- A- Est une technique facile à réaliser.
- B- Consiste à prélever au moins 4 glandes salivaires mineures au niveau de la face interne de la lèvre.
- C- Consiste à la recherche des agrégats de cellules inflammatoires mononucléaires > 50 cellules, qu'on appelle foyer ou focus.
- D- Son score repose sur la classification de Chisholm et Masson.
- E- Un score de III ou IV selon Chisholm et Mason (2 1 focus/ 4 mm) est retenu comme un critère du syndrome de Gougerot-Sjögren.

8. Au cours du syndrome de Sjögren, les manifestations extra-glandulaires peuvent être (choisissez les réponses justes) :

- A- Des arthrites destructrices.
- B- Une pneumopathie interstitielle diffuse.
- C- Une neuropathie périphérique.
- D- Un purpura vasculaire.
- E- Toutes les réponses sont justes.

9. La maladie de Gaucher de type 1 est caractérisée par (choisissez les réponses justes) :

- A- Asthénie.
- B- Syndrome cérébelleux.
- C- Pigmentation brun-jaune sur le visage et les tibias.
- D- Neuropathie périphérique.
- E- Encéphalopathie progressive.

10. Les Indications du traitement enzymatique substitutif dans la maladie de Gaucher sont (choisissez les réponses justes):

- A- Thrombopénie symptomatique ou taux de plaquettes ≤ 50 G/L.
- B- Anémie symptomatique et/ou taux d'hémoglobine ≤ 10 g/dL.
- C- Hépatomégalie et/ou splénomégalie.
- D- Atteinte osseuse cliniquement symptomatique.
- E- Atteinte osseuse radiologique à type d'infarctus, ostéonécrose ou fracture pathologique.

11. Concernant les atteintes neurologiques de la maladie de Fabry, choisissez la réponse fausse:

- A- Les AVC ischémiques sont fréquents.
- B- L'atteinte périphérique se manifeste par des acroparesthésies.
- C- La surdité est fréquente et liée à une atteinte cochléo-vestibulaire.
- D- La substance blanche n'est Jamais touchée.
- E- La dolichoectasie du tronc basilaire est une anomalie possible.

12. Concernant les atteintes osseuses de la maladie de Gaucher, choisissez la réponse fausse:

- A- La douleur osseuse est rare et toujours liée à un traumatisme majeur dans la maladie de Gaucher de type 1.
- B- La déformation en flacon d'Erlenmeyer est due à un trouble de remodelage et à l'infiltration osseuse.
- C- L'IRM est l'examen de choix pour évaluer l'extension et le suivi des lésions osseuses.
- D- Elles peuvent se compliquer d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale.
- E- Elles peuvent toucher aussi bien le rachis que les membres inférieurs.

13. Les signes cliniques rencontrés au cours d'une granulomatose systémique peuvent être (choisissez les réponses fausses) :

- A- Une poly adénopathie associée à une hépato-splénomégalie.
- B- Un érythème noueux.
- C- il n'existe jamais d'atteinte pulmonaire.
- D- Une fièvre prolongée inexpliquée.
- E- Il n'existe jamais d'atteinte oculaire.

14. Une granulomatose systémique d'origine non infectieuse peut être liée à (choisissez les réponses justes) :

- A- Une maladie de Whipple. ,
- B- Une silicose.
- C- Une listériose.
- D- Une berylliose
- E- Une tuberculose×

15. Toutes les anomalies biologiques suivantes sont présentes lors d'une granulomatose systémique sauf une, laquelle ?

- A- Une VS (vitesse de sédimentation) accélérée.
- B- Une hypocalcémie.
- C- Une hypercalciurie.
- D- Une cholestase intra-hépatique.
- E- Une hypergammaglobulinémie.

16. Parmi les causes suivantes de granulomatoses systémiques, lesquelles sont classées comme "primitives" ? (Choisissez les réponses justes):

- A- L'histiocytose langerhansienne.
- B- L'histoplasmose.
- C- La granulomatose avec polyangéite.
- D- La lymphadénite angio-immunoblastique.
- E- La brucellose.

17. Le syndrome catastrophique des anticorps anti-phospholipides CAPS (choisissez les réponses fausses) :

- A. Peut-être déclenché par une infection.
- B. Est caractérisé par la survenue simultanée de thromboses multiples typiques par leur prédominance microcirculatoire responsable d'une défaillance multiviscérale.
- C. Est une entité très fréquemment rencontrée chez les patients atteints de SAPL.
- D. N'engage jamais le pronostic vital du patient atteint de SAPL.
- E. Est une maladie à progression rapide.

18. Au cours du syndrome des anti-phospholipides ; le bilan immunologique peut montrer un (choisissez les réponses justes) :

- A. Un taux élevé d'anticoagulant circulant lupique (ou lupus anticoagulant LA).
- B. Un taux élevé d'anticorps anticardiolipine (aCL)
- C. Un taux élevé d'anticorps anti-B2 glycoprotéines I (B2GPI).
- D. Un taux de C1q bas.
- E. Un taux élevé d'anticorps anti membrane basale glomérulaire.

19. Parmi les manifestations cardiaques du SAPL, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse):

- A- Des végétations valvulaires.
- B- Une thrombose intracardiaque.
- C- Une dysfonction diastolique.
- D- Une Hypertension pulmonaire.
- Une endocardite bactérienne.

20. À propos de la grossesse au cours du SAPL, choisissez la proposition fausse :

- A- La mortalité fœtale peut atteindre 50% sans traitement.
- B. Le SAPL est responsable de 10 à 15 % des pertes embryonnaires répétées.
- C. La grossesse doit être évitée en cas de SAPL primaire.
- D. L'aspirine et les HBPM réduisent significativement les complications.
- E. Le SAPL peut être responsable de thrombose en post partum.

21. Un déficit Immunitaire peut être suspecté devant (choisissez la réponse fausse):

- A- Des Infections à répétition.
- B- Certaines pathologies non Infectieuses comme les granulomatoses systémiques de type « sarcoïdose-like ».
- C- Une neutropénie aiguë ($< 500/\text{mm}^3$) ou neutropénie chronique.
- D- Un taux de lymphocytes correct.
- E- Une histoire familiale de déficit Immunitaire.

22. Le Syndrome de Wiskott-Aldrich associe (choisissez les réponses Justes):

- A- Une réponse vaccinale conservée.
- B- Une prolifération lymphocytaire T altérée.
- C- Une thrombopénie avec des microplaquettes.
- D- Un taux de lymphocytes élevé.
- E- Des manifestations auto-Immunes.

23. A propos du déficit Immunitaire en IgA, choisissez les propositions Justes :

- A- Il se manifeste exclusivement par des Infections.
- B- Il peut être une forme du déficit immunitaire secondaire.
- C- Il peut être associé à une maladie cœliaque.
- D- Il peut parfois être en cause dans des accidents transfusionnels.
- E- Il peut se compléter par un déficit en IgG2 et IgG4.

24. Concernant la grossesse au cours du lupus érythémateux systémique (LES), choisissez les propositions Justes:

- A- La grossesse est formellement contre-indiquée au cours du LES.
- B- Une grossesse peut induire une poussée lupique.
- C- La présence d'Anti-Ro/SSA est associée à un risque accru de lupus néonatal.
- D- L'azathioprine est contre-Indiqué au cours de la grossesse pour éviter la toxicité fœtale.
- E- Les œstrogènes sont recommandés en cas de SAPL associé au LES au cours de la grossesse.

25. Concernant les signes cliniques du lupus érythémateux systémique (LES) (choisissez les réponses fausses) :

- A- L'alopécie lupique réversible est un signe dermatologique spécifique du LES.
- B- Le lupus subaigu peut-être induit par des médicaments.
- C- La panniculite lupique est une forme de lupus cutané chronique.
- D Le lupus discoïde est le plus fréquent des formes cutanées aiguës.
- E- Le lupus cutané aigu est caractérisé par un érythème malaire en aile de papillon.

26. Selon les critères de classification de l'ACR /EULAR 2019 du LES, Le diagnostic de lupus systémique est retenu lorsque le score (Choisissez la réponse juste) :

- A- Est supérieur à 6.
- B- Est supérieur à 7.
- C- Est supérieur à 8.
- D- Est supérieur à 10.
- E- Est supérieur à 20.

27. Selon les recommandations KDIGO 2024, la biopsie rénale au cours du LES est Indiquée devant (choisissez la réponse juste)

- A- Protéinurie des 24h $\geq 300\text{mg} / 24\text{h}$
- B- Le rapport protéine/créatinine urinaire $\geq 1000 \text{ mg/g}$.
- C- Protéinurie des 24h $2 300\text{mg}$ et $\leq 500 \text{ mg}/24\text{h}$.
- D- Protéinurie des 24h $\geq 500 \text{ mg}/24\text{h}$ et Le rapport protéine/créatinine urinaire $\geq 500 \text{ mg/g}$.
- E- Clairance de la créatinine sanguine $\leq 60\text{ml}/\text{mn}$.

28. Concernant les manifestations cardiaques au cours du LES, choisissez les propositions Justes:

- A- La péricardite est l'atteinte cardiaque la plus fréquente.
- B- L'endocardite de Libman-Sacks touche préférentiellement la valve aortique.
- C- La myocardite lupique est fréquente ($>20\%$).
- D- Un bloc cardiaque congénital peut se développer chez le nouveau-né dont la mère a des anticorps anti Ro.
- E- Toutes les propositions sont Justes.

29. Quel signe est le plus évocateur d'une atteinte cardiaque dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse juste) :

- A- La tachycardie sinusale.
- B- L'hypotrophie du VG.
- C- L'angor avec obstruction athéromateuse des coronaires.
- D- L'épanchement péricardique abondant.
- E- L'épaississement pariétal granuleux à l'échocardiographie.

30. Concernant la physiopathologie de l'amylose, choisissez les réponses Justes :

- A- Il s'agit d'une maladie du repliement protéique.
- B- Les dépôts amyloïdes se forment exclusivement dans l'espace Intracellulaire.
- C- Elle peut être acquise ou héréditaire.
- D- Les protéines amyloïdes possèdent une structure en feuillet alpha.
- E- Les dépôts amyloïdes sont inaccessibles à la protéolyse physiologique cellulaire.

31. Quels sont les acteurs principaux intervenant dans la physiopathologie de la sclérodermie systémique ? (Choisissez les propositions Justes):

- A- La cellule musculaire striée.
- B- La cellule endothéliale.
- C- Le lymphocyte B.
- D- Le fibroblaste.
- E- Le kératinocyte.

32. Quels sont les facteurs prédictifs de la survenue de la crise rénale sclérodermique? (Choisissez les réponses fausses) :

- A- La forme cutanée diffuse.
- B- Prise de corticothérapie à 25 mg/J.
- C- Après 5 ans d'évolution.
- D- Présence d'AC anti ARN polymérase III.
- E- Présence d'AC anti topoisomérase I.

33. Concernant la capillaroscopie périunguéeale dans la sclérodermie systémique, choisissez les réponses Justes:

- A- Elle n'est positive qu'à un stade tardif de la maladie.
- B- La raréfaction capillaire se voit exclusivement au cours de la sclérodermie systémique.
- C- Elle fait partie des critères de classification ACR/EULAR 2013.
- D- Elle peut montrer des mégacapillaires.
- E- Toutes les réponses sont justes.

34. Concernant l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) au cours de la sclérodermie systémique, choisissez les propositions fausses:

- A- Son diagnostic de certitude repose sur l'IRM cardiaque.
- B- Elle doit être dépistée annuellement.
- C- Elle est suspectée si la pression artérielle pulmonaire (PAP) moyenne est Inférieure à 15 mmHg au repos.
- D- L'identification d'une HTAP ne précède jamais le diagnostic de la sclérodermie systémique.
- E- Elle peut se manifester par un souffle systolique d'Insuffisance tricuspидienne.

35. Une femme de 56 ans présente une dermatomyosite, quels sont les autoanticorps spécifiques des myosites les plus fortement associés à une pneumopathie interstitielle (choisissez les réponses justes) :

- A- Anti MI2.
- B- Anti J01.
- C- Anti MDAS.
- D- Anti SRP.
- E- Anti NXP2.

36. Au cours des myopathies inflammatoires ; l'IRM musculaire (choisissez les réponses justes

- A- Exclut le diagnostic si elle est normale.
- B- Montre un hyposignal des zones inflammatoires en séquence en suppression de graisse (T2 STIR)
- C- Permet de guider les biopsies.
- D- Permet l'évaluation de la réponse thérapeutique.
- E- Confirme l'activité de la myosite.

37. Les myosites inflammatoires associées aux anticorps anti-MDA 5 sont caractérisées par (choisissez les réponses justes) :

- A- Une atteinte musculaire obligatoire.
- B- Une atteinte respiratoire rapidement progressive.
- C- Une atteinte cutanée à type de calcifications.
- D- Une atteinte articulaire.
- E- Toutes les réponses sont justes.

38. Quel élément est caractéristique d'une myosite nécrosante auto-Immune (MNAI), choisissez la réponse juste :

- A- L'évolution de la maladie est lentement progressive.
- B- La présence fréquente d'anticorps anti-SRP ou anti-HMGCR.
- C- Le taux des CK est peu élevé (< 500 UI/L).
- D- L'histologie retrouve un important infiltrat inflammatoire dense.
- E- Toutes les réponses sont justes.

39. Le syndrome pneumo-rénal au cours des vascularites systémiques se caractérise par (choisissez les réponses justes) :

- A- La présence d'une atteinte pulmonaire type asthme bronchique.
- B- La présence d'une atteinte rénale type syndrome néphrotique pur.
- C- La présence obligatoire des anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA).
- D- Une fréquence faible mais un pronostic sombre.
- E- La présence de croissants glomérulaires à l'histologie rénale.

40. Concernant l'artérite à cellules géantes, choisissez les réponses fausses :

- A- Elle peut provoquer une cécité brutale si elle n'est pas traitée rapidement.
- B- Elle touche plus fréquemment les femmes surtout âgées de plus de 50 ans.
- C- L'imagerie par PET-scan n'a aucune utilité au diagnostic en cas d'atteinte des gros vaisseaux.
- D- La biopsie de l'artère temporale est l'examen de référence pour le diagnostic.
- E- Elle peut s'associer à une pseudopolyarthrite rhizomélique.

41. Le syndrome de Cogan est caractérisé par (choisissez les réponses justes):

- A- Une aortite possible.
- B- Une fréquence rare.
- C- Un vertige.
- D- Une évolution lente favorable.
- E- Toutes les réponses sont justes.

42. A propos de la granulomatose avec polyangéite (GPA), choisissez les réponses fausses :

- A- Elle se manifeste par une glomérulonéphrite pauci-immune, nécrosante et segmentaire.
- B- Elle se manifeste par un écoulement nasal purulent ou sanglant.
- C- Elle atteint surtout les vaisseaux de gros calibre.
- D- Elle se manifeste par un syndrome pneumo-rénal.
- E- Elle se manifeste par des lésions de vascularite coronaire.

43. A propos de l'atteinte rénale au cours des vascularites systémiques, choisissez les propositions justes :

- A- L'HTA réno-vasculaire est toujours présente.
- B- L'atteinte microvasculaire glomérulaire peut se manifester par un syndrome néphrotique.
- C- La détection des ANCA et les anticorps anti-MBG peut orienter l'étiologie.
- D- La glomérulonéphrite rapidement progressive peut se manifester par des croissants glomérulaires.
- E- Toutes les propositions sont justes.

44. A propos des vascularites cryoglobulinémiques, choisissez les propositions fausses :

- A- Elles se manifestent par un purpura vasculaire.
- B- Elles s'associent souvent à l'hépatite B.
- C- Elles se manifestent par une hypertension artérielle rénovasculaire.
- D- Elles se manifestent par une neuropathie périphérique.
- E- L'atteinte rénale est exclusivement glomérulaire pauci-immune.

45. Chez l'enfant, la vascularite à IgA ou Purpura Rhumatoïde (PR) (choisissez les réponses justes) :

- A- Est une vascularite touchant les vaisseaux de gros calibre.
- B- Se manifeste par un purpura vasculaire, symétrique, palpable, déclive, membres inférieurs.
- C- Ne donne jamais d'atteinte digestive.
- D- Responsable d'arthralgies ou d'arthrites précédant parfois l'atteinte cutanée.
- E- Toutes les réponses sont justes.

46. À propos de la maladie de Kawasaki, choisissez les réponses justes :

- A- Elle touche préférentiellement les enfants de plus de 10 ans.
- B- La conjonctivite de la maladie de Kawasaki est bilatérale et purulente.
- C- L'atteinte cardiaque détermine la gravité de la maladie.
- D- L'éruption cutanée de type exanthème non vésiculeux est spécifique de la maladie.
- E- Les immunoglobulines sont le traitement de première intention.

47. Un garçon âgé de 08 ans présente des épisodes fébriles récurrents, durant 2 à 3 jours, associés à des douleurs abdominales et des myalgies sans autres signes. Sa CRP est élevée en crise. Choisissez les propositions justes :

- A- Le syndrome PFAPA est le diagnostic le plus probable.
- B- L'évolution se fait vers la guérison spontanée sans laisser de séquelles.
- C- La fièvre méditerranéenne familiale est une cause possible.
- D- La complication la plus redoutée est l'amylose AA.
- E- Le traitement de fond repose sur la colchicine.

48. Concernant les particularités des maladies auto-immunes pédiatriques, choisissez les réponses fausses :

- A- Elles peuvent être la seule manifestation du déficit immunitaire.
- B- Elles peuvent retentir sur la croissance staturo-pondérale.
- C- Le lupus monogénique est lié à un déficit en complément ou à une production excessive d'INF alpha.
- D- Les maladies auto-immunes sont plus fréquentes en pédiatrie.
- E- Le lupus monogénique est très sensible aux corticoïdes.

49. Quel traitement, est obligatoirement associé avec le méthotrexate ? (choisissez la réponse juste) :

- A- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- B- Les antalgiques.
- C- L'acide folique.
- D- Les corticoïdes.
- E- Un antihistaminique.

50. Concernant le cyclophosphamide, choisissez les réponses justes :

- A- Il est contre-indiqué pendant la grossesse.
- B- Son effet est cycle-Indépendant, Il agit sur les cellules en phase G0.
- C- Il expose à un risque de cystite hémorragique.
- D- Il est principalement utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde bénigne.
- E- Il nécessite une bonne hydratation avant et après perfusion.